

Fachsprachprüfung (FSP) Karlsruhe

Bezirksärztekammer Nordbaden = Wohnort im [Regierungsbezirk Karlsruhe](#)

Telegram-Gruppe: <https://t.me/fspbadenwuttemberg>

Spende (Donations): <https://www.buymeacoffee.com/approbation>

Index

- [Fachsprachprüfung \(FSP\) Karlsruhe](#)
- [Index](#)
 - [xx.02.2025 Karlsruhe](#)
 - [xx.02.2025 Ösophaguskarzinom](#)
 - [30.01.2025 Abszess am Gesäß](#)
 - [27.01.2025 Kolonkarzinom](#)
 - [13.01.2025 Pneumonie](#)
 - [15.01.2025 Migräne](#)
 - [5.12.2024 Myokardinfarkt](#)
 - [5.12.2024 Appendizitis](#)
 - [5.12.2024 Coxarthrose](#)
 - [2.11.2024 Gichtanfall](#)
 - [2.11.2024](#)
 - [28.11.2024 Influenza](#)
 - [26.11.2024 Laktoseintoleranz](#)
 - [07.11.2024 Diabetes Typ 1](#)
 - [09.11.2024 obere gastrointestinale Blutung \(Ulcus ventriculi\)](#)
 - [07.11.2024 Diabetes Typ 1](#)
 - [29.10.2024 Angina pectoris](#)
 - [30.10.2024 Appendizitis](#)
 - [28.10.2024 gastroösophageale Refluxkrankheit](#)
 - [24.10.2024 Anorexia nervosa](#)
 - [20.09.2024 Abszess am Gesäß](#)
 - [16.08.2024 ösophaguskarzinom](#)
 - [08.08.2024 Kolonkarzinom](#)
 - [23.07.2024 Stabile Angina](#)
 - [15.07.2024 Multiple Sklerose](#)
 - [15.07.2024 Pertussis](#)
 - [15.07.2024 DM I](#)
 - [02.07.2024 DM I](#)
 - [30.06.2024 Sprunggelenkfraktur](#)
 - [26.06.2024 KHK](#)
 - [26.06.2024 Sprunggelenk Distorsion](#)
 - [24.06.2024 Obstruktive Schlafapnoe Syndrom](#)

- 18.06.2024 Polymyalgia Rheumatica,
- 17.06.2024 Rheumatisches Fieber und TVT
- 11.06.2024 Obere gastrointestinale Blutung Bei Ulkuskrankheit
- 10.06.2024 Oberschenkelfraktur
- 10.06.2024 Divertikulose
- 04.06.2024 Pyelonephritis
- 04.06.2024 Pneumonie
- 14.05.2024 zervikaler Bandscheibenvorfall
- 14.05.2024 Abszess am Gesäß
- 13.05.2024 Zöliakie
- 07.05.2024 Leberzirrhose
- 07.05.2024 Cholezystolithiasis
- 07.05.2024 Leberzirrhose
- 06.05.2024 pAVK
- 02.05.2024 zervikaler Diskusprolaps
- 02.05.2024 Kolonkarzinom
- 30.04.2024 Refluxkrankheit
- 18.04.2024 obere intestinale Blutung
- 16.04.2024 Osteoporose
- 16.04.2024 akute Pankreatitis
- 15.04.2024 Depression
- 08.04.2024 Divertikulitis
- 08.04.2024 Ösophaguskarzinom
- 04.04.2024 obere gastrointestinale Blutung
- 04.04.2024 Angina pectoris
- 26.03.2024 Divertikulitis
- 26.03.2024 PAVK
- 16.03.2024 Anorexia nervosa
- 16.03.2024 Diabetes Mellitus Typ 1
- 14.03.2024 Cholezystolithiasis
- 12.03.2024 Kolonkarzinom
- 29.02.2024 zervikaler Diskusprolaps
- 22.02.2024 obere gastrointestinale Blutung
- 15.02.2024 Ulcus ventriculi
- 15.02.2024 Polymyalgia rheumatica
- 12.02.2024 Laktoseintoleranz
- 12.02.2024 Depression
- 00.02.2024 Leberzirrhose
- 00.02.2024
- 00.02.2024 Gonarthrose
- 08.02.2024 Migräne
- 08.02.2024 metabolisches Syndrom
- 08.02.2024 Migräne
- 25.01.2024 Oberschenkelhalsfraktur
- 23.01.2024 rheumatisches Fieber
- 23.01.2024 Ösophaguskarzinom

- 09.01.2024 Kolonkarzinom
- 18.12.2023 Divertikulitis
- In der Medikamentenanamnese zeigten sich:
- 21.11.2023 Coxarthrose
- 16.11.2023 Oberschenkelhalsfraktur
- 14.11.2023 metabolisches Syndrom
- 09.11.2023 Pertusis
- 23.10.2023 Ösophaguskarzinom
- 23.10.2023 Osteoporose
- 18.09.2023 Ösophaguskarzinom
- 00.09.2023
- 04.09.2023 Ösophaguskarzinom
- 04.09.2023 Kolonkarzinom
- 01.08.2023 Depression
- 19.09.2023 Migräne
- 31.08.2023 Gicht
- 31.08.2023
- 29.08.2023 pAVK
- 28.08.2023 Borreliose
- 24.08.2023 Abzess
- 21.08.2023 Sprunggelenkfraktur
- 21.08.2023 akute Pankreatitis
- 03.08.2023 osteoporotische Fraktur
- 27.07.2023 Anorexia nervosa (2x)
- 20.07.2023 Divertikulitis
- 18.07.2023 tiefe Venenthrombose (TVT)
- 18.07.2023 tiefe Venenthrombose (TVT)-1
- 17.07.2023 rheumatisches Fieber
- 13.07.2023 akute Pankreatitis
- 10.07.2023 pAVK Stadium 2 b
- 06.07.2023 Alzheimerkrankheit
- 06.07.2023 Alzheimerkrankheit-1
- 03.07.2023 Diabetes mellitus Typ I
- 15.06.2023 Angina pectoris (2x)
- 07.06.2023 Ulcus ventriculi
- 00.06.2023 Pneumonie
- 07.06.2023 Zöliakie
- 05.06.2023 Diskusprolaps
- 01.06.2023 rheumatisches Fieber
- 00.06.2023 Pneumonie
- 08.05.2023 Colon irritabile
- 08.05.2023 Depression
- 04.05.2023 Appendizitis
- 04.05.2023 Migräne
- 26.04.2023 Divertikulitis
- 26.04.2023 Pyelonephritis

- 25.04.2023 Laktoseintoleranz
- 25.04.2023 Appendizitis (2x)
- 19.04.2023 Sprunggelenkfraktur
- 17.04.2023 obere intestinale Blutung
- 17.04.2023 akute Pankreatitis
- 06.04.2023 periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- 27.03.2023 Obere gastrointestinal Blutung
- 27.03.2023 Rheumatisches Fieber (2x)
- 18.01.2023 Appendizitis
- 18.01.2023 Pneumonie
- 30.01.2023 Sprunggelenksfraktur
- 08.02.2023 obere gastrointestinale Blutung
- 08.02.2023 Hüftkopfnekrose
- 09.02.2023 rheumatisches Fieber
- 00.02.2023 Migräne
- 16.02.2023 Appendizitis (2x)
- 16.02.2023 Angina pectoris
- 16.02.2023 Appendizitis
- 23.02.2023 Abszess am Gesäß
- 13.03.2023 Deppresion
- 13.03.2023 Appendizitis
- 00.03.2023 Depression
- 06.03.2023 Depression
- 06.03.2023 Angina pectoris
- 08.03.2023 Lyme-Borreliose
- 08.03.2023 Lyme-Borreliose-1
- 09.03.2023 Multiple Sklerose
- 09.03.2023 Osteoporose
- 16.03.2023 zervikaler Diskusprolaps
- 20.03.2023 Gastroenteritis
- 09.06.2022 Hyperurikämie (Gicht)
- 22.07.2022 Zöliakie
- 26.07.2022 Depression
- 30.07.2022 Ösophaguskarzinom
- 18.08.2022 Pyelonephritis
- 18.08.2022 Pyelonephritis
- 15.12.2022 Ösophaguskarzinom
- 15.12.2022 Appendizitis
- 15.12.2022 Grippe
- 26.01.2022 Wirbelfraktur aufgrund einer Osteoporose
- 03.02.2022 Laktoseintoleranz
- 08.11.2021 Depression
- 17.09.2020 Gichtanfall
- 24.06.2020 Oberschenkelhalsfraktur
- 06.02.2020 Depression
- 29.01.2020 Depression

- [Fachbegriffe Karlsruhe](#)
 - ["Spaced Repetition" für die FSP](#)
 - [Literatur für die FSP](#)
 - [Podcasts für die FSP](#)
 - [Feedback und Diskussion](#)
-

xx.02.2025 Karlsruhe

Patient ist Herr Kowalski, 51 Jahre alt. Er kam wegen Bluterbrechen, Teerstuhl, Oberbauchschmerzen, Schwäche und Schwitzen.

Vorerkrankung: arterielle Hypertonie, behandelt mit Captopril. Medikamente: Metiprednisolon und Voltaren (also Steroide + NSAR – Meine Verdachtsdiagnose war: obere GI-Blutung, wahrscheinlich ulkusbedingt. DD: Ulkus ventriculi/duodeni, erosive Gastritis, Ösophagusvarizen, Mallory-Weiss, Tumor, Arzt-Arzt gespräch Sie haben nach Diagnostische und Therapeutischemaßnahmen gefragt .

Die fachbegriffe waren alles von Anki app.

xx.02.2025 Ösophaguskarzinom

Mein Fall war ein Ösophaguskarzinom, genau wie im Protokoll. Das Prüfungskomitee war sehr nett und freundlich. Sie haben von Anfang an gesagt, dass sie uns helfen werden, die Prüfung zu bestehen. Vor der eigentlichen Prüfung haben sie ein paar persönliche Fragen gestellt (z. B. woher ich komme, in welche Fachrichtung ich gehen möchte usw.). Zwei andere Prüflinge haben die Prüfung ebenfalls bestanden – ihre Fälle waren Pertussis.

Es ist wichtig, die Dokumentation vollständig bis zum Ende zu schreiben. Sie haben mir gesagt, dass es Minuspunkte gibt, wenn diagnostische Maßnahmen und Therapie nicht aufgeführt sind, selbst wenn es nur ein oder zwei Stichpunkte sind (einfach schreib etwas).

Der AAG-Teil lief super – nur typische Fragen und eine Aufklärung zur Endoskopie.

Die Fachbegriffe waren all in Anki (Subdural Blutung, Anatomie, Ösophagus, Tibia, usw.)

30.01.2025 Abszess am Gesäß

Der Fall war Abszess am Gesäß, genau so wie im Protokoll.

Die Kommission war ganz nett und freundlich.

Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat mir so viele Fragen bezüglich meine Erfahrung gestellt , weil ich auch Allgemeinmediziner bin . Aber sie waren ganz leicht.

AAG:

Kurz Patientenvorstellung

Was ist Verdachtsdiagnose ! Welche DD gibt es hier !

Weiteres Vorgehen bezüglich Diagnostik und Therapie?

Muss der Pat im Krankenhaus bleiben ? Ja ..

Der patient fragt , so das ist der schuld des Arztes?

Reaktion? Wir können das nicht genau Sagen , aber ihre Beschwerde konnte viele Ursachen haben , er ist Diabetiker.

Der facharzt , wenn du diesen Patienten behandeln würdest ! Gibst du ihm Spritze ?

Wir geben ihm keine Spritze , aber wir können anderes Schmerzmittel verschreiben . ZB IBuprofen 3 mal täglich, denn er nimmt schon Paracetamol ein, aber keine Besserung damit.

Bei Diagnostik hier ist Sonar wichtig , Sie wollen das hören.

Er hat allergeie gegen Penicillin, deswegen bei Antibiotika (cetriaxone)

Fachbegriffe waren allen Aus Anki außer Hämoglobin (Rotfarbe Blutstoff)

Dank An Linux , Marko, Oussama und an allen anderen Kollegen, die Protokolle geteilt haben

27.01.2025 Kolonkarzinom

Hallo, ich habe heute die Prüfung in Karlsruhe bestanden. Die Prüfer waren sehr nett aber zwei von denen hatten ein bisschen Akzent 😊. Der Fall war Kolonkarzinom.

Der Patient ist 60J, 179cm und 72kg. Er hat seit 3 Monaten bestehende langsam auftretende diffuse Bauchschmerzen mit Verstopfung. Die Schmerzen treten mit der Verstopfung auf und nach dem Stuhlgang werden die Schmerzen gelindert. Er hat das Essen geändert, aber es hat nicht geholfen. Gegen Verstopfung hat er Abführmittel genommen. Sein Stuhl ist dünner als sonst. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Er hat 1kg abgenommen. Er hat keine Allergien, keine Vorerkrankungen, keine Operationen.

Er raucht nicht, trinkt gelegentlich Alkohol und hat Drogen nicht probiert.

Er ist verheiratet und hat ein Sohn oder eine Tochter. Er ist Büroarbeiter. Sein Vater leidet an Kolonskarzinom und seine Mutter und Schwester sind gesund. A-A Gespräch: keine Patientenvorstellung aber nur Fragen über Ausschluss der DD. Die goldstandard der Kolonkarzinom? Aufklärung der Koloskopie. Und Wie weit sollte die Koloskop vorgeschoben werden? (das kenne ich nicht 😊.) Die Tumormarker? Und wenn Tumormarker erhöht nicht, kann man die Karzinom ausschließen?

Die Fachbegriffe sind wie Anki.

13.01.2025 Pneumonie

Pneumonie – fast wie im Protokoll.

Ulrich Mais, 59 Jahre / Hauptbeschwerde: Fieber, Schüttelfrost seit 3 Tagen und quälender Husten seit 1 Woche („Ich huste immer“) mit gelbem Auswurf. Keine Auslöser, Verstärkungs- oder Linderungsfaktoren sowie Abhängigkeit. Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde bejaht (Patient: „Ja, habe so mehrmals gehabt aber nicht so stark“). Damals wurde er mit „dicker Erkältung“ diagnostiziert. Die Einnahme von ACC und Paracodein-Tropfen hat eine kleine Verbesserung gebracht, besonders beim Schlafen („Ich schlafe besser mit diesen Tropfen“).

Begleitsymptome: Antriebslosigkeit, Fatigue. Die Fragen nach Thoraxschmerzen, Dyspnoe, Anosmie, Ageusie, Tachykardie, Palpitationen, Hämoptoe und ähnliche Beschwerden in der Umgebung wurden verneint.

Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Inappetenz und Insomnie, die sich mit der Einnahme von Paracodein-Tropfen verbessert hätte. • Vorerkrankungen: aH, DM. Der Patient leide zurzeit an einem Prostatakarzinom, das mit Strahlentherapie behandelt sei wurde (Empathie zeigen). • Medikamente: Ramipril, Metformin, HCT. • Allergie: Penicillin (Exanthem). • Rauchen/Alkohol/Drogen: Verneint.

Reaktionen: Patient: „Was habe ich? Wie könnten Sie eine Lungenentzündung bestätigen?“ (Labor und Röntgen). „Ich rauche nicht und trinke nicht, und Sie fragen nach Drogen? Natürlich nein.“ Antwort: „Ja, Herr Mais, das habe ich mir schon gedacht, aber ich muss Sie fragen, um sicherzugehen.“ muss ich hier bleiben?

AA: Ich habe den Patienten präsentiert bis zu den Medikamenten. Danach wurde ich direkt nach der Diagnose gefragt: „Was ist besonders bei diesem Patienten?“ (Antwort: Strahlentherapie und DM = Immunsuppression). „Wie können wir die Sauerstoffsättigung messen?“ (Antwort: Fingerpulsoxymeter und BGA). „Werden Sie den Patienten stationär aufnehmen?“ (Antwort: „Ja, natürlich, wegen der Immunsuppression.“). Der Chefarzt hat mir gesagt, dass dieser Patient intensiv aufgenommen werden sollte. Was finden Sie im Röntgen? (Infiltration / bronchiektasie) Was erwarten Sie vom Labor? (Leukozytose / Crp erhöht)

Sputum kultur ist auch sehr wichtig mich Antibiotogramm

Fachbegriffe: Inoperabilität (Unmöglichkeit, eine OP durchzuführen).

Die Kommission war nett, besonders die Ärzte. Sprache und Selbstbewusstsein sind am wichtigsten.

Viel Glück an alle!

15.01.2025 Migräne

Mein Fall war Migräne, fast wie im Protokoll, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, und zwar Schmerzen linksseitig, ohne Auslöser, ohne Ausstrahlung. Während Arzt-Arzt-Gespräch wurde nach Differentialdiagnosen und Therapie gefragt. Und auch wurde gefragt ob der Patient raucht + SA und FA. Keine Aufklärungen.

Der Patient hat sehr deutlich und ziemlich langsam gesprochen!

Fachbegriffe (12): auricular, paraneoplastisch, Asystolie, Aszitis, Brachialgie, Capitulum... usw. Wie in Anki.

Die Kommission war nett! Sie versuchen den Prüfling von Anfang an zu beruhigen und eine angenehme Atmosphäre während der Prüfung zu schaffen. Und es hilft sehr!

Ich möchte mich für die Protokolle und alle anderen Unterlagen wie Anki, Begriffsliste usw. bedanken! Das war sehr hilfreich!

Ich wünsche allen viel Erfolg! ✨

5.12.2024 Myokardinfarkt

08.01.2025, Karlsruhe: Prüfung bestanden! Thema: Myokardinfarkt. Fallvorstellung und therapeutische Maßnahmen wurden erfolgreich erklärt. Fachbegriffe wie in Anki genutzt. Viel Erfolg an alle, die noch vor ihrer

Prüfung stehen! Ein anderer Kandidat hatte denselben Fall, aber leider nicht bestanden.

5.12.2024 Appendizitis

Fachbegriff Tic , osteosynthese , Cerumen , Schlafapnoe , präfinal , Singultus, pertusis , Koagulation , Inzision , Rabies, Hemianopsie , exsikiert.

5.12.2024 Coxarthrose

Ich hatte viel Stress und konnte mich nicht beruhigen. Die Prüfer waren jedoch sehr nett und haben mich beruhigt. Der Richter betonte, dass es sich nur um eine Sprachprüfung handelt und nicht um fachliche Kenntnisse. Trotzdem denke ich, dass die Ärzte dort auch ein bisschen auf das Fachwissen achten.

Der Richter hat auch darauf hingewiesen, dass für jeden Teil des Briefes etwas geschrieben werden muss und bitte DD , Diagnostik und Therapie nicht auslassen

Ich schätze, dass eine gute Selbstvorstellung sehr wichtig ist und einen positiven Eindruck hinterlässt.

In Bezug auf Fachbegriffe kamen unter anderem "intermittierend" und "Poliomyelitis" vor.

2.11.2024 Gichtanfall

Gestern habe ich die FSP in Karlsruhe bestanden. Mein Fall war Gichtanfall, wie im Protokoll. Die Prüfer waren freundlich, die Atmosphäre angenehm und die Prüfung verlief recht einfach. Fachbegriffe : monoarthritis , urtikaria , vena cava inferior , urosepsis , orbital , glandula , intima , ...

2.11.2024

Hallo in die Runde, ich habe gestern und zwar 2.11 die FSP in Karlsruhe abgelegt und bestanden) 🥳 Das war, aber meiner zweite Versuch. Das erste Mal war in Reutlingen, der Fall war eine allergische Reaktion gegen Wespenstich! Ich war nicht dazu bereit, weil ich das nicht vorbereitet habe. Sogar hörte ich darüber nicht. Gestern war zervikale Diskusprolaps. Alles wie im Protokoll, die Begriffe waren alle aus Anki! ☐☐ Die Kommission war aus 3 "erwachsene" angenehme Männer, die haben alles deutlich und langsam alles gesprochen. Das ist ziemlich machbar. Viel Erfolg an alle!

28.11.2024 Influenza

Herr Mais Klaus, ein 58 Jahre alt Patient stellte sich mit seit 3 Tagen plötzlich mit Fieber 40 grad, seit 5 Tagen Husten mit Auswurf als gelblich und grünlich beschreiben und mit Schüttelfrost begleitend und Belastungsabhängige Dyspnoe vor.

Gegen Fieber Ibuprofen 600mg bei Bedarf eingenommen und ACC 600 um Husten zu lindern und Codein tropfen, weil er unter Schlafstörung aufgrund Husten klagte. Appetitverminderung seit beginn der Beschwerden.

Z.n Prostata Karzinom seit 1 Jahr, mit Strahlungstherapie z.n Diabetes typ2 mit Metformin 1-0-0 dosis unbekannt z.n arterielle Hypertonie mit Ramipril 5mg 1-0-1/2 und HCT 1-0-0

Penizillin allergie seit 5 Jahre bekannt äußert sich durch Hautausschlag DD Pneumonie, Bronchitis, Covid 19 Diagnostische Maßnahmen KU, BB, CRP, BSG, Auswurf für Erregernachweis und Resistenztests zu bestimmen. Röntgenaufnahme

Therapie: Statoraufnahme, Antibiotikum (Azithromizin, Clarithromicin aufgrund Penizillinallergie), Sauerstoff bei Bedarf, Symptomatische Behandlung.

Fachbegriffe wie beim Protokoll. Kommission waren sehr nett.

26.11.2024 Laktoseintoleranz

Guten Tag, Ich habe die FSP in Karlsruhe am 26.11 abgelegt. Mein Fall war Laktoseintoleranz wie Protokoll. Fragen von der Kommission:

- Aufklärung dem Patienten über Pathophysiologie
- H2 Atem Test Aufklärung Anderer Fall ist eine Depression Danke an alle die Ihren Protokollen geschrieben haben und viel Erfolg für die Andere.

07.11.2024 Diabetes Typ 1

Hallo zusammen, ich habe gestern 7.11.2024 meine Prüfung in Karlsruhe erfolgreich bestanden. Der Fall, den ich vorgestellt habe, betraf einen Patienten mit Diabetes Typ 1. Die Prüfungskommission bestand aus einem Juristen, einem Oberarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und einem Oberarzt der Allgemeinchirurgie. Einstiegsgespräch: Zu Beginn wurde ich nach meinem Lebenslauf gefragt – welche Fachrichtung ich anstrebe und was ich seit meinem Abschluss gemacht habe.

Anamnesegepräg: Der Patient sprach langsam und deutlich und gab mir gleich zu Beginn alle wichtigen Informationen. Herr Franz Maier ist 24 Jahre alt, wiegt 65 kg und ist 178 cm groß. Er stellte sich bei uns aufgrund von seit drei Monaten bestehender Müdigkeit vor. Die Beschwerden seien plötzlich aufgetreten und hätten sich im Verlauf verschlimmert. Begleitsymptome: Polydipsie und Polyurie. Auf meine Fragen hin verneinte der Patient Sehstörungen, Polyphagie, Parästhesien, Kältegefühl, Bradykardie, Dysurie, Hautblässe und Tachykardie. In der Vorgeschichte erwähnte der Patient eine Insomnie. Er hat keine relevanten Vorerkrankungen und nimmt zurzeit keine Medikamente ein. In der Vergangenheit erlitt er einen Ellenbogenbruch rechts, der konservativ mit einem Gipsverband behandelt wurde. Zudem leidet er an einer Pollenallergie und reagiert darauf mit Halsödemen. Der Patient raucht eine Zigarette pro Woche und trinkt ein Glas Wein pro Woche; Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab: Der Vater verstarb an einem Myokardinfarkt, die Mutter leidet an Diabetes Typ 2. Er hat zwei Geschwister, die gesund sind. Sozialanamnese: Er ist ledig, kinderlos und studiert. Er treibt keinen Sport. Der Impfstatus ist vollständig, und es gab keine auffälligen Reiseanamnese. Verdachtsdiagnose: Diabetes Typ 1 Differentialdiagnosen: Hypothyreose, Anämie und Zystitis.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

Körperliche Untersuchung

Labordiagnostik: Blutbild, CRP, Elektrolyte, Nüchternblutzucker, HbA1c, Urinstatus, TSH, fT3, fT4, Anti-GAD-Antikörper, Anti-IA2, Anti-Insulin und C-Peptid

Therapieansatz: Körperliche Aktivität fördern Ernährungsumstellung Langzeit-Insulintherapie

Dokumentation: 20 Minuten, das war für mich ausreichend.

Arzt-Arzt-Gespräch:

Vorstellung bis hin zu den Medikamenten

Welche Differenzialdiagnose?

Diabetes insipidus?

Wie gehen Sie vor?

Erklären Sie die Erkrankung und die Untersuchung bis hin zur Behandlung für den Patienten.

Patientengespräch:

Patient: „Warum habe ich Diabetes Typ 1?“ Ich habe erklärt, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert und so weiter...

Patient: „Wie viel muss ich spritzen?“ Ich habe gesagt, dass ich es momentan nicht genau sagen kann; es hängt von den Zuckerwerten ab. Er wollte aber wissen, ob es Alternativen wie Insulinpumpen gibt, und ich habe ihm das erklärt.

Patient: „Gibt es andere Alternativen, falls ich kein Insulin mehr spritzen möchte?“ Ich habe gesagt, dass es, soweit ich weiß, Operationen gibt, wie z. B. eine Verpflanzung von Insulinzellen, aber ich wusste den genauen Namen der OP nicht. Er sagte dann: „Ja, richtig: Pankreas-Transplantation.“ Insgesamt war das Gespräch sehr angenehm und ohne Stress. Man muss sich gut vorbereiten, viele Simulationen machen und auch das Hörverstehen üben.

Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass meine Erfahrung für euch hilfreich ist. Ich habe selbst viel aus den öffentlichen Erfahrungen gelernt und möchte auch meine ausführlich teilen.

Hallo Leute (06.11.24) Gestern habe ich die Prüfung abgelegt und Gott sei Dank habe ich bestanden. Mein Fall war Akute Divertikulitis wie im Protokoll. Fachbegriffe: Anki

Heute habe ich FSP abgelegt. (05.11.24) Der Fall war obere gastrointestinale Blutung und wurde wie Protokoll Die Kommission war sehr respektvoll. Das Gespräch mit dem Chef Arzt über die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten und so weiter Und einige Reaktionen. Bezüglich der Fachbegriffe gibt es nichts Neues. Gott sei Dank habe ich bestanden. Ich wünsche allen viel Erfolg 🙏

Hallo! 🦋 Mein Fall gestern war KHK. (29.10.24)

09.11.2024 obere gastrointestinale Blutung (Ulcus ventriculi)

Manfred Kaiser-Schmitt 67jähriger Patient geboren an 13.03.1957 1,87m 83Kg Wohnhaft: Stuttgart
Hausarzt: Dr. Müller Keine Allergien Glutenunverträglichkeit Medikamentenanamnese: Ibuprofen 600mg
b.B. Beloc-Zok einmal täglich (Dosierung n.E.) Simvastatin 0-0-1(Dosierung n.E.) Genussmittelanamnese:
Nikotinabusus: 50py Alkoholkonsum: 1 kleine Flasche Bier/Abend seit mehreren Jahren Drogenabusus:
verneint Familienanamnese: Vater: gestorben (Ursache unbekannt) Mutter: an Hirninfarkt gestorben Bruder
(64J): hat ein Herzinfarkt gelitten Sozialanamnese: Geschieden, wohnt allein Kinder: 2 Söhne, 1 Tochter
Beruf: Bauingenieur Lebensstil: kein Sport, ungesunde Ernährung Aktuelle Anamnese: Seit 2 Wochen
bestehende dauerhafte epigastrische abdominelle Schmerzen Dumpf, brennend Keine Ausstrahlung Nach
Essen verschlimmern Nichts dagegen eingenommen Er war nicht zuvor bei einem anderen Arzt
Begleitsymptome: Hämatemesis seit gestern Meläna seit gestern Restliche vegetative Anamnese: Übelkeit
Wasserlassen: keine Beschwerde Inappetenz abgenommen in der letzten Zeit Husten (seit mehreren Jahren
wegen Rauchen) Schlafstörungen Scheißausbrüche als Begleitsymptom der Schmerzen Restliche vegetative
Anamnese unauffällig Eigenanamnese: Dorsalgie seit 15Jahren aHT Hyperlipidämie

Voroperationen: Kreuzbandruptur im linken Knie VD: obere gastrointestinale Blutung (Ulcus ventriculi) DD: • andere Ursachen der OGB (Ulcus Duodeni, Ösophagusvarizen) • Cholezystitis • Pankreatitis • KHK

Erfahrung: Der Prüfungsausschuss bestand aus 3 Personen, einer Frau im organisatorischen, prozessualen Teil, einem etwa 60-jährigen Gastroenterologen, der den Patienten spielte und einem neuen Arzt, der den Arzt in der 3. Partei spielte. Alle waren nett und der Ablauf verlief reibungslos. Zunächst wurde ich gebeten, mich vorzustellen und gefragt, ob ich mich bereits bei einer Klinik beworben habe. Der Patient war ruhig, ohne seltsame Reaktionen, er beantwortete alle meine Fragen und ließ nicht zu lange auf sich warten. Seine Fragen am Ende waren die klassischen Fragen: „Was habe ich, was ist die Ursache dafür, sollte ich mir Sorgen machen, was kommt als nächstes? Wenn ich mich erinnere, hat er auch gefragt, ob er Krebs hat. Ich habe vergessen, nach der Impf-/Reiseanamnese zu fragen (es wurde mir weder eine Bemerkung gemacht, noch wurden die Vorwürfe in der gesamten Prüfung erwähnt). Mit dem Bericht war ich einige Sekunden vor Ablauf der Zeit fertig, ohne Zeit zu haben, noch einmal zu überprüfen, was ich geschrieben hatte. Einige Informationen sind mir in der Aufzeichnung möglicherweise entgangen. Zu dem Bericht wurde mir ohnehin kein Kommentar vorgelegt. Im dritten Teil begann ich, Namen, Gewicht, Kilogramm, Wohnort und das Hauptsymptom des Schmerzes vorzustellen, und dann mischte sich der Arzt sofort in die Diskussion ein und stellte Fragen zu den verschiedenen Symptomen und in einem Diskussionskontext (welche Beweise zeigen, dass ulcus ventriculi sein könnte). Ich erwähnte, dass ÖGD durchgeführt werden sollte und er fragte mich, ob dies notwendig sei. Ich antwortete, dass wir angesichts der Meläna und des Hämatemeses sowie wenn wir einen FOBT-Test machen und Blut finden würden, das tun sollten. Nach dem Ende des 3. Teils erwähnte der Gastroenterologe, dass wir das unbedingt tun sollten. Es folgten Fragen dazu, welche Tests wir durchführen würden, um die verbleibenden DDs auszuschließen. Dann gaben sie mir die Aufgabe, die Fachbegriffe auszufüllen: Lues, Geriatrie, Adduktor, Meläna, Tibia, Glaukom. Leider kann ich mich nicht an den Rest erinnern, der gefallen ist. Nach dem dritten Teil wartete ich fünf Minuten vor dem Prüfungsraum, dann riefen sie mich zurück und sagten mir, ich hätte bestanden. Der ältere Arzt berichtete, dass er sehr zufrieden sei und machte den oben erwähnten Kommentar zur ÖGD als Beobachtung. Sie fragten mich, ob ich Interesse an einer bestimmten Klinik in Baden-Württemberg hätte und wünschten mir abschließend viel Glück für die nächsten Schritte.

07.11.2024 Diabetes Typ 1

Die Prüfungskommission bestand aus einem Juristen, einem Oberarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und einem Oberarzt der Allgemeinchirurgie. Einstiegsgespräch: Zu Beginn wurde ich nach meinem Lebenslauf gefragt – welche Fachrichtung ich anstrebe und was ich seit meinem Abschluss gemacht habe.

Anamnesegegespräch: Der Patient sprach langsam und deutlich und gab mir gleich zu Beginn alle wichtigen Informationen. Herr Franz Maier ist 24 Jahre alt, wiegt 65 kg und ist 178 cm groß. Er stellte sich bei uns aufgrund von seit drei Monaten bestehender Müdigkeit vor. Die Beschwerden seien plötzlich aufgetreten und hätten sich im Verlauf verschlimmert. Begleitsymptome: Polydipsie und Polyurie. Auf meine Fragen hin verneinte der Patient Sehstörungen, Polyphagie, Parästhesien, Kältegefühl, Bradykardie, Dysurie, Hautblässe und Tachykardie. In der Vorgeschichte erwähnte der Patient eine Insomnie. Er hat keine relevanten Vorerkrankungen und nimmt zurzeit keine Medikamente ein. In der Vergangenheit erlitt er einen Ellenbogenbruch rechts, der konservativ mit einem Gipsverband behandelt wurde. Zudem leidet er an einer Pollenallergie und reagiert darauf mit Halsödemen. Der Patient raucht eine Zigarette pro Woche und trinkt ein Glas Wein pro Woche; Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab: Der Vater verstarb an einem Myokardinfarkt, die Mutter leidet an Diabetes Typ 2. Er hat zwei Geschwister, die gesund sind.

Sozialanamnese: Er ist ledig, kinderlos und studiert. Er treibt keinen Sport.

Der Impfstatus ist vollständig, und es gab keine auffälligen Reiseanamnese.

Verdachtsdiagnose: Diabetes Typ 1 Differentialdiagnosen: Hypothyreose, Anämie und Zystitis.

Vorgeschlagene Maßnahmen:

Körperliche Untersuchung

Labordiagnostik: Blutbild, CRP, Elektrolyte, Nüchternblutzucker, HbA1c, Urinstatus, TSH, fT3, fT4, Anti-GAD-Antikörper, Anti-IA2, Anti-Insulin und C-Peptid

Therapieansatz: Körperliche Aktivität fördern Ernährungsumstellung Langzeit-Insulintherapie

Dokumentation: 20 Minuten, das war für mich ausreichend.

Arzt-Arzt-Gespräch:

Vorstellung bis hin zu den Medikamenten

Welche Differenzialdiagnose?

Diabetes insipidus?

Wie gehen Sie vor?

Erklären Sie die Erkrankung und die Untersuchung bis hin zur Behandlung für den Patienten.

Patientengespräch:

Patient: „Warum habe ich Diabetes Typ 1?“ Ich habe erklärt, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert und so weiter...

Patient: „Wie viel muss ich spritzen?“ Ich habe gesagt, dass ich es momentan nicht genau sagen kann; es hängt von den Zuckerwerten ab. Er wollte aber wissen, ob es Alternativen wie Insulinpumpen gibt, und ich habe ihm das erklärt.

Patient: „Gibt es andere Alternativen, falls ich kein Insulin mehr spritzen möchte?“ Ich habe gesagt, dass es, soweit ich weiß, Operationen gibt, wie z. B. eine Verpflanzung von Insulinzellen, aber ich wusste den genauen Namen der OP nicht. Er sagte dann: „Ja, richtig: Pankreas-Transplantation.“ Insgesamt war das Gespräch sehr angenehm und ohne Stress. Man muss sich gut vorbereiten, viele Simulationen machen und auch das Hörverstehen üben.

Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass meine Erfahrung für euch hilfreich ist. Ich habe selbst viel aus den öffentlichen Erfahrungen gelernt und möchte auch meine ausführlich teilen.

29.10.2024 Angina pectoris

Mein Fall war Angina pectoris, genau wie im Protokoll.

Fachbegriffe: Mandibula, Dehydratation, Konjunktivitis, Cornea, Atrophie, Ösophagus, Prolaps,

Der Prüfer hat gefragt: • Wichtigste Laborwerte: Troponin und CK, sowie etwas Spezifisches und Günstiges: CK-MB • Differentialdiagnosen • Aufklärung zur Koronarangiographie und ob der Patient übernachten sollte 😊

30.10.2024 Appendizitis

Liebe Kolleg*innen, heute Vormittag habe ich die FSP in Karlsruhe glücklicherweise bestanden. Der Fall war eine Appendizitis. Ich bin super dankbar für alle Mitteilungen, den Austausch und die gegenseitige Unterstützung, vor allem Anki.

Zu Beginn gab es keine Selbstvorstellung. Die Prüfungskommission hat spontan einige Fragen zu meiner Berufserfahrung und meiner derzeitigen Arbeit gestellt (Spezialisierung? Was beinhaltet meine Arbeit?). Dann wurde der Prüfungsablauf erklärt, und ich wurde darüber informiert, wer später die Rollen von Patient und Oberarzt übernehmen. Vor dem Anamnesegespräch gaben sie mir Zeit, ein paar Notizen zu machen. (Ich schrieb mir einige Dinge auf, die ich manchmal vergesse.)

Hans Müller, 41 J., 1,69 m, ca. 80 kg

- verheiratet, zwei gesunde Kinder, Büroangestellter
- Impfstatus: vollständig
- Reise: Spanien im August
- Med: Pantoprazol (Dosis unbekannt) b.B., Ibuprofen b.B. (gegen Rückenschmerzen)
- Keine Allergien oder Unverträglichkeiten
- Vater: a. Hypertonie, an einem MI verstorben
- Rauchen: Rauchstopp vor 15 Jahren (zuvor nur gelegentlich geraucht)
- Alkohol: ein Glas Wein 1-2 Mal pro Woche
- Drogen: verneint

Der Pt stellte sich heute wegen seit gestern Abend plötzlich aufgetretener stechender Schmerzen im rechten UB ohne Ausstrahlung vor. Aktuell sei die Schmerzintensität 7-8 von 10 auf der NRS. Dem Patienten zufolge seien sie bei Flexion des Oberkörpers besser und im Flachliegen schlimmer geworden. Begleitend klagte er über Schüttelfrost, erhöhte Temperatur (nicht gemessen), Nachtschweiß, Inappetenz und Nausea. Verneint wurden die Fragen nach Emesis und Diarrhoe.

Im AA Gespräch: Keine vollständige Vorstellung, sondern ein Dialog, wie es bereits viele Kolleg*innen beschrieben haben.

- Erzählen Sie, wen Sie gesehen haben? Welche Beschwerden hat er?
- Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Warum? Differenzialdiagnosen?
- Wie gehen Sie vor, um Ihren Verdacht zu bestätigen?
- Welche Laborwerte möchten Sie anfordern? Welche Informationen liefert ein Blutbild? (Leukozyten-, Erythrozyten- und Thrombozytenzahl)
- Würden Sie den Urin untersuchen? Warum?
- Falls die Entzündungsparameter nicht erhöht sind, was könnte ein Grund sein? (lokalisierte Entzündung)
- Was würden Sie noch tun? Was kann man in Sonografie sehen?
- Welche Therapie schlagen Sie vor?
- den Patienten über eine laparoskopische Appendektomie aufklären (Stichwort: Schlüssellochoperation)

Fachbegriffe: Apnoe, Apoplex, Colitis ulcerosa, Lymphangitis, Obstipation, Pertussis, Pneumonie, Prostatitis, rezidivierend, Ulcus ventriculi, Varikosis, Varizellen

Fragen des Patienten:

- Kann es sein, dass ich eine Blinddarmentzündung habe? Was werden Sie später mit mir machen?
- Was ist ein CT?

Viel Erfolg an alle!

=== Wie der Pt seine Beschwerden und Vorgeschichte beschrieb === Seit gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, haben die Schmerzen im rechten Unterbauch angefangen. Anfangs waren sie nicht so stark, und ich dachte, vielleicht würden sie von alleine weggehen. Aber heute Morgen sind sie immer stärker geworden. Sie sind nicht gewandert und stechend. Ich kann mir kaum von einer Schmerzskala vorstellen. Auf einer Schmerzskala würde ich die Intensität bei etwa 7-8 einstufen, falls ich das einschätzen müsste. Bisher habe ich noch kein Schmerzmittel dagegen genommen. Falls Sie mich später untersuchen, kann ich sie noch eine Weile aushalten. Die Schmerzen verbessern sich etwas, wenn ich mich nach vorne beuge oder wenn ich meine Knie im Liegen anziehe. Ganz flach liegen kann ich nicht, das tut wahnsinnig weh. Mir ist außerdem übel. Bis jetzt habe ich jedoch nicht erbrochen. Ich fühle mich heiß, aber ich habe kein Thermometer zu Hause. Schüttelfrost habe ich nicht, allerdings habe ich letzte Nacht stark geschwitzt. Seit gestern Abend habe ich nichts gegessen und auch keinen Appetit. Ansonsten habe ich weder Durchfall noch Probleme beim Wasserlassen. Ich nehme Pantoprazol, wenn ich Sodbrennen habe. Dieses Medikament wurde mir von meinem Hausarzt verschrieben. Bisher wurde das Sodbrennen nicht weiter untersucht, und auch eine Magenspiegelung wurde noch nicht gemacht. Das lag auch an der Corona-Zeit. Es tritt allerdings auch nicht häufig auf. Mein Hausarzt meinte, eine Magenspiegelung wäre sinnvoll, falls ich häufiger Sodbrennen hätte. Ich bin eigentlich fit und gesund, habe weder Zucker noch Bluthochdruck. Ich erinnere mich nicht mehr an Details, allerdings hatte ich einen Leistenbruch als Kind. Davon habe ich immer noch eine Narbe in der rechten Leiste. Damals war ich etwa 5 Jahre alt.

=== Für alle, die sich gründlich über alle Details am Prüfungsort Karlsruhe informieren möchten === Hier sind einige Dinge aus meiner Erfahrung, also, keine Garantie 😊 ===

- Überall gab es eine digitale Uhr (zumindest heute, nicht nur im Prüfungsraum, sondern auch in dem Raum, in dem man den Brief verfasst).
- Die Dokumentation erfolgte direkt nach dem Anamnesegespräch. (Beide Räume liegen nebeneinander.) Nach der Dokumentation habe ich jedoch noch ca. 20 Minuten gewartet, bis ich zum AA Gespräch aufgerufen wurde. (Ich vermute, die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dauer vom Gespräch mit anderen Prüflingen.) Man kann diese Zeit nutzen, um über diagnostische und therapeutische Maßnahmen genauer nachzudenken.
- Es gab keine Möglichkeit, den Brief am Computer zu schreiben.
- Unbegrenztes Papier und Kulis waren verfügbar. Natürlich kann man auch einen eigenen Kuli mitbringen.
- Auf der ersten Seite des Anamnesebogens gab es Felder für Allergien, Genussmittel, Sozialanamnese und Familienanamnese, in den man stichpunktartig schreiben kann. Den Rest musste man sich selbst um die Übersichtlichkeit kümmern, denn es gab keine separaten Felder für Verdachtsdiagnose und weiteres Vorgehen. Außerdem wurde das Geburtsdatum nicht verlangt.
- Bitte vergesst nicht, euch bei der Ankunft bei der Sekretärin anzumelden. (Danke für die Erinnerung von einer netten Mitprüfling!)

28.10.2024 gastroösophageale Refluxkrankheit

Die Prüfer waren sehr freundlich und haben mir geholfen.

Der Patient XY, 95 kg, 179 cm, stellte sich aufgrund eines seit längerer Zeit bestehenden Druckgefühls hinter der Brust, Pyrosis, Heiserkeit und Husten bei uns vor. Der Patient hat darauf hingewiesen, dass Schokolade, Kaffee, Flachliegen und Rauchen die Beschwerden verschlimmern würden.

Die vegetative Anamnese war unauffällig. Die Fragen nach Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten wurden verneint. Der Patient raucht seit 31 Jahren etwa 20 Zigaretten täglich und trinkt 1-2 Gläser Wein, manchmal auch Spirituosen.

In der Familienanamnese ergaben sich beim Bruder ein Ösophaguskarzinom und bei der Schwester Multiple Sklerose seit 6 Jahren. Der Patient ist verheiratet und hat einen Sohn. Er ist Angestellter beim Verkehrsdienst.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine gastroösophageale Refluxkrankheit hin.

Fragen:

1. Ist der Patient adipös?
2. Risikofaktoren der Refluxkrankheit?
3. Wenn bereits ein Barrett-Ösophagus vorliegt, was machen wir?
4. Was ist die wichtigste Untersuchung und warum? Keine Aufklärung.

Ich habe 3/4 bestanden, andere Prüflinge hatten Laktoseintoleranz.

24.10.2024 Anorexia nervosa

Hallo Leute, ich habe gestern (24.10.24) die Prüfung in Karlsruhe abgelegt und Elhamdulillah bestanden

Es handelte sich um einen Fall von Anorexia nervosa, und es war etwas schwierig und sehr stressig, weil ich nicht wusste, was ich die Patientin fragen sollte und sie keine Beschwerden hatte. Alles war normal Außer Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust

Die Prüfer waren sehr sehr sehr nett und sprachen deutlich

die Fälle für heute waren: - kolonkarzinom - Anorexia nervosa x 2

20.09.2024 Abszess am Gesäß

Herr Bernhard Lauber 31 J Gewicht 89kg Größe 182cm

Allergie: Penicillin Allergie (Hautausschlag)

Nichtraucher ein Glass Bier abends Drogenkonsum wurde verneint

Elektor von Beruf, verheiratet und habe eine Tochter

Vater und Bruder sind gesund Mutter leide an DM seit über 30 J

Herr Lauber ist 31 Jahre alt. Er kam zu uns wegen seit zwei Tagen bestehenden, drückenden Schmerzen am rechten Gesäß ohne Ausstrahlung.

Der Patient berichtete, dass die Schmerzen allmählich nach einer Injektion(Voltaren) aufgetreten seien und sich im weiteren Verlauf verschlimmert hätten.

Die Schmerzintensität bewertete der Pt. mit zwischen 4 und 5 von 10 nach der Schmerzskala

Zusätzlich teilt er mit, dass er Erythem, Ödeme, Schüttelfrost Nachtschweiß und Körpertemperatur 39 °C habe.

Die Vegetative Anamnese ist unauffällig.

Das Vorliegen von Insomnie, Inappetenz und Gewichtsverlust wurde verneint.

Vorerkrankungen: Arterielle Hypertonie und Diabetes Mellitus seit 2 J

Medikamente: Candesartan 8mg 1-0-0 Metformin 500 mg 1-0-1

Voroperationen: Z.n Sprunggelenkfraktur vor 7 J

Verdachtsdiagnose: Auf der Basis meiner erhobenen Befunde gehe ich von einem Verdacht auf Abszess am Gefäß aus.

Aber als Differenzialdiagnose denke ich auch an einen Diskusprolaps und eine Diskushernie.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten körperlich untersuchen.

Das umfasst Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation. Ich konzentriere mich auf das rechte Gefäß.

Danach werde ich Laboruntersuchungen durchführen, BB, CRP, BSG, sowie eine Sonographie als bildgebende Untersuchung.

Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, plane ich, den Patienten zunächst konservativ zu behandeln, und bei Bedarf eine Inzision und Drainage durchzuführen.

Zudem werde ich eine Antibiotikatherapie (Cephalosporine) und eine Analgesie zur Schmerzlinderung einleiten.

Patient: was habe ich Herr Dr? Soll ich hier bleiben ?

Arzt-Arzt: Warum ist der Patient hier? Welche Beschwerden hat er?

Verdachtsdiagnose?

Welche Untersuchungen braucht der Patient?

Und Therapie?

Aneurysma Struma hepatitis ulcus pepticus, Aminoerkrankungen, Mandibulitis, Pneumothorax, Varikozelen, GRD

Ja, die Prüfung war gut. Alle drei Prüfer waren sehr nett und unterstützen mich auch weiterhin. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber dann habe ich mich gut an die Prüfungsatmosphäre angepasst. Es war wirklich machbar.

Ihr könnt die Fachsprachprüfung also auch bestehen. Wenn jemand einen Prüfungstermin hat, können wir gerne gemeinsam paarmal üben und ich gebe gerne Feedback

Viel Erfolg 🍀

16.08.2024 Ösophaguskarzinom

Guten tag, ich habe die Prüfung bestanden heute, mein fall war Ösophaguskarzinom, Herr Otto Schutser 54 ja, kommt wegen seit wochen bestehender langsam aufgetretener retrosternaler dysphagie mit fester Essen und mit reflux der speise während der Rückenlage, und Gewichtsverlust (er habe sich nicht gewogen) in zeitraum von 2 wochen und asthämie, Vegetative Anamnese: unauffällig bis auf insomnie, VE DM2, AH, z.n rezidivierende arthritus urica, medika: belockzok, janumet, keine allergien, rauchen 20zig/tag zuseit 30jahren, alkohol 10 Flaschen Bier/tag, familien anamnese: vater herzinsuffizienz, mutter DM1, bruder prostatakc, social: geschieden, lebe allein, keine kinder, bauer von arbeit.

AAG was sind die risikofaktoren? Was VD? DD? Was werden Sie machen? THERAPIE? Und aufklärung VD und OGD, FB: caudal, distortion, MI, zyste.

Die Kommission waren sehr sehr nett.

Viel Erfolg

08.08.2024 Kolonkarzinom

Hallo!!!

Heute gab es zwei Fälle von Kolonkarzinom, genau wie im Protokoll. Wir haben bestanden

Gestern Mein fall war PaVK und 2 Gicht, wir haben bestanden

23.07.2024 Stabile Angina

Herr Josef Renner 55 Jahre Alt.

Er stellte sich bei uns wegen seit 3 Wochen bestehender intermi Toraxschmerzen vor. Die Schmerzen sei drückend, intermittierend und Belastungsabhängig. Die Intensität liege bei 0 auf der Schmerzskala bei Ruhezustand und 6 bei Belastung, mit Ausstrahlung in den linken Arm. Er habe keine Medikamente dagegen eingenommen.

Als Begleitsymptome nannte er Parästhesie an den Linken Arm.

In der Vegetativen Anamnese erwähnte er Enschladstörungen.

An Vorerkrankungen seien arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, Diabetes mellitus Typ 2 seit 10 Jahren und TVT vor 4 Jahren bekannt.

An Voroperationen sei eine Appendektomie vor 30 Jahren bekannt. Diese sei komplikationslos verlaufen.

An Medikamenten nehme er Metformin 1000mg und Lisinoprol.

Er sei vollständig geimpf und sei in letzter Zeit nich im Ausland gewesen.

Es seien keine Allergien Bekannt.

Er rauche Pfeifen mal am Tag. Er trinke 2 Flaschen Bier am Tag. Er nehme keine Drogen.

Er treibe keinen Sport.

Er sei verheiratet und habe 3 gesunde Kinder. Er arbeite als Hausmeister.

Der Vater leide an arterieller Hipertonie

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Stabile Angina.

Als Differenzialdiagnose kommen die folgenden in Betracht Gastritis, Zervikaler Diskusprolaps..

Diagnose un Therapie wie im Protokoll.

Aufklärung PTA (Perkutane tranailuminale Angioplastie.

Fachbegriffe (ich erinnere mich) Contusuo cerebro, Kommissur und Paraneoplasie.

15.07.2024 Multiple Sklerose

Hallo zusammen,

ich habe die Prüfung am 18.07.2024 abgelegt. Herr **Klaus Huber**, 33 Jahre alt, war mein Patient (**Multiple Sklerose**).

Die Dokumentation erfolgte wie im Protokoll, jedoch gab es kleine Modifikationen bei den Begleitsymptomen: Der Patient klagte über Hypästhesie, Parästhesie und Sehstörungen, verneinte jedoch depressive Stimmung und Paralyse.

Der Patient erzählte anfangs sehr viel und nannte fast die gesamte aktuelle Anamnese, währenddessen habe ich die wichtigen Informationen notiert und nicht wiederholt nachgefragt.

Vorherige Erkrankungen (VA): Unauffällig bis auf Insomnie.

Vergangene Erkrankungen (VE): Zustand nach Appendektomie im Alter von 12 Jahren.

Medikamente: Keine.

Allergien: Fisch (äußert sich in geschwellenen Lippen und Zunge).

Noxen: Cannabis.

Alkohol: Kein Konsum.

Familienanamnese: Vater gesund. Mutter hatte Mammakarzinom, behandelt mit Chemotherapie, Radiotherapie und Mastektomie. Keine Geschwister.

Reaktionen: Der Patient fragte nach den möglichen Ursachen seiner Symptome und wie weiter verfahren werden soll.

Es wurde ein Arzt-Arzt-Gespräch geführt, bei dem die Verdachtsdiagnose (VD) und Differentialdiagnosen (DD) besprochen wurden. Die körperliche Untersuchung (KU), Laboruntersuchungen und apparative Diagnostik wurden ebenfalls diskutiert.

Der Oberarzt empfahl eine MRT-Untersuchung des Schädels und eine Therapie zu Hause, darunter Physiotherapie. Der Patient hatte im Internet recherchiert und wünschte sich eine vollständige Heilung seiner Erkrankung. (**Aufklärung**)Es wurde ihm erklärt, dass seine Erkrankung, Multiple Sklerose, chronisch und

unheilbar ist. Da der Patient im zweiten Stock wohnt, riet der Oberarzt, ihm zu empfehlen, in ein Erdgeschoss zu ziehen. (Ich habe dies während der Anamnese nicht berücksichtigt. 😴)

Ich wünsche euch viel Erfolg 🙌

15.07.2024 Pertussis

Guten Abend. Heute habe ich FSP in Karlsruhe bestanden. Fall war Pertussis.

15.07.2024 DM I

Hallo zusammen, ich habe heute die FSP in Karlsruhe bestanden, Alhamdulillah.

Mein Fall war Migräne, derselbe wie die Fälle. Das Arztgespräch war sehr intensiv, viele Fragen, besonders zur **Aufklärung** (DC, MRT, Therapie).

Für den **Fachbegriffe** war der neue Begriff Traumatologie (ich habe "Lehre von Knochen" geschrieben).

02.07.2024 DM I

Ich habe am 02.07.2024 die Prüfung abgelegt.

Der Fall war DM1. Drei andere Kandidaten haben ebenfalls die Prüfung abgelegt.

Ihre Fälle waren Sprunggelenkfraktur und Pankreatitis.

Herr Franz Meyer ist ein 24-jähriger Patient, der sich wegen Müdigkeit seit 3 Monaten vorgestellt habe.

Er sei deswegen beim Hausarzt gewesen, der ihn zu uns überwiesen habe. Zusätzlich leide er an einem Polyurie-Polydipsie-Syndrom sowie an einem Gewichtsverlust von circa 5 kg innerhalb von 3 Monaten. Alle anderen Fragen seien verneint worden.

VA: unauffällig bis auf Insomnie

VE: Ellenbogenfraktur, die konservativ mittels Gipsverband immobilisiert worden sei

Medikamente: keine

Allergie: Pollen sowie Haselnüsseallergie (es äußert sich mit tränenden Augen)

Keine Unverträglichkeiten

Genussmittel:

Tabakkonsum: 1 bis 2 Zigaretten gelegentlich

Alkohol: Weißwein, ein Glas gelegentlich

Familienanamnese:

Vater: an Myokardinfarkt gestorben

Mutter: DM2

Geschwister: ein Bruder, der gesund sei

Schwester: Ich habe eine Schwester, die behauptet, eine Hypothyreose zu haben, aber sie hat nur Symptome, wenn sie eine Prüfung hat oder etwas zu erledigen hat.

Reaktionen:

Was habe ich?

Mein Hausarzt hat mir gesagt, es könnte Krebs sein. Was meinen Sie, Frau Doktor?

Was werden Sie jetzt machen?

Frau Doktor, ich habe Angst vor Nadeln.

Arzt-Arzt-Gespräch: VD

DD

Warum haben Sie sich für Diabetes Typ 1 entschieden?

Was ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2?

Fachbegriffe:

Keine neuen Fachbegriffe

Das wäre es.

Viel Erfolg!

30.06.2024 Sprunggelenkfraktur

Guten Tag ich habe die Prüfung heute abgelegt und Hamdulleh bestanden

Fall: Sprunggelenkfraktur

Wie im Protokoll

Die Prüfer waren sehr nett.

Reaktion des Patienten: „Geben Sie mir bitte ein Schmerzmittel? ich habe sehr starke Schmerzen. Wo ist die Krankenschwester? 😊 Werden Sie ein Röntgen machen?“

Ich habe die Dokumentation nicht vollständig geschrieben (bis zu den Medikamenten und Zeit war um 🤖).

Währenddessen habe ich auch bemerkt, dass ich vergessen habe, nach der Medikamentenliste zu fragen.

Der Patient hat Faktor-V-Leiden und nimmt ein Medikament, aber könnte nicht den Namen erinnern...

Ich habe geschrieben Rücksprache mit dem Hausarzt / Medikamentenliste anschauen im. Sie haben

angemerkt, dass ich fragen sollte, ob der Patient schon einmal eine Thrombose hatte, was sehr wichtig in

diesem Fall ist. Im AAG habe ich gut geantwortet und die Prüfer waren zufrieden, obwohl ich nichts über

Diagnose und Therapie im Arztbrief geschrieben hhh

Fragen:

Verdachtsdiagnose: Sprunggelenkfraktur rechts

Differenzialdiagnosen: Distorsion, Kontusion, Achillessehnenruptur

Was würden Sie machen:

- Klinische Untersuchung (KU), Puls, Durchblutung, Motorik und Sensibilität (pdms) überprüfen
- Röntgen des Sprunggelenks in zwei Ebenen

Prüfer: „Und wenn wir nichts finden?“

„Bei unklaren Befunden oder präop benötigen wir ein CT. Außerdem brauchen wir ein Labor: Blutbild, Gerinnungsparameter, Entzündungsparameter...“

Prüfer: „Sind Sie Orthopädin?“ 🤔

Ich: „Nein.“

Prüfer: „Ich auch nicht. Was machen Sie?“

Ich: „Ich veranlasse ein orthopädisches Konsil.“

Prüfer: „sehr gut Oder sogar eine Verlegung, wir sind keine Chirurgen.“ 🙄

Was haben Sie als Schmerzmittel gegeben: „Ich habe Metamizol vorgeschlagen.“

Prüfer: (schüttelt den Kopf)

Ich: „Oder IBU.“

Prüfer: „Die Frauen mögen IBUPROFEN. Ich weiß nicht, was er damit meinte.“ 😊

Keine Aufklärung.

Das war alles 😊. Am Ende haben sie mir gesagt, dass sie beeindruckt sind, wie gut ich Deutsch spreche, obwohl ich erst seit drei Monaten hier bin. Zu Beginn der Prüfung gab es keine Vorstellung, sie hatten meine Unterlagen dabei. Sie fragten nur, habe ich gut angekommen .. wie ich Deutsch gelernt habe, habe ich ein Praktikum gemacht.. seit wann ich hier bin und warum ich nicht nach Frankreich
Auch wollten sie wissen, ob ich in einer WG oder mit Familie wohne. und wie sprechen Wir (auf deutsch ?

Viel Erfolg die Prüfung ist machbar es geht eher um die Sprache ..

26.06.2024 KHK

Mein fall war KHK die Ärzte waren nett und der rechter neutral . Herr johans Schulze ist ein 51 jahiriger patient Der sich heute bei uns wegen seit heute morgen bestehender bestehender druckender starker thorakalgie mit Ausstrahlung in den Unterkiefer sowie in den linken Arm vorgestellt hat.

Ich habe die anamnse unterbrechen sie waren glücklich damit .

Der Patient berichtet, dass die schmerzen plötzlich nach der Streit mit dem Nachbarn aufgetreten und im Lauf der Zeit schlimmer geworden seien .

Die schmerzen lägen bei 7 von 10 auf der Skala. Er fügte hinzu dass er die ähnlichen Beschwerden vor 4 Wochen nach einer stressige Situation gehabt hatte .

Als begleitsymptom klagt er über tachykardie , nausea , Angst, pyrosis und gastralgie seit 5 Jahren
Die Fragen nach dyspnoe, Husten, regurgiation vomitus wurden verneint.

An Vorerkrankungen fanden sich : aHT und DM Typ 2 seit 10J . Keine relevante Operation sei bei ihm bekannt .

AA Gespräch: DD. Erwartung bei Labor und EKG . Was sind herzenzymen . Therapie .Warum nitrite , (ich habe gesagt ich weise nicht und die Antwort war unklar für mich) PTCA aufklärung sowie die Krankheit.

Fachbegriffe : basaliom , begeminus , intoxication , obstipation , bösartig, malignom , dyspnoe , die andere ich errinire mich nicht aber sehr einfach. Das war alles , sie haben mir gesagt es ist sehr wichtig fließend zu sprechen und die Krankheit zu den Patienten einfach erklären .

Viel Erfolg

26.06.2024 Sprunggelenk Distorsion

Sprunggelenk Distorsion Gestern nach Fußballspiel Loch übersehen gestolpert Umgeknickt

Schmerzen bis knie Ruhezustand null Bewegung auftreten Fuß nicht warm Ödem bis knie Bläuliche verfärbung nur im sprunggelenk

Besserung durch Abkühlung

Die schmerzen haben sich verschlechtern und nich von anfang an sooo stark deswegen nicht Fraktur sondern distorsion

VE: Faktor V leiden Hodgkin zervikal Testisektomie VO: Meniskus op Asthma bronchiale Allergie hase Gräser.. Asthma anfall

Frühblüher rhinokonjunktivitis

24.06.2024 Obstruktive Schlafapnoe Syndrom

Hanz Müller, 61 Jahre alt. 1.06.1963 LKW Fahrer, verheiratet, 2 Kinder, Nach Allergie habe ich vergessen zu fragen. Noxen: Nikotin 15-20 Zigaretten pro Tag seit mit 28 Lebensjahr.(REAKTION ☒) Alkohol: 1-2 Gläser Bier abends Drogen- keine. Familienanamnese: Vater: aHT, DM Alterzucker Krankheit Mutter: sei mit 55 LJ an Lungenkrebs verstorben. (Pat. hatte Angst, Krebs zu haben, REAKTION ☒) Herr Hanz Müller ist ein 61 - jähriger Patient, der sich heute bei uns wegen 3 Monaten bestehender progredienter Adynamie vorstellte. Der Patient berichtete ,dass er sich tagsüber schläfrig und müde fühle, obwohl er nachts genug schlafe. Dem Patienten sind folgende Begleitsymptome aufgefallen: Konzentrationsstörung, Abgeschlagenheit und Tussis. Des weitem klagte er über Gewichtsverlust von 2 kg innerhalb der letzten 3 Monaten. Dem Patienten zufolge klagte seine Frau über sein Schnarchen während er schläft. Die vegetative Anamnese sei bis auf Pollakisurie unauffällig. An Vorerkrankungen sind ihm Folgende bekannt:

1. aHT seit mit 55 Lebensjahr.
2. Prostata Hyperplasie seit 8 Jahren.
3. chronische Bronchitis seit mit 28 Lebensjahr.

In Bezug auf Medikation nehme er amlodipin 10 mg 1-0-0 Tamsulosin 0.4 mg 0-0-1 Salbutamol spray b.B

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Obstruktive Schlafapnoe Sindrom hin.

Die Differentialdiagnosen kommen Anämie, Hyperthyreose und Tumorerkrankungen in Betracht.

Zur weiteren Abklärung sind folgende Untersuchungen durchzuführen:

1. KU (Palpation der Schilddrüse, Auskultation des Herzens,)
2. Labor : BB, CRP, BSG, TSH, ggf T3 und T4.
3. Sonographie der Schilddrüse

4. CT und MRT Tumoren) Metastasen auszuschließen.
5. Polysomnographie.

Sollte sich die VD bestätigen, sind die folgenden therapeutischen Maßnahmen einzuleiten:

1. Lebensstiländerung/ Gewicht , Schlafposition ändern/ seitlich hinlegen.
2. Masken benutzen während des Schlafens (Oxygenierung verbessern)
3. HNO konsil fordern. ggf.Uvuleplastik durchführen.

Aufklärung: was Patient hat? Was ist SCHLAFAPNOE SYNDROM. wie werden Sie ihn behandeln.

Fachbegriffe: kein Neues

Viel Erfolg an alle 😊

Tipps und Erfahrung:

Mann muss immer gut zuhören, sinnvolle Fragen stellen. Muss nicht immer nach Reihenfolge sein: in meinem Fall hat der Patient gesagt, dass er husten als vegetative Anamnese erwähnt, und den mit Rauchen verbunden. Ich hab gleich nach Noxen gefragt....seit wann, trinken usw.....

Empathie zeigen: die Mutter vom Patienten hatte Lungenkrebs, deswegen hat er Angst, ich habe sofort reagiert.. Andersfall erwähnte er noch Mall, dass es vielleicht etwas Ernsthaftes ist , ich hab gesagt, bitte beruhigen Sie sich, denken Sie bitte nicht an schlimmste Sache, es können viele Ursachen für ihre Beschwerden haben, Lassen Sie uns erstmal Sie untersuchen.....bla bla...

Beim Arzt Arzt Gespräch seien Sie bitte wie möglich frei,und sprechen sie ohne Eile. Einfach Vorstellen, die Sätze nicht auswendig lernen, Sagen Sie bitte nur , was Der Patient gesagt hat. Keine Zusätzliche Informationen oder symptome, obwohl die für diese Krankheit relevant sein könnten.

Halten Sie immer Augen Kontakt sowohl mit dem Arzt bei der Fallvorstellung, sondern auch mit dem Patienten während Sie Anamnese erheben. Lächeln ist immer gut....

Kommen Sie ein bisschen früher am Prüfungsort, lassen Sie Zeit, sich an der Atmosphäre zu gewöhnen. Nehmen Sie mal auch ein paar Schokolade ZB. Snikers, Twix...das hilft gegen Stress😊. (Das funktioniert immer bei mir)

Achten Sie bitte auch auf Ihre Kleidung, Aussehen, Haare.....

Streiten Sie bitte nicht mit Prüfern, die könnten sogar erstmal sagen,dass Sie durchgefallen sind und Sehen wie Sie reagieren.

Wenn Prüfer zeigt ihre Fehler, geben Sie ruhig zu, und sagen Sie das habe ich ausversehen gemacht (bei Schriftlichem Teil) , oder Wegen Aufregung hab ich vergessen zu fragen, aber bei der KU werde ich nach fragen....

Üben Sie für Dokumentation genug, weil da Zeit sehr knapp ist.

Vor der Prüfung bekommt jede Kälte Füße.

Ich habe was hinzugefügt..

Für den Ersten Eindruck, den Sie zeigen, bekommen Sie keine zweite Chance. Deswegen ist es wirklich wichtig, am Anfang mit freundlichen Grüßen und Lächeln zu erscheinen (üben Sie vor dem Spiegel. 😊)

Am Ende des Gesprächs bekommen sie fachbegriffe, wenn sie die Fachbegriffe auswendig gelernt haben, das heißt, sie können am Ende Ihre Kenntnisse gut zeigen 😊

- Sie müssen einen guten Eindruck hinterlassen

Ich bedanke mich an alle für die Hilfe und Materialien. Besonders @Linux56 danke dir. Ich habe vor dir großen Respekt.

18.06.2024 Polymyalgia Rheumatica,

Mein Fall heute war Polymyalgia rheumatica, genau wie im Protokoll, zusätzlich mit Morgensteifigkeit, aber ohne depressive Verstimmung. Die Prüfer waren der nett 🙌

17.06.2024 Rheumatisches Fieber und TVT

11.06.2024 Obere gastrointestinale Blutung Bei Ulkuskrankheit

Herr Peter Kowalski , ist ein 51 jähriger Patient , der sich heute Morgen bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit zwei Tagen aufgetretener bestehender Hämatemesis (Hellrot Blut Erbrechen) vorgestellt hat.

Außerdem klagte über bestehende zunehmende drückende epigastrische Oberbauchschmerzen ohne Ausstrahlung. Die Beschwerden seien langsam aufgetreten und hätten sich im laufe der Zeit verschlechtert. Die schmerzen würden bei 06/10 auf der Skala liegen. Er habe dagegen Milch getrunken und habe es ihm geholfen. Die Frage nach ähnlichen Beschwerden wurde verneint Die Beschwerden seien von den folgenden Symptomen begleitet : . Fatigue +++ . Tachycardie . Meläna . Meteorismus . Pyrosis

Die Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf insomnie wegen schmerzen An Vorerkrankungen leide er an : Arterielle hypertonie seit 10 Jahren Rheumatoide Arthritis seit 10 Jahren Er wurde wegen Appendektomie operiert. Er nehme regelmäßig Medikamente ein : Captopril 25 mg 1.1.1 Diclofenac 25 mg / 50 mg bei bedarf

Noxen : Er rauche 20 Zigaretten pro Tag mit seinem 16 Lebensjahr Er trinke täglich 1 Glas Wein oder 1 Flasche Bier

Sozial Anamnese : Er sei Fernfahrer von beruf und habe viel Stress bei der Arbeit Er sei verheiratet und habe 1 gesund Sohn ÖGD Aufklärung

Fachbegriffe: Ösophagitis, Ulcerosa colitis , Defibrillator , Anämie , Femurfraktur, Physiotherapie, Arteria poplitea , Kachektisch, BMI , Ulcus cruris , Spinalkanalestenose , TEP.

10.06.2024 Oberschenkelfraktur

Mein Fall heute war Oberschenkelfraktur, mehr oder weniger derselbe wie der Fall, den wir haben, bis auf ein paar kleine Details.

Jury war extrem nett und hilfreich, sie stellten ein paar Fragen zu körperliche Untersuchung, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten und Anästhesie im Verlauf der Behandlung. Es wurde keine Aufklärung gefragt.

Fachbegriffe: Adenom, DRE, Pertussis, Inzision, Abrasio, Distortion, Tremor, Sinus maxillaris, Zystostatika
Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg

10.06.2024 Divertikulose

Mein Fall heute war Divertikulose.

Die Kommission war extrem freundlich und hilfreich. Die Anamnese war einfach: der PT klagte nur über Unterbauchschmerzen nach dem Essen. Alles andere war unauffällig. Keine Aufklärung, nur ein paar fragen zur Maßnahme und Therapie.

Fachbegriffe wie in Anki: Adipositas, STIKO, Disarthrie, Logopädie, Tonsillitis purulenta, Thyroidectomy, Carotidisstenose, Veneninsuffizienz, Claudicatio intermittens, Compliance , Pertussis

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg

04.06.2024 Pyelonephritis

Hallo, am 06.06.2024 habe ich die Prüfung in Karlsruhe abgelegt und Gott sei Dank bestanden. Mein Fall war Pyelonephritis gleich wie im Protokoll, keine Reaktion noch Aufklärung (Außer "erklären Sie dem Patienten die nächsten Schritte") ein anderer Fall war Kolorektales Karzinom, Alle Fachbegriffe von der Liste, die Kommission war sehr sehr nett und freundlich. Viel Glück!

04.06.2024 Pneumonie

Am 04.06.2024 habe ich die Prüfung in Karlsruhe gemacht und bestanden. Das Thema war Pneumonie, wie es in den Protokollen beschrieben wurde. Die drei Prüfer waren sehr nett.

Anamnese: Der Patient hat mich nach der Diagnose gefragt, ob er im Krankenhaus bleiben sollte und welche Behandlung nötig ist. Es ist möglich, die Anamnese in weniger als 20 Minuten abzuschließen, ohne negative Punkte zu bekommen. In meinem Fall hat die Anamnese etwa 15 Minuten gedauert.

Dokumentation: Wichtig ist, dass alle Teile der Dokumentation vollständig sind. Es muss keine perfekte oder komplexe Dokumentation sein.

Arzt-Arzt-Gespräch: Der Oberarzt hat mich nach der Verdachtsdiagnose, den Differentialdiagnosen mit Begründung, den notwendigen Tests zur Bestätigung der Diagnose und den Fällen gefragt, in denen eine Bronchoskopie erforderlich wäre (Atelektase oder starke Sekretion). Außerdem wollte er wissen, ob der Patient stationär aufgenommen werden müsse (ja, wegen des Alters und der Vorerkrankungen).

Fachbegriffe: Abdomen, karzinogen, Ekzem, Cholangitis, benigne, Alopecia, diuretisch, medial, Orbita und noch ein paar mehr. Alle stehen auf der Liste. Es macht einen guten Eindruck, wenn man alle Fachbegriffe kennt.

Mein Eindruck ist, dass die Prüfer nicht erwarten, dass wir perfektes Deutsch sprechen. Sie korrigieren einige Fehler während der Prüfung. Wichtig ist, dass wir alles verstehen und unsere Ideen gut ausdrücken können.

Danke an alle, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt und das Lernmaterial entwickelt haben! Viel Erfolg euch!



14.05.2024 zervikaler Bandscheibenvorfall

Bei dem heutigen Fall handelt es sich um einen zervikalen Bandscheibenvorfall, genau wie bei Protokoll.

Vor der Prüfung findet ein längeres Gespräch statt, in dem auch Fragen zu Ihrer persönlichen Situation gestellt werden.

Arzt-Arzt-Gespräch, keine Patientenvorstellung, sondern Fragen von Anfang bis Ende. Dazu gehört, warum es sich um einen zervikalen Bandscheibenvorfall handelt und wo sich der zervikale Bandscheibenvorfall befindet. Welche Erkrankung hat den Lendenbandscheibenvorfall verursacht und wo ist er lokalisiert? Welche Untersuchungen werden durchgeführt und warum ist MRT besser als CT? Was sind die Differentialdiagnosen? Was sind die Symptome einer Schulterluxation? Wie wird die Operation durchgeführt? Wie wird sie konservativ behandelt?

Die Prüfer, die die Fragen stellen, sind sehr, sehr freundlich und wir stehen sogar oft für einige Demonstrationen auf.

Neues Fachbegriff: Dilatation, sonst übereinstimmend mit Protokoll.

14.05.2024 Abszess am Gesäß

Die Kommission waren nicht unfreundlich aber ich kann auch nicht sagen dass Sie fröhlich waren. Also ganz neutral.

Pat: Bernhard Lauber 31 JA Beschwerde: Roter, schmerzhafter Fleck seit 2 Tagen. Fieber bis 39 grad. Er leidet schon längst an Rückenschmerzen und er nimmt normalerweise orale Analgetikum ein aber vor 3-4 Tagen hat er ein Voltaren Analgetikumspritz am rechten Gesäß bekommen. Bis auf Fieber war vegetative Anamnese unauffällig.

VE: A. Hypertonie und DM typ 2 Medikamente: Metformin und Kandesartan

Allergie gegen Penicillin. Noxen: Trinkt ein Flasche Bier täglich. Familie: Mutter Typ 1 DM. Sozial: Elektriker, verheiratet habe eine Tochter.

AA Gespräch: Diagnose? DD? Welche Untersuchung würden Sie durchführen? Therapie? Was kann am schlimmsten Fall vorkommen? Was für ein Rolle spielt die Diabetes in diesem Fall? Was würden Sie ihm empfehlen?

Fachbegriffe: Intoxikation, Amaurose, Tremor, Hepatitis, Dilution, Epiglottis, Dehydratation, Umbilical Hernie, Verruka, Rippe, Alopezie

13.05.2024 Zöliakie

Die 3 Prüfer waren sehr nett. 2 Ärzte und 1 Richter, sie waren alle sehr freundlich.

Vor der Dokumentation, hat der Richter betont, dass ich IMMER vollständige Sätze im Arztbrief schreiben muss. Falls ich nicht genug Zeit hätte, müsste ich auf jeden Fall die Diagnose, Diagnostik und Therapie mindestens mit Stichworten schreiben.

Fragen des Patienten: muss ich hier bleiben? Was habe ich? darf ich nicht mehr Brot essen!!!!??? Was soll ich denn essen? Wieso habe ich diese Unverträglichkeit seit wenigen Monaten und nicht früher gekriegt, wie funktioniert das? (Pathophysiologie kurz erklären).

A-A-Gespräch: Verdachtsdiagnose? Wieso Zöliakie? (Die Schmerzen treten nur nach dem Verzehr von Brot auf, Zeichen von Malabsorption) Wo genau im Darmtrakt tritt Zöliakie auf? (Duodenum) Wie sichern wir die Diagnose, außer der Labordiagnostik? (ÖGD mit Biopsieentnahme aus dem Duodenum) Wieso Kolonkarzinom als DD? (Gewichtsabnahme als ) Therapie (Verzicht auf glutenhaltiges Essen, Ernährungsberatung) welches Essen ist noch erlaubt? (Mais, Reis, Kartoffeln, Möhren, usw.)

ÖGD Aufklärung.

Fachbegriffe: Duplikatur, Ösophagotracheale Fistel, Calcaneus, Acetabulum, Aortenaneurysma, Meningitis, Volvulus, Malrotation und ein paar mehr

Arztbrief:

Name: Gustav Hirschmann Alter: 44 Jahre Größe: 1,70 m (erinnere ich mich nicht genau) Gewicht: früher 69-70 kg, jetzt ca. minus 6 kg (~64 kg) HA: Herr Müller

Herr Hirschmann ist ein 44-jähriger Patient, der sich wegen seit 4 Monaten bestehender langsam auftretender rezidivierender nahrungsabhängiger diffuser Abdominalschmerzen ohne Ausstrahlung sowie Gewichtsabnahme von 6 kg bei uns vorgestellt hat.

Der Patient gab an, dass die Schmerzen nur 2-3 Stunden nach dem Essen von Brot aufgetreten seien. Die Schmerzintensität bewerte der Patient mit 4 von 10 auf der Schmerzskala.

Des Weiteren klagte er über Lethargie, Fatigue, Flatulenz und beidseitige Cephalgie. Die vegetative Anamnese sei bis auf Insomnie (insbesondere beim Durchschlafen) und Steatorrhö unauffällig.

Familienanamnese:

- Vater: Verstorben (unbekannt woran), keine VE
- Mutter: Verstorben (unbekannt woran), keine VE
- Geschwister: 2 gesunde Brüder
-

Sozialanamnese:

- Familienstand: verheiratet, wohne zusammen mit seiner Frau.
- Arbeit: Bauer
- Kinder: 3 gesunde Kinder
-

Die Reiseanamnese sei leer und der Impfstatus sei vollständig.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Zöliakie hin. Differentialdiagnostisch kommen Kolonkarzinom, Reizdarmsyndrom, Giardiasis und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen in Betracht.

Zur weiteren Abklärung der Beschwerden würde ich folgende diagnostische Maßnahmen einleiten:

- körperliche Untersuchung, DRU
- Labordiagnostik (dBB, CRP, BSG, Anti-Transglutaminase-IgA, gesamt-IgA, Stuhlprobe und -kultur, CEA, CA19-9, okkultes Blut im Stuhl)
- ÖGD mit Biopsieentnahme aus dem Duodenum.

- ggf. Koloskopie, ggf. Abdomensonografie (um DD auszuschließen) Falls die Verdachtsdiagnose bestätigt wird, schlage ich folgende Therapie vor:
- Verzicht auf glutenhaltiges Essen
- Ernährungsberatung

07.05.2024 Leberzirrhose

Die Kommission war sehr nett.

Schulze Peter, 46 J, 181 cm 86Kg

Pt. kommt wegen diffusen Bauchschmerzen und Bauchvergrößerung seit 3 Monaten. Er klagt über Nausea und 5 Kilo Gewichtszunahme. Keine Allergie/keine Unverträglichkeit Nikotin : Nichtraucher, Alkohol: 8 Flaschen Bier täglich + 700 ml Schnaps. (Vodka Gorbatschow) 🍷 Drogen: keine Familie: Eltern gesund, Einzelkind Sozialanamnese: Straßenbauer Geschieden, 2 Kinder (kein Kontakt) Vegetative Anamnese: Gewichtszunahme, Insomnie VE: unklare Lebererkrankung schon bekannt. Z.n Unterschenkelsfraktur Re. Mit 15 J. Medikamente - Paracetamol 500 mg bB

AAG: Patientenvorstellung: nur wichtige Informationen VD und DD? KU - auskultation, percussion, palpation. Labor - BB, Leberwerte, Koagulation parameters Ultraschall- was kann man sehen? Elastographie. Aufklärung - Magenspiegelung, Diagnose und Therapie

Therapie- Alkoholkarenz Transösophageale Sclerisierung der Ösophagialen Venen und Parazentese Leber Transplantation

Fachbegriffe - ANKI oder wie in Protokollen für Karlsruhe + iatrogen

07.05.2024 Cholezystolithiasis

Herr Hans Müller ist ein 41 jähriger Patient der sich heute Morgen bei uns wegen seit 6 Monaten aufgetretener intermittierender stechender rechtseitiger Oberbauchschmerz mit Ausstrahlung in die rechte Schulter vorgestellt hat

Die Schmerzen sein 10/10 nach dem Essen

Der Patient berichtete über mehrere Episoden seit 6 Monaten

Ibuprofen nicht geholfen

Es gebe fettes Essen als Auslöser für diese Schmerzen

BS : Pyrosis, Übelkeit, Vomitus (1 / 2 Mal) manchmal Fiber (unregelmässig)

Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine Obstipation

Als Vorerkrankungen leide er an arteriellen Hypertonie sowie Hyperlipidämie In Bezug auf die Medikation nehme er Ramipril 1.0.0 und Simvastatin 1.0.0 ein (die Dosierung sei unbekannt)

Er trinke Wein 1Mal pro Woche Er rauche nicht, keine Allergie

Familien Anamnese ist unauffällig

Die anamnatische Angaben am ehesten auf eine Cholezystolithiasis hin

Reaktionen: Was habe ich , kann ich jetzt gehen ?

AA Gespräch:

VD? Labor untersuchung ?

Wie können wir zwischen cholezystitis und cholezystolithiasis unterscheiden ? (Fiber , schüttelfröst, Labor)

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Pyrosis und VD ? (Nein) , und mit Vomit (ja)

Therapie Wenn es auch keine Stein in Sonographie gibt (ich habe gesagt nur eine Oralhydratation , der Arzt hat mir gesagt nein wir müssen auch eine Op machen)

Aufklärungen : Cholezytectomy

07.05.2024 Leberzirrhose

Die Kommission war dieselbe wie gestern. Die Ärzte waren sehr nett, der Richter eher kalt. Lass euch davon nicht verunsichern.

Schulze Peter, 46 J, 1m90, 86Kg Hausarzt: Dr Müller

Er kommt wegen diffusen Bauchschmerzen und Bauchvergrößerung seit 3 Monaten. Er klagt über Völlegefühl, Nausea und Diarrhöe. Keine Allergie/keine Unverträglichkeit Nikotin : hat 10 PY geraucht , Alkohol: 8 Flaschen Bier täglich seit 20 J. Und 3/4 von Schnaps. Drogen:0 Familie: Eltern gesund, Einzelkind Sozialanamnese: Straßenbauer Geschieden seit 10 J., 2 gesunde Kinder

Vegetative Anamnese: Gewichtszunahme, Inappetenz , Insomnie

VE: unklare Lebererkrankung schon bekannt. Z.n Unterschenkelfraktur vor 15 J. Medikament: nur Paracetamol 500 mg bB

AAG: Patientenvorstellung, welche VD und DD? Aufklärung für eine Magenspiegelung, Wie diagnostiziert man eine Aszites ? Welche Laborparameter bestimmt man bei einer Leberzirrhose? Was ist eine Varize?

Fachbegriffe wie in ANKI, nur makroskopisch war neu.

06.05.2024 pAVK

Mein Fall war pAVK wie im Protokoll. Die Ärzte waren nett, aber der Richter war nicht so freundlich. Wir waren zu dritt, und wir sind alle durchgefallen.

Eigentlich dachte ich, ich hätte die Prüfung gut gemacht und bestanden, aber die Kommission sagte, dass ich 1-2 Monate hospitieren müsse.

02.05.2024 zervikaler Diskusprolaps

Der 51-jährige Patient, Herr Josef Stelzer, stellte sich heute bei uns wegen seit 4 Wochen bestehender, ziehender, zervikaler Dorsalgie vor. Die Schmerzen würden in den Schulterbereich beiderseits und in den linken Arm ausstrahlen. Auf einer Schmerzskala seien sie bei 7-8/10. Sie seien entstanden, als der Patient vor 4 Wochen schwere Gegenstände gehoben habe. Dagegen habe er Tabletten von Ibu 400mg eingenommen. Letztes Mal war vor 2 Stunden. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Parästhesie,

Hypästhesie und Parese wurden verneint. Er rauche seit 35 Jahren ca. 20 Zigaretten/Tag. Er trinke eine Flasche Bier abends. Der Drogenkonsum wurde verneint. Er treibe keinen Sport regelmäßig. Als Vorerkrankungen gab er COPD und Cholezystitis an. Er verwende täglich morgens ein Spray Spiriva (1 Hub). Er nehme regelmäßig Lorano wegen der Hausstauballergie ein (an die Dosierung erinnere er sich nicht, die Medikamentenliste soll mit seinem Hausarzt besprochen werden). Vor 4 Jahren sei bei ihm Cholezystektomie durchgeführt worden. Mit 14 Jahren sei er wegen Appendizitis operiert worden. Die Bluttransfusion wurde verneint. Er reagiere allergisch auf dem Hausstaub. Die Allergie äußere sich mit allergischer Rinitis und allergischer Konjunktivitis.

Er sei vollständig geimpft bis auf den letzten Impfstoff gegen FSME.

Er sei in letzter Zeit nicht gereist.

Bezüglich der Familienanamnese sei seine Mutter an einem Pankreaskarzinom gestorben. Sein Vater lebe noch und sei über 90 Jahren alt. Keine chronischen Erkrankungen seien bei ihm unserem Patienten bekannt (vermutlich Demenz?). Er sei ein Einzelkind. Er habe zwei gesunde Kinder. Er lebe in einem Haus mit seiner Ehefrau zusammen.

Fachbegriffe: Radiatio Anomalie Scapula Clavikula Morbidität Hyperthyreose Myositis Sarkoma Mastektomie Letalität Hypovolemie Nephrolithiasis

Ich habe die Prüfung bestanden. Die Prüfer waren sehr angenehm.

02.05.2024 Kolonkarzinom

30.04.2024 Refluxkrankheit

Hans Schmidt 50 JA 95 kg 179 cm stellt sich wegen seit 2 Monaten brennender retrosternaler Schmerzen vor, 3-4/10 auf einer Schmerzskala. Beim Liegen und beim Verzehr von scharfem Essen, Alkohol und Kaffee schlimmer geworden. Begleitsymptome: trockene Husten Pyrosis. Rauche 0.5 Schachtel Zigaretten pro Tag seit 30 Jahren. VE KHK Hypercholesterinämie VO Cholezystektomie Keine Allergien Medikamente Betalocok Simvastatin und Pantoprazol b. B. FA Vater KHK Mutter Diabetes Bruder Speicheldrüsenkrebs Schwester MS SA Angestellter bei der Ärztekammer, verheiratet, einen gesunden Sohn. Fachbegriffe Cerumen Hemianopsie Tic Pertussis Schlafapnoe Urethra Präfinal (12 Fachbegriffe) Die Prüfer waren seeeeehr nett, 2 Ärzte und ein Rechtsanwalt. Einfacher als erwartet

18.04.2024 obere intestinale Blutung

Alles war wie in der Protokolle. Keine neue Fachbegriffe. Die Fragen waren wie immer: VD, DD, was spricht dafür und was dagegen, diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Aufklärung ÖGDS.

16.04.2024 Osteoporose

Herrn Rainer Hober, 55 Jahre alt, 1,83 m groß und 83 kg schwer. Seit gestern leidet er unter plötzlich auftretenden ziehenden und stechenden Brust-Wirbelsäulenschmerzen ohne Ausstrahlung, die sich im Verlauf verschlechtern haben. Die Schmerzen sind beim Bewegen 7 von 10 und in Ruhe 4 von 10. Es gab keine erkennbaren Auslöser, Trauma oder Verletzungen. Vor einigen Jahren wurde bei ihm Osteoporose diagnostiziert, jedoch wurde keine Behandlung durchgeführt. Zusätzlich leidet er unter morgendlichem Husten und Müdigkeit. Seine Vorerkrankungen umfassen Typ-2-Diabetes, der mit Metformin 1000 mg 1-0-1 behandelt wird, sowie eine frühere Oberschenkelfraktur, die mit Nagelosteosynthese behandelt wurde. Er hat

eine Nussallergie, die zu Schluckbeschwerden führt, und raucht seit 20 Jahren 20 Zigaretten pro Tag. Sein Alkoholkonsum beträgt 1-2 Gläser pro Abend. Der Vater hatte einen Schlaganfall, und die Mutter leidet im Alter von 80 Jahren ebenfalls an Osteoporose.

Reaktion: Was werden Sie für mich tun? A A: Nur persönlichen Daten erfassen und dann gezielte Fragen stellen: Was hat der Patient? Seit wann? Gibt es einen Auslöser? Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Welche Differentialdiagnosen erwägen Sie? KHK+++

Welche Risikofaktoren liegen vor? Handelt es sich um primäre oder sekundäre Osteoporose? Welche Maßnahmen und Therapien werden empfohlen?

keine Aufklärung Fachbegriffe : Macroglossie, Katarakt, Mastitis ,Urethra

Bestanden ♥

16.04.2024 akute Pankreatitis

Karl Franke , 39J , epigastrische Schmerzen mit Ausstrahlung in den Unterbauch sowie in die Flanken) BS : Diarrhoe(2Mal, flüssig) VA: Inappetenz Reaktionen : Was habe ich? Was werden Sie für mich machen? Sollte ich hier bleiben?

A A Gespräch Nur aktuelle Beschwerden, dann sofort zur Fragen : Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Differentialdiagnosen? Riskofaktoren? Maßnahmen und Therapie?

Was müssen wir auf Therapie des pankreatitis achten? Keine Aufklärung

Fachbegriffe: Alveolen ventral Dialyse I.M Ödem Präfinal Subkutan Bursitis Neoplasma

15.04.2024 Depression

gleich wie das Protokoll

Fachbegriffe Ökonomie Induratio Nukleus Myopie präventiv Progredient Kontusion Keratitis Rabies STIKO

08.04.2024 Divertikulitis

Der Chefarzt war der Patient.

Herr Klaus Maier 57 J, seit 1 Woche bestehende linksseitige Schmerzen im Unterbauch mit Ausstrahlung in das linke Bein. Die Schmerzen seien pochend/bohrend und dauerhaft im Verlauf. Hätten eine Intensität von 7/10. Keine Rötung/Ödem auf der betroffenen Stelle. Ich habe nach eine Beule gefragt ob es sich um eine Hernie handelt und er hat gesagt ja, ich glaube schon.. und wenn ich drauf drücke tut es mehr weh. Danach hab ich gefragt ob die Beule gehts nach innen und bleibt da oder kommt es raus wieder nach Ausüben des Drucks und hier hat der P gesagt okay es gibt keine Beule um mich nicht mehr zu verwirren und gelächelt. (Die sind echt nett und tun alles mögliche zu helfen) Also am Anfang war es ein bisschen chaotisch. Fieber betrug 38.5.

Abwechselnde Diarrhö und Obstipation.

Nachtschweiß mit nassem Schlafanzug und Haare. Keine Gewichtsabnahme. Insomnie wegen Schmerzen.

Op: Appendektomie VE: MI mit PTCA und Stenteinlage, arterielle Hypertonie Rauchen mit 20 py
Regelmäßiger Alkoholkonsum von 1 Glas Rotwein am Wochenende

FA: Vater an Kolonkarzinom gestorben. (Wegen Nachtshweiß und Fieber war ich hier auch verwirrt) Mutter: DM

Lehrer. Verheiratet. 2 Gesunde Kinder.

Dann bin ich alleine in ein anderes Zimmer für Dokumentation gegangen.

Habe ich nur 2-3 Sätze gemacht für Vorstellung. Sie haben nach Koloskopie gefragt. Wann empfehle ich? Nach Abklingen der Beschwerden mit Antibiotikagabe. Welche? Für gram negative und anaerob aber die Name weiß ich nicht. Sehr gut, kein Problem. Das war es. Keine Aufklärung. Der Oberarzt hat gesagt, dass er am Anfang auch an eine Hernie gedacht habe. Wir haben über Sport gesprochen. (Nach meine persönlichen Angaben) sie haben mir gefragt wo ich wohne und ob ich eine Vorstellungsgespräch gemacht habe. Wie hab ich meine Sprache verbessert usw. Sie machen auch viiele kleine Witze. Das war mir seeehhrr klar dass man nicht viele medizinische Kenntnisse braucht um FSP zu bestehen. Sie können einfach „ich weiß nicht“ sagen und das wäre ganz okay. Sie beantworten die Fragen selbst 😊 Aber man muss Strukturiert sein. Ganze Sätze im Anamnesegeespäch benutzen, eine gute Dokumentation machen. (Ich konnte über Therapie Empfehlungen nicht schreiben weil ich kein mehr Zeit hatte, aber gar kein Problem) Dann ist die Prüfung fertig für sie und sogar Patientenvorstellung oder mehrere Frage nach dem Fall ist nicht mehr notwendig.

Fachbegriffe: Pankreas okzipital Dekubitus Rektoskopie

Sugillation (der Chefarzt hat gesagt niemand braucht dieses Wort)

08.04.2024 Ösophaguskarzinom

Herr Schuster, Otto 54J, 01.03.1970, 54kg keine Allergie 20Zig/Tag seit 30 Jahren 10 Flaschen Bier täglich kein Drogenkonsum Bauarbeiter, geschieden, kein Kind, lebe allein Vater: eine Herzerkrankung Mutter: DM ein Bruder: Prostatakarzinom (wurde operiert)

Seit 3-4 Wochen bestehende drückende nahrungsabhängige retrosternale Schmerzen sowie Dysphagie keine Auslöser Gewichtsabnahme von 2 kg innerhalb einer Woche Nur mit flüssiger Nahrung könne er sich ernähren. Er habe früher unter Pyrosis gelitten, aber jetzt habe er keine Pyrosis. Die Fragen nach ähnlichen vorherigen Beschwerden, Fieber, Nachtschweiß, Meläna, Nausea und Emesis wurden verneint. Bis auf morgendliche Tussis ist die vegetative Anamnese unauffällig. VE: DM, aHT, Gicht keine Op Med: Janumet 50/850mg 1-0-1, Beloc-Zok ?mg 1-0-0 keine Reise

A-P: Was habe ich? Soll ich hier bleiben? Kann ich jetzt 2 Flaschen Bier am Kiosk holen?

A-A: VD? DD? Risikofaktoren (Zigaretten und Fleischkonsum)? Wichtigste Untersuchung(ÖGD)? Therapie? Chirurgische Therapie? Welches Typ von Karzinom (Plattenepithelkarzinom)? Wenn es inoperabel ist(Palliative Therapie, Chemo-Radiotherapie)? Keine Aufklärung

Fachbegriffe: Ösophagitis Ulcus cruris Femurfraktur Osteosynthese Arteria poplitea Defibrillation Body Mass Index Kachexie Anämie Physiotherapie

Die Kommission war sehr nett. bestanden ✓

04.04.2024 obere gastrointestinale Blutung

Herr Keller, Peter 50 J, 09.02.1974, 79 kg, 1,75 m

Allergie/Unv: Glutenunverträglichkeit

Noxen: 20 Zigaretten täglich seit seinem 16. Lebensjahr 2-3 Flaschen Bier täglich und gelegentlich Schnaps
seit 35 Jahren kein Drogenkonsum kein Sport

Sozialanamnese: verheiratet, 4 gesunde Kinder, habe ein Bauunternehmen

Familienanamnese: Die Mutter-Apoplex Der Vater-gesund Der Bruder-MI

Aktuelle Anamnese: Der 50-jährige Patient, Herr Peter Keller, stellte sich aufgrund seit über 2-3 Wochen bestehender progredienter krampfartiger nahrungsabhängiger Abdominalgie im Epigastrium ohne Ausstrahlung sowie seit heute Morgen bestehender zweimaliger Hämatemesis bei uns vor. Die Schmerzen seien auf einer Skala von 0--10 bei 7 einzuordnen. Er verspüre eine Besserung nach der Einnahme von Ibuprofen 600 mg und nachdem er etwas getrunken habe. Die Reduzierung des Rauchens verschlimmere die Schmerzen. Ferner klage er über Pyrosis, Nausea und Schwindel. Bis auf Meläna seit 2 Tagen, Inappetenz, Insomnie und Stress bei der Arbeit ist die vegetative Anamnese unauffällig. Als Vorerkrankungen seien bei Herrn Keller aHT und Hyperlipidämie bekannt. Eine Kreuzband-OP sei ihm mit 18 durchgeführt worden. Die Medikamentenanamnese ergab die Einnahme von Beloc, Metoprolol und Ibuprofen bei Bedarf. Er sei standardmäßig geimpft.

Reaktionen: -Was habe ich? Ich habe ein Unternehmen, soll ich hier bleiben? -Ich habe zugenommen, als ich mit der glutenfreien Diät begonnen habe. Es würde nicht schaden, etwas abzunehmen. Kann ich mich wieder glutenhaltig ernähren? -Was machen Sie jetzt?

AA Gespräch: Patientenvorstellung, hat er eine Herzerkrankung? Warum habe ich gefragt? (ASS!) Was machen wir? (stationäre Aufnahme, Zugang legen, Blut entnehmen, körperliche Untersuchung, ÖGD...), Therapie, keine Aufklärung. Die Kommission war sehr nett.

Fachbegriffe: Diabetes Mellitus Perikarditis Perfusion Fragment Cochlea Clavicula Kryochirurgie
Lungenatektase Gravidität dorsobasal Muskelatrophie

bestanden

04.04.2024 Angina pectoris

Herr Joachim Schulze stellte sich heute wegen seit heute Morgen früh bestehender zunehmender belastungsabhängiger rezidivierender Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm vor. Die Schmerzen würden sich genau unter den Claviculae befinden. Die Schmerzen seien nach einem Streit mit seinem Nachbarn aufgetreten. Die Schmerzintensität liege bei 9/10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen würden sich bei Belastung verschlechtern und sich in Ruhe verbessern.

Einen Myokardinfarkt wurde während der Anamnese ausgeschlossen: EKG und Herzenzymen

Der Patient gab an, ähnliche Beschwerden früher gehabt zu haben.

Zusätzlich klagte der Patient über Todesangst, belastungsabhängige Dyspnoe, Insomnie wegen ständiger Gedanken, trockenen morgendlichen Husten, Obstipation und Meteorismus seit langer Zeit.

Die Fragen nach Tachykardie, Nausea, Emesis und Inappetenz wurden verneint.

Der Patient leide an: arterieller Hypertonie seit 10 Jahren, Diabetes Mellitus seit 10 Jahren, rezidivierende Zervikalgie, Schulterschmerzen und sporadische Gastritis.

Keine Voroperation sei bei ihm durchgeführt worden.

Er nehme Ramipril 5 mg 1-0-1, Metformin 1000 mg 1-0-1 und Hydrochlorothiazid 12,5 mg 1-0-0 regelmäßig und Abführmittel b.B. ein.

Pollinose: Rhinoconjunctivitis allergica. Keine Unverträglichkeiten

Er rauche 1 Packung/Tag seit 20 J und wollte damit nicht aufhören Alkohol- und Drogenkonsum: verneint

Familienanamnese: Großmutter (väterlich): an Kolonkarzinom gestorben Vater sei vor 5 J an Myokardinfarkt gestorben Mutter: gesund Keine Geschwister

Sozialanamnese: Lehrer von Beruf: Stress bei der Arbeit Geschieden: er war daher froh Alleinlebend Treibe keinen Sport

AA-Gespräch:

1- Verdachtsdiagnose 2- Fragen nach der Beschwerden: Wo genau? Ausstrahlung? Beschreibung der Schmerzen? 3- Risikofaktoren: Adipositas, Rauchen, aHT, ähnliche Beschwerden früher gehabt, Vater an Myokardinfarkt gestorben. 4- Zusammenhang zwischen den Beschwerden und dem Husten? Lungenembolie, rechte Herzinsuffizienz (Differenzialdiagnosen) 5- Was erwartet man in der körperlichen Untersuchung bei rechte Herzinsuffizienz? Zyanose, Ödeme, Erweiterung der Halsvenen (Halsvenenstauung). 6- Was würden Sie zuerst erledigen, PTCA oder Belastungs-EKG? PTCA. Bei kHK kann eine Belastungs-EKG einen Myokardinfarkt verursachen. 7- Erklären Sie, was wir bei einer PTCA machen. 8- Was für Medikamente soll der Patient nach einer PTCA einnehmen? Antikoagulantien

Fachbegriffe:

- Struma nodosa
- fluktuierend
- Interruptio
- Pleura
- Rezidiv
- Phlebitis
- Aphthen
- Subfebril - Urämie

26.03.2024 Divertikulitis

Franz Wehner 67j dumpfer , druckender Unterbauch schmerzen links ohne Ausstrahlung. 4 bis 6 von 10 Langsam aufgetreten seit 3 Tagen, im Verlauf verschlechtert. Nausea , meteorismus

ähnlichen vorherigen Beschwerden vor 4montagen Fiber nicht gemessen , Schüttelfrost, schwitzen Inappetenz Schmerzbedingte insomnie Chronische Obstipation Wasserige diarrhoe seit 3 Tagen (ohne Blutspuren) Allergie : Nickel Chrom Nicht Raucher 1bis 2 Gläser Wein Abends Hypercholesterinämie

Coxarthrose Chronische dorsalgie OP: cholezystectomy (zn: cholezystitis) Vater : an apoplex gestorben
Mutter: DM Verkäufer , verheiratet, 2 gesunde Kinder Stress bei der Arbeit.

Fragen : Patienten vorstellen -was hat er über seine Obstipation erzählt ? Ist er in Ruhe Phase ? -warum nimmt er Voltaren ein ?

- was hat sein Vater? -wie alt ist er ?
- welche Vorerkrankungen hat er?
- welche op?
- Diagnose? Differenzialdiagnose?
- warum Divertikulitis und nicht kolonkarzinom? _ was machen Sie bei körperliche Untersuchung (DRU + Abwehrspannung)
- Labor ? was erwarten Sie? _ welche Apparat? _warum keine Koloskopie?
- Therapie? Welche antibiotika? _ bei rezidivierende Divertikulitis, was machen sie? (Elektive OP) , welche op? (Partielle hemikolektomie).

Ich habe die Verdacht Diagnose dem Patientien während der Anamnese mitteilen, und was zu tun ist , deswegen habe ich keine Aufklärungen beim Arzt Arzt Gespräch.

26.03.2024 PAVK

Der Patient war der Walter Vögel, 74 Jahre alt, bringt 87 Kilo auf die Waage. Der kam zu mir, weil er seit 6-8 Monaten Schmerzen im rechten Unterschenkel hat. Die Schmerzen kamen und gingen und sind mit der Zeit schlimmer geworden. Wenn er saß, ging's ihm besser, aber beim Laufen wurde es echt mies. Beim Chillen waren die Schmerzen bei ner Null von 10 und beim Laufen ne satte 7. Hab ihn gefragt, ob er Kribbeln, Taubheitsgefühle, Lähmungen, Hautveränderungen, ob er sich verletzt hat, lange unterwegs war, ob's geschwollen, rot oder warm war – aber nix davon.

Der Mann hat seit 12 Jahren Bluthochdruck, seit 7 Jahren Probleme mit dem Cholesterin, hatte vor 8 Jahren nen Herzinfarkt und vor 15 Jahren ne OP wegen nem Bandscheibenvorfall. Auf Penicillin reagiert er mit Ausschlag, also Finger weg davon. Er raucht 30 Kippen am Tag, schon seit 15 Jahren, und kippt täglich sein Feierabendbierchen, schon ewig lang. Drogen? Hab ich vergessen zu fragen.

Beruflich war er Busfahrer, ist verheiratet und hat zwei fitte Kids. Sein Alter ist an nem Herzinfarkt gestorben und seine Mutter an Lungenkrebs.

Beim Arztgespräch ging's dann rund:

- Was ich als Diagnose auf dem Schirm habe
- Was sonst noch infrage kommt
- Was der Unterschied zwischen PAVK und TVT ist
- Dem Walter erklären, was er hat, wie's weitergeht und was für Behandlungen es gibt
- Dann noch nen Schnack über die Duplex-Sonographie und die PTA halten.

16.03.2024 Anorexia nervosa

16.03.2024 Diabetes Mellitus Typ 1

Herr Josef Meyer Alter:24 KGr:167 KGw:75 LS: Müdigkeit seit 9 Monaten BS: depressive Stimmung Durchschlafstörungen Vermehrtes Durstempfinden Nykturi Gewichtsabnahme 6-7 Kilo in den letzten 9 Monaten Pruritus (ganze Körper) Dermatomykose VE: — OPs: einer OPs durch Osteosynthese wegen Ellenbogen Fraktur vor 3 Jahren Allergie : gegen Hasel Nüsse und polinozis—allergische rhinitis und Tränen Augen Medikament: keine R.A. Unauffällig Impfpass sei komplette Noxen: 10 Zigarillo pro Monat mit 18. Lebensjahr Ein Flasche Weiß Wein pro Woche Drogenanamnese: u.a. Familienanamnese: Mutter—DM Typ 2 und PaVK Vater: HI als Todesursache mit 65 Einen Bruder: keine relevanten Angaben Eine Schwester: hyperthyreose Sozialanamnese: alleinstehend keine Kinder BA: Student

VD: Diabetes mellitus Typ 1 DD: Anämie Depression Hyperthyreose Körperliche Untersuchungen Lab: Blutbild zwecks Anämie auszuschließen Entzündungsparametern Glucose } zwecks Bestätigung von DM HbA1c } zwecks Bestätigung von DM C - peptid Leber - Nieren werte Urin Status } zwecks Nachweis von Keton Schilddrüse Hormonspiegelung }zwecks hyperthyreose auszuschließen Apparat: Schilddrüse Sonographie Therapie : stationäre Aufnahme Insulin Schulung Ernährungsberatung Patient- Arzt: was habe ich? Arzt - Arzt: Was ist die VD? Rizikofaktoren? Labor Parametern? Warum sind C-Peptid und Urin Status wichtig? Diagnostische Kriterien von Diabetes mellitus ? Akute und chronische Komplikationen ? Warum ist die Schulung wichtig und nötig? Aufklärung: Patient hat gefragt: muss ich Insulin spritze benutzen? Meine Mutter nimmt Tablette. Ist es möglich dass ich eine Tablette nehme? Fachbegriffe: Ulcus ventriculi Struma Aneurysma Pneumonektomie Menopause Asthma Epigastrisch

14.03.2024 Cholezystolithiasis

Herr Klaus Müller ist ein 41 jähriger Patient der sich heute Morgen bei uns wegen seit 6 Monaten aufgetretener intermittierender Krampfartiger Ober Bauch Koliken (Schmerzen) Rechts ohne Ausstrahlung vorgestellt hat

Die schmerzen würden plötzlich auftreten dann eine Stunde dauern

Der Patient berichtete über ungefähr 3 Episoden wöchentlich seit 6 Monaten

Es gebe fettes Essen als Auslöser für diese Schmerzen

Die Fragen nach Ikterus Fieber oder Ausstrahlung in den Schulter wurden verneint

Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf eine Obstipation sowie eine Schmerz bedingte Insomnie

Als Vorerkrankungen leide er an arteriellen Hypertonie sowie Hyperlipidämie

In Bezug auf die Medikation nehme er Ramipril 1.0.0 und Sinnvastatin 1.0.0 ein (die Dosierung sei unbekannt)

Er trinke Wein 1Mal pro Woche, Keine Allergie, und Familien Anamnese ist unauffällig

Die anamnatische Angaben deuten am ehesten auf eine Cholezystolithiasis hin

DD: Cholezystitis Gastritis und Kolon irritabile

Reaktionen: Was hat Drogenkonsum mit meiner Schmerzen zu tun ? Was wurden Sie machen?

AA Gespräch: Was spricht gegen cholezystitis? Könnte es Ulkus sein? Warum ? Warum haben Sie Kolon irritabile erwähnt? Was ist Murphy Zeichnen?

Aufklärungen : Sonographie ERCP Cholezytektomie

Der Patient hat sogar gefragt: Ist ERCP gefährlich? Bei der OP, werden ich Vollnarkose bekommen? Wurden Sie ein Schnitt in meinem Bauch machen? Wie groß? 3 ? Warum 3 ? Wie lange soll ich denn in Krankenhaus bleiben?

Bestanden. Viel Erfolg

12.03.2024 Kolonkarzinom

Der Patient hatte Unterbauchschmerzen, Völlegefühl, Obstipation und Gewichtsabnahme. Vater ist an einem Kolonkarzinom gestorben. Fachbegriffe wie im Protokoll. Keine schwäbisch.

Aufklärung: CT, Koloskopie und digital rektale Untersuchung

Reaktion: Bier ist kein Alkohol, was habe ich, werde ich sterben ?

A-A: Diagnose, DD, warum auf der Suche nach Tumormarkern, würden sie eine Operation durchführen ? Wie und warum ?

bestanden

29.02.2024 zervikaler Diskusprolaps

22.02.2024 obere gastrointestinale Blutung

Mein Fall war Obere gastrointestinale Blutung, die Symptome waren genau wie in den Protokolle. Seit gestern bestehende stehende, progredienter, nahrungsabhängige Epigastralgie/Oberbauch (NRS 8/10) mit Strahlung in den ganzen Abdomen. Begleitsymptome: Hämatemesis (Bluterbrechen), Meläna (Schwarzer Stuhl). Risikofaktoren: Einnahme von Ibuprofen, viel Kaffee, Alkohol und scharfes Essen.

So die Diagnose war ganz klar. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, die Blutung zu finden und die Differenzialdiagnose auszuschließen. Zum Beispiel Vorgeschichte über Ulkus Peptikum oder nach Risikofaktoren fragen.

- Ulcus (Estress, schlecht Diät oder lange Zeit ohne Essen, epigastralgie in der Vergangenheit, Ulcus ventriculi va duodeni, Schmerzen vor, während oder nach Ernährung Abnahme, und so weite)
- Cholecystitis (was genau haben Sie gegessen, bevor die Schmerzen auftraten, fettreich essen? Haben sie Dyslipidämie, Ictericia (gelbe Sucht)
- Pankreatitis : Strahlung in den Flanken und so weiter.

Brief Es war nicht Perfekt, aber es war genug. Ich denke, es ist wichtig eine vollständigen Brief zu schreiben, bis zu Ende (Therapiemaßnahme).

Arzt-Arzt gespräch Ich habe den Patienten vorgestellt und dann hat der Oberarzt gefragt: -Verdachtsdiagnose

- Differentialdiagnose -Die wahrscheinliche Ursache der Blutung. -Untersuchungsmethode zum Ausschluss einer DD, zur Bestätigung meiner VD und zur Ermittlung der Blutungsursache.

Aufklärung: Abdomensonographie und ÖGD

Reaktion

- Trinke ich viel Alkohol, ist es nicht normal? (1 Flasche Bier jeden Tag seit er 18 Jahre alt war) Rauche gleiche Reaktion
- Mein Alkohol oder Tabakkonsum hat mit meinen Beschwerden etwas zu tun?
- Was habe ich? etwas schlecht?
- Warum stellen Sie so viele Fragen?

Fachbegriffe

Neu Genom, alles andere steht im Protokoll der FSP Karlsruhe. z.B Genu, Karenz, Hypophyse, Hyperkaliämie.

Meinen Empfehlungen: Meine Prüfungen waren 3 nette Männer. Meine Prüfung war nicht perfekt, mein Brief war auch nicht perfekt. Das Wichtigste ist, gut mit den Patienten kommunizieren und die richtigen Fragen stellen, trotzdem habe ich ein Paar vergessen.

-Sicher sein, in Augen sehen, mit der Patienten, Oberarzt sprechen, sie sind nur Menschen. Es ist ein Aufnahmegespräch, nicht nur Fragen stellen. -Erstellen Sie eine Liste verschiedener Krankheiten, die fast die gleichen Symptome aufweisen, oder nach Abteilungen und finden Sie Unterschiede. Fragen Sie in der Anamnese genau nach diesen Unterschieden, um eine DD auszuschließen und im Arzt-Arzt-Gespräch Gesprächsstoff zu haben.

Beispiel: -Osteoporose (Rückenschmerzen ohne Sensibilität oder Motikstörubg) Gonarthrose gleich, aber in Knie- und Vorgeschichten für körperliche Belastung sportlich. -Hernia Diskusprolaps (Rückenschmerzen mit sensibilitätsstörung, Hypästhesie, Parästhesie etc)

Im Allgemeinen war die Prüfung sehr einfach, Sie werden es schaffen, viel Glück an alle.

Für Erklärungen habe ich folgende Methode entwickelt:

1. Was ist die Untersuchung (invasive, nicht invasive, schmerzlose, Röntgenstrahlung frei und so weiter) Bildgebende Verfahren...
2. Das Ziel für die Untersuchung in Verbindung mit der Verdachtsdiagnose (Ihre inneren Organe darstellung und eine Blutung zu sehen ...)
3. Vorbereitung für die Untersuchung
4. Verlauf für die Untersuchung
5. Komplikationen und Risiko
6. Was kann oder was können die Patienten nach der Untersuchung machen (Autofahren, essen, bleiben Sie ein paar Stunden bei uns, um zu beobachten.)
7. Welche Symptome sind normal nach der Untersuchung und mit welche sollte sie sich bei uns anmelden.

Also haben sie mich nicht einmal gefragt. Als ich wegen der Komplikationen dort war, sagte mir die Kommission sogar, dass genug sei und ich nicht mehr reden müsse.

15.02.2024 [Ulcus ventriculi](#)

15.02.2024 [Polymyalgia rheumatica](#)

12.02.2024 Laktoseintoleranz

Patient: Name: Herr Peter Novak, Alter: 29 J. Gewicht: 66 kg Größe: 1,79 m

Noxen Nichtraucher; Trinkt gelegentlich Wein

Familienanamnese Vater: mit 50. Lebensjahr an Magenkarzinom gestorben Mutter: gesund Tochter: Neurodermitis

Sozialanamnese Verheiratet; Drei Kinder

Beschwerden: Der Patient klagte über Blähungen und Durchfall (wässrig, dünn) Seit ein paar Jahren, Die mit Milchverzierung verbunden. Die Beschwerden sind mit diffusen kolkartigen Bauchschmerzen verbunden. Die Schmerzintensität gab der Patient mit 5/10 auf der Schmerzskala.

Vegetative Anamnese: unauffällig Vorerkrankungen: keine Bekannte Erkrankungen Medikamente : er nimmt keine Medikamente Operationen: Appendektomie mit 12 J. + Unterschenkelfraktur (konservativ behandelt) mit 18 J.

Arzt-Arzt Gespräch

Ich hat der Patient nicht vorstellen. Nur Fragen/Antworten

Der Arzt mir die folgenden Fragen gestellt:

Diagnostische Maßnahmen? Therapie? DD? Wie können Wir die DD ausschließen? Der Patient hat die Beschwerden seit Jahren, warum hat er sich jetzt gestellt? Der Patient ist untergewichtig, woran das liegen kann?

Begriffe: (Ich erinnere mich nicht an alles) Ikterus Sugillation Pankreatitis Emesis gravidarum Hereditär

Die Kommission ist sehr nett und entspannt.

12.02.2024 Depression

Herr Thomas Heidenreich, 55J, 163cm, 66 kg

stellte sich heute wegen seit 10 Wochen bestehender, drückender Cephalgie ohne Ausstrahlung begleitend mit Antriebslosigkeit, Anhedonie sowie Gedankenkreisen bei uns auf der Station vor.

Schmerzintensität 6. Ibu nicht geholfen. Schmerzen morgen stark abend besser.

Auslöser: seine Schwester an Leukämie gestorben.

Keine kontakt mit Freunde. Keine Sport. Keine Lust.

Der Pat gibt an, Suizidgedanken zu haben. (mir ist egal, ob ich lebe oder nicht).

VA: Insomnie, Inappetenz, Verstopfung. (keine Gewichtsveränderung)

VE: aHT seit 7 Jahren. Ramipril 10, HCT 12,5, Adumbran.

FA: Vater hatte Depression, hat sich selbst umgebracht.

Kontusion, Ökonomische, Hämatemesis, Myopie, Malleolus Medialis, Keratitis, Nukleus, Progredient, Gingiva, Induratio, Retina, Prävention

00.02.2024 Leberzirrhose

Anamnese: Der Patient hat seit 3 Monaten Krampfadern im Bauchbereich, die dem Nabel entspringen. Er beschreibt sie ähnlich wie die Krampfadern im Bein seiner Mutter. Er sagt, er hat in letzter Zeit 4 Kilogramm zugenommen. Er kann nicht schlafen wegen dieses Drucks im Bauch.

Begleitsymptome: Übelkeit.

Meine Fragen waren über:

Hautveränderungen: Ja, rote sowie Sonnenzeichen (Gefäßspinnen).

Juckreiz: Ja.

Herzrasen: Nein.

Raucher, Alkoholiker und die restlichen Informationen sowie das Protokoll.

AA Gespräch:

Was hat der Patient?

Was hat der Patient gesagt?

Verdachtsdiagnose?

Was sollen wir durchführen, um Aszites festzustellen? KU (Perkussion).

Differenzialdiagnose?

Was machen wir jetzt? (KU, LU, Sono.)

Wie erklärt sich der Juckreiz?(Bilirubin bewirkt den Juckreiz)

Was ist im Labor wichtig?

Wie sind die Werte? (Hoch)

Und im fortgeschrittenen Stadium? (Normal)

Die Therapie?

Was für Diuretika?

Wie wirkt Spironolacton? (Kaliumsparendes Medikament)

Fachbegriffe: 12. Diese erinnere ich mich an:

Cardia

Reposition

Ulcus duodeni

Hyperthyreose

Endokarditis

Nephritis

Adrenalektomie

00.02.2024

Frau Peter Schmidt ist eine 52 Jährige Patientin ,die sich heute Morgen bei uns wegen seit Gestern augetretener , bestehender , dumpfer Abdominalschmerzen vorgestellt hat . Die Patientin berichtete , die Schmerzen langsam im Region Periumbilikalis begonnen hätten denn in den rechtseitiger unterbauch gewandert seien . Die Smerzintensität wurde mit 6 / von 10 auf einer Smerzskala bewertet . Die Schmerzen seien nich Nahrungsabhängig . Die Frage nach ähnlichen vorherigen Beschwerden wurde verneint . Die Fragen nach Nausea ,, Emesis .. Meteorismus ,, wurden verneint . Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz, sowie Obstipation seit langzeit (deswegen nehme sie hömopatische Abführmittel) . An Vorerkrankungen leide sie an : Arterielle Hypertonie seit 4 bid 5 jahren Hypothyreose seit 4bis 5Jahren in Bezug auf Medikation nehme sie die folgenden Medikament ein : Ramipril 10 mg (1-0-0) I thyroxine 1000ug (1-0-0) es wurde bei der Patientin als sie jugend war Tonsillektomie , vor 10 jahren Cholezystektomie , vor 8 jahren op wegen Tubärgravidität (sie weis nicht welche seite). Familienanamnese : vater : gesund mutter : leide an apoplex und sie wohne im pflegeheim 1 Schwester : leide an Mamakarzinom

- arbeite im Buro , getrennt , habe 2 Tocher
- Nikotin :40 zig /tag seit 20 jahren
- Alkohol : gelegentlich eine Glas Sekt
- Drogen : wurde verneint beim arzt - patient Gespräch : *kann ich eine Zigarette rauchen denn ich komme ? (reaktion) *wenn ich nach Schmerzintensität fragte er hat gesagt : wie kann mann Weiß ? dass passiert nicht und danach er sagte 4,5 hhh *Alkohol ist gud für die Schmerzen(Reaktion) .
- wenn ich nach Nikotinkosum fragte: sagen sie mir nicht ich muss aufhören mein Hausarzt immer sagte so
- was habe ich am ende? Arzt - Arzt Gespräch : patienten Vorstellung bis ende verdachtdiagnose maßnahmen end therapie , differentialgiagnose . -die pateintin kann schwanger sein ?(ja die patient weiß nicht ob sie im wechseljahre oder nicht die periode kommt bei ihr ab und zu nicht regelmäßig) dann was machen wir ? Bhcg und Echo um Schwangerschaft auszuschließen
- Sie ist Frau was könnte auch sein ich sagte Ovarialtorsion der oberarzt sagte nein bei Ovarialtorsion die Patient ist nicht so weil die Schmerzen sehr stark ist , er möchte Adnexitis hören.

Fachbegriff : Menstruation , os frontal , os metatarsal ,, empyem ,, pleurektomie ,, Michel Divertikul , Orchitis , otitis media (die andere ich kann nicht erinnern leide viele wörter nicht auf dem Liste)

00.02.2024 Gonarthrose

69 J Mann 176 cm 68kg

Seit 6 Monaten Bestehender persistierender (auch in der Nacht, ständig) progredienter beidseitiger Knieschmerzen. Ohne Ausstrahlung Begleitet von Ödem & Erythem (manchmal) und eingeschränkte Beweglichkeit Keinen Auslöser Gibt es etwas, dass die Schmerzen lindert oder verstärkt? Nein. Sie sind immer stark. Wird es schlimmer mit körperlichen Aktivitäten, beispielsweise beim Gehen? Nein. Es ist immer stark.

Ibuprofen nicht geholfen Frage nach Trauma, Parästhesie, Hypästhesie, Parese verneint .

3-8 Schmerzskala

Bohrend & brennender

Ohne Steifigkeit

Zeckenstich verneint

Veg: Schmerzbedingte Schlafstörung Trockener morgendlicher Husten Niedergeschlagenheit

Mit dem Rauchen aufgehört. Früher 20PY

Alkohol eine Flasche Bier täglich Keine Drogen (Reaktion: Frau Dr. haben Sie selbst Drogen ausprobiert?)

Vorerkrankungen: •Hyperlipidämie •Z.n. Diskusprolaps konservativ behandelt vor 1 Jahr •Z.n. Hemikolektomie vor 10 J (ein Teil von Dickdarm entfernt wurde) •Tonsillektomie & Appendektomie im Kindesalter Medikamente: •Pantoprazole, Atorvastatin & Ibuprofen

Mutter : Bronchialkarzinom Vater: MI Schwester: Blasenkarzinom

Rentner früher Lehrer in der Fahrschule Verheiratet. 2 Kinder gesund (Reaktion: Frau Dr Sie haben viele Fragen gestellt. Ich habe Schmerzen.)

Allergien habe ich vergessen zu Fragen.

AAG : Meine VD war rheumatoide Arthritis Als DD habe ich Gonarthrose & PMR erwähnt.

Diagnostische und Therapeutische Maßnahmen für RF , Arthrose und PMR.

Keine Aufklärung

Neue Fachbegriffe: Dekade Indolenz Juvenile

08.02.2024 Migräne

Die Kommission besteht aus 2 Ärzte und ein Rechtsanwalt. Die waren sehr nett. Ich hatte einen ähnlichen Fall aus dem Protokoll (19.09.2023).

Herr Paul Kovermann 39 Jahre

seit 2 Tagen, bestehender, plötzlich aufgetretener pulsierender, rechtsseitiger Cephalgie

Begleitende Symptome: Nausea, Emesis (2-Mal), Phonophobie und Lichtblitzen

VE: Venenthrombose im linken Bein vor 10J, behandelt mit Heparin.

Allergie/Unverträglichkeiten: Laktoseintoleranz

Noxen: Raucher 10Z pro Tag seit 20 Jahren. Alkohol 1 Flasche Bier oder 1 Glass Wein jeden Abend, Drogenkonsum wurde verneint.

FA: Mutter: an Hirntumor mit 60 Jahren gestorben Vater: leiden an Demenz und lebt im Heim

DD: Spannungskopfschmerzen, Cluster-Cephalgie, Hirntumor, Meningitis

Diagnostik: 1. KU: Neurologische Untersuchung, Nackensteifigkeit 2. Labor: unauffällig (BB, Elektrolyten, Entzündungsparameter), 2.Bildgebung: CT/MRT des Schädels 3. Der Prufer sagte, wir könnten ein EEG machen, und ich frage mich, was wir bei einer Migräne finden können. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte, und sagte nur, dass wir Befunde sehen könnten, die mit einem Anfall vereinbar sind.

Therapie: 1. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr 2. Analgetika (NSAR + ASS/Sumatriptan) 3. Antiemetika (Metoclopramid) 4. Körperschonung 5. Prophylaxe vorschlagen (propanolol, amitriptilin) 6. Nikotinverzicht

Schwierigen Situationen: Habe ich Krebs? Muss ich hierbleiben?

A-A Gespräch: Ich durfte den beschwerden Teil praktisch ohne Unterbrechung vortragen, ich wurde direkt nach Diagnose und Therapie gefragt. Was sind die klassischen Symptome einer Migräne und wie unterscheiden sie sich von anderen Kopfschmerzen. Was kann ich in Labor finden? Welche Therapie wäre das Beste? Welche Emetika wäre das Beste?

Fachbegriffe: Halluzination, Nephrektomie, Abort, Inkontinenz, Obstipation, chronisch, Pancreatitis, Pulmo, Myocarditis, Rezidiv, Cutis (waren 12 Fachbegriffe)

08.02.2024 metabolisches Syndrom

08.02.2024 Migräne

Begriffe: Germinom, Asepsis, Azidose, Bursitis, Gangrän, Distorsion, Pyelonephritis, Kolektomie, Sedativa, Glaukom, Hemiplegie

25.01.2024 Oberschenkelhalsfraktur

Neuer Fachbegriff: Calcaneus

23.01.2024 rheumatisches Fieber

Reaktion: was habe ich, was machen sie usw. Ich habe gesagt, ich kann noch nicht genau sagen, ich brauche Diagnostisch bla bla aber Patient möchte was hat er. Und der Patient-Arzt, sagte: "Okay, jetzt möchte ich Ihnen vorschlagen. Bitte zögern Sie nicht, dem Patienten die vorläufige Diagnose mitzuteilen. Sie alle sagen, "ich untersuche Sie zuerst und dann werde ich es Ihnen sagen" aber das ist falsch."

Aber er sagte es höflich und es war ein Ratschlag.

Und teil-3 habe ich die Vorstellung gemacht. Chefarzt hat mir Pathophysiologie gefragt, ich wusste nicht aber kein Problem. Diagnostik: (Ekg,blutabnahme, BB, crp, bsg, antistreptolysin O usw.), hautausschlag(erythema marginatum), herzkomplication (perikarditis, endokarditis, myokarditis), prophylaxe

Gibt es keine neue Fachbegriffe.

bestanden

23.01.2024 Osöphaguskarzinom

Am Anfang habe ich mich kürz die drei Prüfern vorgestellt und sie haben mir auch ein paar Fragen gestellt, also über meine Hobbys und was bin ich momentan tätig.

Mein Fall : Osöphaguskarzinom

Herr Mühe Franz

53 Jahr alt 11.12.1971

179 cm groß 49kg schwer

Der Patient stellte sich in unsere Notaufnahme wegen seit 4 Wochen bestehender, progridierender und retrosternaler Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Er berichtete, dass die Beschwerde langsam aufgetreten sei und sich im Verlauf verschlechtert hätte. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen 3-4 von 10 auf der Schmerzskala betragen würden. Die Schmerzen seien nahrungsabhängig und beim Essen, besonders beim festen Essen schlimmer geworden seien und mit Dysphagie begleitet. Des Weiteren klagte er über Gewichtsverlust von ca. 12 kg innerhalb 3 Monaten.

Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Defekation und Miktionsproblemen wurden von dem Pt verneint.

Die vegetative Anamnese sei bis auf Inappetenz und morgendlicher, trockener Husten unauffällig.

Vorerkrankungen : TVT vor 10 Jahren Er sei ein mal TVT mit Lungenembolie im Krankenhaus aufgenommen und medikamentös behandelt worden. Er sei nie operiert worden. Keine Allergien seien bei ihm bekannt. Der Impfstatus sei komplett.

Noxen : Er rauche 30 Z/T seit 20 Jahren (30 PY) trinke 3-5 Flaschen Bier und 1-2 Gläser Snaps täglich seit langem. Drogen wurden verneint.

Familienanamnese : Vater leide an aHT. Die Mutter habe Apoplex gelitten und sei die rechte Arm ein bisschen gelähmt. Er habe einen Bruder gehabt und er sei an Pankreaskarzinom gestorben.

Fragen von Prüfern.

1. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?
2. DD
3. Diagnostische Maßnahmen?
4. Therapeutische Maßnahmen?
5. ÖGD dem Pt aufklären und versuchen den Patienten zu beruhigen? usw.

Fachbegriffe :

1. Abusus
2. Perforation
3. Sphincter ani
4. Enterologisch
5. Kardial

6. Vergiftung
7. Intoxikation
8. Palliativ Medizin
9. Koronararterienstenose
- 10.
- 11.
- 12.

Letzte drei habe ich vergessen.

Die Kommission war extrem nett. bestanden.

09.01.2024 Kolonkarzinom

Der Fall war fast wie im Protokoll. Die Prüfer (3 Männer) waren sehr nett und freundlich.

Leitsymptome: Starker Gewichtsverlust (fast 8kg in 3-4 Monaten) Keine Schmerzen

Vegetative Anamnese: Inappetenz abwechselnde Stuhlgang (manchmal Diarrhoe und manchmal Obstipation)

Patient-Reaktionen: Was habe ich? Muss ich mich sorgen?

Arzt-Arzt Gespräch: Ich habe nicht den Patienten vorgestellt, es war wie eine Diskussion. -Wie viel Gewicht hat der Patient verloren und über welchen Zeitraum? -Risikofaktoren -Voroperationen -Vorerkrankungen - Verdachstdiagnose -Diagnostische Maßnahmen -Therapie

Aufklärung: Koloskopie und Komplikationen

Fachbegriffe (12 insgesamt): Alveolen subkutan i.m. Ödem Ventral präfinal Fraktur

18.12.2023 Divertikulitis

Der Patient war fast derselbe wie in Protokoll, Franz Müller, 65 JA, 1,75m ... Ich werde die wenigen Unterschiede aufschreiben, die mir aufgefallen sind.

Anamnese Allergien/Unverträglichkeiten: Laktose-intoleranz und Hausstaub Familienanamnese: Vater leide an DM. Habe an MI gelitten. Aktuelle Beschwerden: Die Beschwerden seien langsam (subakut) aufgetreten. Intensität der Schmerzen war variable, 4/10 morgens und 8/10 abends. Vegetative Anamnese: Keine Pyrexie (!), Pyrosis, Nykturie. Vorerkrankungen und Voroperationen: • Keine Coxarthrose und Hyperchol. • Z.n Appendektomie statt Cholezystektomie. Er sei in die Schweiz gereist. Pat. Fragen: Was habe ich? Muss ich im Krankenhaus bleiben? Arzt-Arzt Gespräch Er lässt mich den Patienten vorstellen und fragt nach Diagnose und Therapie. Viele Fragen wurden hier schon geschrieben. Verwenden wir die Koloskopie sofort?

- Nicht bei akuten Anfällen. Was würden wir auf dem Ultraschallbild sehen?
- Verdickung Wie können wir auf Komplikationen prüfen, wenn wir keine Koloskopie durchführen können?
- CT mit Kontrastmittel. Welches Antibiotikum würden Sie verabreichen und warum?
- Ceftriaxon, die antibiotische Therapie sollte gramnegative und anaerobe Erreger erfassen. FB Tracheotomie - Luftröhrenschnitt Bronchoskopie - Lungenspiegelung Parotis - Ohrspeicheldrüse Adnexitis - Entzündung der Eileiter und Eierstöcke Hyperparathyreoidismus - vermehrte Sekretion von Parathormon Radiatio - Bestrahlung Carcinom in situ - Tumor hat die Basalmembran noch nicht

durchbrochen Atrophie - Gewebeschwund Hysterektomie - operative Entfernung der Gebärmutter
Tonsillektomie - chirurgische Entfernung der Gaumenmandel Phimose - Verengung der Vorhaut Die
Kommission ist sehr nett und entspannt. Viel Glück! 11.12.2023 Ich habe heute die
Fachspracheprüfung geschafft, Fall war Osteoporose. Der Patient kam mit Brustschmerzen, und ich
fragte nach kardiologischen Anzeichen (weil ich Aortendissektion vermutete), dann nach
neurologischen Ausfällen und ob er Schweres bei der Arbeit hebt (um einen Bandscheibenvorfall
auszuschließen). Ich hab den Patienten auch nach Bluthusten gefragt (im Arztgespräch fragten sie
mich, warum ich das gefragt habe, und ich hab geantwortet, dass der Patient ein Mann ist und muss
ich Metastasen von Lungenkrebs ausschließen !). Bei der Anamnese der Vorerkrankungen erzählte mir
der Patient, dass er vor 3 Jahren einen Hüftbruch hatte. Ich fragte, ob er gestürzt war, aber er meinte,
es war ein normaler Sturz. Also fragte ich, ob er schon Knochenschwund hat (und er war froh, als ich
das ansprach).

In der Dokumentation bestanden sie darauf, die Therapie und Maßnahmen zu schreiben, und ich hatte genug
Zeit, alles aufzuschreiben. Beim Arztgespräch fragte mich der Oberarzt, warum Osteoporose und kein
kardiologischer Notfall (der Schmerz hatte keine Ausstrahlung und der Patient litt nicht unter Atemnot). Er
fragte auch, welcher Notfall es sein könnte (ich sagte Aortendissektion, und das fanden sie gut). Dann fragte
er nach der Behandlung, die der Patient bereits gegen Osteoporose bekommt (Vosamax), wie sie wirkt
(hemmt den Abbau von Knochengewebe) und warum sie in diesem Fall nicht effektiv ist (die Behandlung
erfordert auch Bewegung und Physiotherapie, aber der Patient arbeitet im Büro). Er fragte auch nach der
Rolle der Osteodensitometrie. Er bat mich, dem Patienten die Diagnose zu erklären. Der Patient sagte, er
wisse, dass er Osteoporose habe, aber warum er diesen Schmerz in der Brust habe. Ich sagte ihm, es
könnte wegen eines Wirbelkörperbruchs sein. Die Fachbegriffe sind: Konjunktivitis, Ulcus ventriculi,
Splenektomie, Dehydratation, Atrophie. Die Kommission war echt nett und hat mir am Anfang mit bisschen
Smalltalk geholfen, um den Prüfungsstress zu lockern. 11.12.2023 Hans Hedgke, 45 J, 172 cm, 114 kg, SA:
Machinenschlosser, verheiratet, 2 Kinder Noxen: Alkoholkonsum: 2 Flasche Bier täglich, Schnapps
gelegentlich bei Partys Tabakkonsum und Drogenkontakt wurden verneint. Allergien & Unverträglichkeiten:
unauffällig FA: Mutter sei mit 76. Lj gestorben. (Den Grund weiß der Patient nicht, aber das heißt nicht, sie an
einer unbekannten Krankheit gestorben ist.) Vater sei mit 67. Lj an Kolonkarzinom gestorben. Bruder sei mit
37. Lj an Pankreaskarzinom gestorben. Die jüngste Tochter leide an Down-Syndrom. (Zunächst habe ich
"Ach so, tut mir leid." gesagt und er hat zurück reagiert: "Zurzeit hat sie keine Gesundheitsprobleme und sie
ist kuschelig, bla bla ..." (Untertiteln: Wage dir nicht, mein Kind zu unterschätzen!!!). Dann habe ich plötzlich
mit einem barmherzigen Blick mit gehobenen Augenbrauen nett gelächelt und mit Freude seine Liebe
widergespiegelt: "Ach, jaa! Das ist gut zu hören. Die Kinder sind sehr süüüß, sie machen man lebendig
fühlen, oder?" und meinen Kopf hoch und runter bewegt, als eine Anforderung für eine Zustimmung,
Verzeichnung und okkulten Frieden. Dann er hat bejaht und an den Prüfer geguckt. Ich habe aber mir schon
vor der Prüfung versprochen: "Da gibt es keine Prüfer, keine Prüfung, nur einen hilfsbedürftigen Patienten wie
meine Patienten im Alltag, deren Willen theoretisch nicht ist, mit mir Konflikt zu haben.")

Anamnese Her Hedgke ist ein 45-jähriger Patient, der sich bei uns wegen stechender

Arthritis am linken Fuß vorstellte. Er klagte über Calor, Dolor, Rubor, Tumor und Bewegungseinschränkung
an der betroffenen Stelle. Die Schmerzen ohne Ausstrahlung seien erst vor 2 Tagen eingetreten und seit dem
Abend nach dem Alkoholkonsum stärker (7-8 auf der Schmerzskala) geworden. Die Einnahme von Ibuprofen
600 mg habe nur eine teilweise Besserung der Symptomatik gebracht. (Die Schmerzen seien nach der
Medikation "dumpfer" geworden.) Die Fragen nach sonstigen Gelenkbefälle, Fieber, Inappetenz,

Nachtschweiß, Gewichtsänderung, Hautveränderungen sowie Alopezie an der betroffenen Fuß, Stuhl- und Miktionsveränderungen, Schlafstörungen wurden verneint. An Vorerkrankungen sind bekannt:

- aHT seit ... J.
- Z.n. Commotio cerebri als Folge eines Motorradunfalls vor 20 J., konservativ behandelt (Körperliche Schonung)
- Migräne (Das hatte der Patient nicht als Krankheit eingeordnet, sondern das beim Erwähnen über den Unfall angegeben: "Ich habe keine andere Erkrankungen, reicht es nicht Frau Doktor? Vor 20 Jahren hatte ich einen Motorradunfall, dann musste ich beim Krankenhaus bleiben. Ich hatte migränartige Kopfschmerzen und Abschürfungen, an Gehirnerschütterung gelitten. Als ich den Motorrad fuhr, ist der Unfall passiert. Trotzdem habe ich es leicht überwunden. Meine damalige Partnerin saß in der Hintersitze, sie ist gestorben." Er hat während meiner Dokumentieren sehr schnell erzählt. Aber dank eines Kollegen, der in der Telegram-Gruppe dieselbe Verlierergeschichte in seinem Fall aufgeschrieben hat, und dank Linux, alle diese Angaben für uns zusammengefügt hat, war ich blitzschnell mit einem sehr nachempfindlichen traurigen schockierten Mimik aufgewacht und nachgefragt: "Entschuldigung (mit großer Überraschung und der Mimik eines Nichtverstehens), wer war, die gestorben ist?" – "Meine Partnerin" – "Ach so!" mit einer Tonne und einem Gesicht, als ob ich das zum ersten Mal von einem Patienten gehört hätte. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich schnell und zielorientiert gesprochen aber da bin ich mit einer anderen Stimme leiser geworden, den Stift auf dem Tisch abgelegt, aufgehört, Notizen zu nehmen. Ich habe so direkt in die Augen der Patienten geguckt, als ob ich bei einer Psychotherapiesitzung versucht hätte, den Patienten für weitere psychiatrische Exploration zu triggern: "Das ist bestimmt nicht einfach für Sie, huh?" In dieser absichtigen 2-Sekundigen Pause mit direktem Augenkontakt hat der Patient-Prüfer das Gefühl so sehr realistisch gefühlt, sodass er musste seinen Blick nach anderen Prüfern zu steuern, um bei der Prüfung hilflos nicht anfangen zu müssen, seine Kindheitstraumas zu thematisieren. ☺ Dann habe ich mit einer leitenden und merkwürdigen Stimme und einem ernsten, sorgfältig und merkwürdigen Ausdruck nachgefragt: "Wie kommen Sie damit klar?" – Dann habe ich plötzlich Angst gemacht, ob meine Sorge übermäßig betrachtet würde: "Doch, es ist schon 20 Jahren, aber doch..." Er reagierte direkt stimmend; er esse oder trinke, um diese Gedanken zu bewältigen. Er konnte noch nicht vergessen und fühle sich schuldig. "Verstehe... (Ich habe mal ein- und ausgeatmet, um den Patienten auf die Themaänderung vorzubereiten. Mit einer anderen lebendigen Stimme weitergemacht: "Aber Ihre Gesundheit ist doch wichtiger Herr Hedgke, ja? Sie sind zum Glück noch da. Hatten Sie dann irgendwelche Operationen gehabt?"...) In der Medikamentenanamnese zeigten sich:
 -
 -

Ramipril 1-0-0, dessen Dosierung nicht erinnerlich Ibuprofen 600 mg b. B. Impfungsstatus sei vollständig, er sei gegen Corona 3 mal geimpft worden.

Anhand der anamnestischen Angaben gehe ich von einer Arthritis urica (Hyperurikämie) aus. DD: Weichteilläsion (Wenn ich etwas Zeit hätte, dürfte ich entzündliche Gelenkerkrankungen wie RA schreiben)
Diagnostik: Lab (Die Zeit war echt zu knapp) Therapie: Allgemeine Maßnahmen

Während der Anamnese habe ich nach Essengewohnheiten gefragt: "Essen Sie gerne Fleisch oder fettige Nahrungsmittel?" – "Ohoho, es wäre leichter, wenn ich sage, was ich nicht gerne esse." Dieser Scherz wurde vom Patienten anscheinend für die Audienz der Prüfer gemacht, die gelächelt haben. Ich habe die Schau nicht gestoppt: – "Na, okay, dann machen wir so, was essen Sie nicht gerne? Zum Beispiel Gemüse?" Sie

haben noch mal gelächelt. Am Ende der Anamnese hat der Patient nach der VD gefragt. Ich habe mal zurückhaltend verhalten: "Herr Hedgke, klar habe ich eine Verdachtsdiagnose. Trotzdem ist es noch früh etwas Konkretes zu sagen. Wir müssen zuerst Sie körperlich untersuchen, Blut abnehmen. Dann muss ich mit meinem Oberarzt besprechen und erst danach können wir mit Ihnen die richtige Diagnose teilen." – Er hat zynisch gelächelt und leise gesagt: "Mm, heißt, Sie verraten mir nichts, hmhm." – "Dann verrate ich das große Geheimnis, machen wir so... Ich gehe von einem Gichtanfall aus." – "Aa ja ich habe den gehört." – "Wie haben Sie gehört?" – "Mein Kollege hatte, bla bla..." – "OK" – "Was werden Sie dann machen?" – "Wenn es um einen Gichtanfall geht, müssen wir ein paar Änderungen in Ihrem Lebensstil machen. Sie müssen den Alkoholkonsum reduzieren und etwas Gewicht verlieren, einverstanden?" – "Sie wissen aber zurzeit nicht sicherlich, das können wir später sprechen." – Mit einer plötzlichen Mimikänderung, als ob ich mit einem unartigen Kind gesprochen hätte: "Herr Hedgke? Sie geben auf jeden etwas Gewicht ab, egal Gichtanfall." Dann haben alle Prüfer inklusive der Pt. laut gelächelt.

Bei dem Bericht gab kaum Infos über weiteres Vorgehen nach der VD. Ich dachte mal, dass ich diesmal deswegen durchfallen würde. Aber die Prüfer haben weder den Bericht noch etwas Anderes kritisiert.

Arzt-Arztgespräch war sehr leicht im Vergleich zu meinen anderen 2 Prüfungen. Ich habe diesmal mit kurzen Sätzen vorerst über die aktuelle Anamnese berichtet. Die alle Angaben durfte ich auch berichten. VD wurde nachgefragt: Arthritis urica – genau gesagt Podagra, da es um einen Befall des Großzehens handelt. Die erste Frage: Dürfen wir einen Gichtanfall ausschließen, wenn die Harnsäure nicht erhöht sind? Die Antwort ist im Amboss Kapitel Hyperurikämie besonders hervorgehoben: Nein! Ein plötzlicher Anstieg oder auch ein plötzlicher Abstieg der Konzentration von Harnsäure kann zu einen Gichtanfall führen! Ich würde stark empfehlen, die aktuellen Protokolle zu lesen, wie ich heute für euch geschrieben habe. Diese Frage habe ich auch in den Protokollen gesehen und den Kapitel gelesen. Herzlichen Gruß an diesen Kollegen! Zweite Frage: Welche Risikofaktoren für einen Gichtanfall bestehen bei dem Patienten? Alkoholkonsum, (er hat selber erinnert: Ist der Patient etwas übergewicht? – "Ach ja, eben morbid obes!" habe ich gesagt, er war zufrieden. Aber nicht morbid obese- morbid adipös sollte ich eher auf Deutsch nennen.) Übergewicht, das Alter und männliche Geschlecht habe ich eingeordnet. / FSP Karlsruhe.md 2023-12-01 Als er sah, dass ich zögert habe, mehr Argumentationen zu rufen, hat er dann nach dem Beruf und Belastung als eine Risikofaktor gefragt. (Als ich dem Patienten fragte, ob er davor nach ähnlichen Schmerzen bekommen hätte, hat der Patient von ihm die folgende angegeben: "Ja, ich habe manchmal Rückenschmerzen, da ich Maschinenschloßer bin, muss ich schwere Sache aufheben. Deshalb habe ich mal meinen Hausarzt aufgesucht und Ibuprofen eingenommen. Diese nehme ich nur wenn ich Kopfschmerzen habe. Gestern habe ich einmal genommen und damit sind die Schmerzen, ja, dumpfer, oberflächlicher geworden. Ich habe mit kurzen Blickkontakten kontinuierlich aufgeschrieben. Was ich nicht ganz sicher verstanden habe, habe ich mit kurzen Rückfragen "zur Sicherheit" noch mal gewahrleistet: "Dann sind Sie ein Maschinenschloßer, ne?" – Ja, das bin ich. – Was hat den Ihr Hausarzt gemacht, was für weitere Untersuchungen?

- Was meinen Sie? – MRT / Kernspintomografie zum Beispiel. Sie hatten Rückenschmerzen. – Ach, Sie meinen wegen der Rückenschmerzen... Nein, er hat nichts besonders gesagt, nur Ibuprofen gegeben. Im Moment habe ich keine Schmerzen und in Ordnung. Das war anders, nicht wie die Heutige.) "Er ist ein Maschinenschloßer und muss schwere Sachen aufheben - wenn Sie eine körperliche Belastung meinten..." (mit versorglicher Stimme und bemerkend habe ich weitergemacht:) "Bei diesem Fall könnte ich aber Ihnen eine traumatische Geschichte des Motorradunfalls angeben. Dabei hat der Patient seine Partnerin verloren, sie saß am Hintersitz." Dann hat der Oberarzt spielende Prüfer sehr interessiert reagiert, sehr wichtig gefunden und sehr zufrieden mit meinem Ausdruck gewirkt. "Ach so,

stimmt... Das erklärt einige, huh?" – "Ja, eigentlich Vieles. Psychische Belastung ist zu hoch. Hierbei müssen wir eine Psychotherapie planen." – "Warum? Sie meinen, der Patient hat übermäßiges Essverhalten, verstanden." – "Ja, das wäre auch ein Grund, aber wir müssen die psychologische Gründe des Alkoholabusus therapieren" (Er hat sehr freudig angenommen und das hat mich ermutigt, noch mehr zu sagen:) "... und noch gegen den Sozialenkontaktverlust müssen wir den Patienten mithilfe Psychotherapie unterstützen." – Sehr gut, klug. (Der Patient hat Probleme mit seiner Frau aufgrund des Alkoholkonsums. Er sprach etwas deprimiert aber hatte keine andere Diagnosekriterien für Depression) Als DD habe ich Rheumatoide Arthritis und Rheumatisches Fieber angesprochen; die Erste mit dem Fehlen multiplen Gelenkbefälle und die Zweite mit dem Mangel des Fiebers eher unwahrscheinlich sind. Bei der Laboruntersuchung habe ich Entzündungsparameter wie CRP, BSG, Leukozytose und - zum Ausschluss einer bakteriellen Genese- Procalcitonin, Nierenwerte zum Ausschluss der nephrolytischen Komplikationen, differenziales Blutbild und Urat betont. Dabei hat der Prüfer den Begriff "Harnsäure" zu hören, aber nicht schlimm betrachtet, es in diesem Moment mir nicht eingefallen ist. Außerdem habe ich alles richtig beantwortet. Er hat generell sehr positiv bewertet und sehr sehr unterstützend bei meinen Aufregungsmomenten positiv ein gewirkt – was die vorherigen Prüfer ganz umgekehrt gemacht haben. Eine typische Witze über Procalcitonin hat der Prüfer gemacht, die ich in meinem Heimatland auch oft gehört habe: "Haha, wer hat zu viel Geld um für Procalcitonin auszugeben? Vielleicht in Unis, aber schon gut..." ☺ Die Fragen waren: Welche Entzündungsparameter? Wie nennst du "Arthritis urica" dem Patienten auf Deutsch? Ich habe mal Gedanken gemacht, am Ende des Anamnesegesprächs habe ich ja schon den Gichtanfall äußert? Die Prüfer haben "Kein Stress, Sie haben ja schon während der Anamnese umgangssprachlich gesagt." Beide "drei Engel" haben mich alle 2 Minute mit / FSP Karlsruhe.md 2023-12-01 immer mehr beschleunigten Kopfbewegungen eingestimmt und fast miteinander konkurriert, mich besser zu loben. Haha, ich habe mich verwirrt gefühlt, als ob sie mit mir lustig gemacht hätten. Die vorherigen Kommissionen, besonders in Stuttgart, haben mich ständig kritisch zugehört. Therapeutisch habe ich NSAR wie ASS oder Metamizol, ggb. Paracetamol und prophylaktisch Allopurinol empfohlen. Der Prüfer wollte mal über stärkere Analgetika hören. Um Zeit zu gewinnen habe ich Flüssigkeitsaufnahme, Vermeidung vom Alkohol und proteinhaltiges Essen benutzt. Dann fällt mir ein, Steroiden - Corticosteroiden zu nennen. Ja, das war es, was er hören wollte. Ich dachte, dass es etwa 10 Minuten gegangen wäre, als der Arzt-Prüfer mir sagte: Schon gut. Wir könnten hier aufhören, aber wir haben noch 2 Minuten. Dann machen Sie bitte eine Aufklärung über die Diagnose. - Haben wir jetzt die Diagnose sicherlich gestellt? – Ja. – Ok dann. Herr Hedgke, jetzt kann ich Ihnen sicher sagen, dass Sie abnehmen müssen. Ich habe gerade mit meinem Oberarzt gesprochen. Wie Sie schon wissen, wir haben Sie untersucht und die Laborergebnisse sind auch ausgefallen. Sie leiden an einem Gichtanfall. Dabei kann ich gut nachvollziehen, dass Sie während der Attacken sehr starke Schmerzen bekommen. Tatsächlich ist die Krankheit mit diesen nächtlichen starken Schmerzen gekennzeichnet. Aber gar keine Sorge, wir haben sehr einwirksame Arzneimittel dagegen. Was wir aber noch tun müssen, ein paar Maßnahmen zur Vorbeugung weiterer Anfälle zu greifen. Hier wurde unseren Dialog unterbrochen. – Das reicht schon, haben Sie gesagt. Für die Fachbegriffe wurde mir 5-10 Minuten gegeben, "ganz flexibel" haben Sie beschrieben (Ist diese eine Prüfung wie die Andere?). Sie haben etwas im Zimmer gegessen. Als ich bereit war, habe ich alle Fachbegriffe vorgelesen. Leute, ich bin mir ganz sicher, dass ich alle auf dem Papier stehenden Fachwörter (außer Bilobektomie) richtig auswendig gelernt habe. Sie haben aber bei Einigen mit einem kleinen Überlegensmoment eingestimmt. Ich glaube, die Prüfer akzeptieren eine andere Quelle, die wir nicht wissen. In der vorherigen Prüfungen hatte ich auch die sicherlich richtigen Klärungen aufgeschrieben aber diese wurden ganz kritisch gesehen.

Zum Schluss musste ich nur 3-5 Minuten draußen abwarten. In den anderen Prüfungen musste ich 20-30 Minuten abwarten gelassen. Damals haben sie mich den Platz im Prüfungsraum gegeben und noch für 15 Minuten komische und beleidigende "Empfehlungen" geschenkt. Diesmal hat einer der Kommission mich direkt mit der Urkunde eingeladen und sie wollten nur positive Rückmeldungen geben: Die Prüfer haben nicht verstanden, warum ich in den ersten 2 Prüfungen nicht bestanden hatte. Auch wenn Sie meine vorherigen Leistungen nicht gesehen hatten, sei es klar: Es wirkte, was ich seit der letzten Prüfung gemacht hatte. Laut den Prüfer habe ich sehr flüssig, ohne Grammatikfehler, sehr stark empathisch mit angemessenen Humor gesprochen und alles waren in Ordnung. Sie benötigten gar nicht, mit mir kurz vom dem Aushändigen der Bescheinigung besprechen, um ein paar Kritik zu machen. Sie haben mich nur vor meiner Eile und Geschwindigkeit gewarnt, ansonsten könne ich schon besser sprechen. Ich habe diese Rückmeldung mit Wörter "Leider habe ich diese Kritik lebenslang erhalten" angenommen. Beim Handshake hat der Patient-Prüfer mir auf meiner Muttersprache "langsam - langsam" gesagt. 😊 Ganz ehrlich, ich habe in diesem Zeitraum fast nichts gemacht und meine älteren Leistungen waren schon viel besser. Wenn die Prüfer über den / FSP Karlsruhe.md Vorfall des Motorradunfalls fragen würden, könnte ich nicht beantworten, darauf habe ich nicht geachtet. Wenn sie wollten, gegen mich streng zu sein, könnten sie einfach. Was geändert hat, war nicht die Prüflinge, die Kommission selber. Deshalb wünsche ich an euch, die geehrten Kolleg*innen, viel Glück, Ausdauer und Erfolg!

21.11.2023 Coxarthrose

Herr Johannes King 58 Jahre 1,80m 110kg Genussmittel: Alkohol eine Flasche Bier täglich FA: Vater gestorben / Mutter gestorben, Herzinsuffizienz und DM SA: Baggerfahrer, verheiratet, eine gesunde Tochter

Seit 5 Monaten stechende dumpfe Schmerzen in der Linken Hüfte mit Ausstrahlung in den Oberschenkel bis zum Knie. Die Schmerzen treten bei Belastung auf, bei jede 500m bekommt er Schmerzen, seit einer Woche sind die Schmerzen progredient, 7/10 deswegen hat er Voltaren ohne Besserung benutzt. Müdigkeit, und Insomnie Alle weiteren Fragen wurden verneint. VE: Dm Typ II, arterielle Hypertonie, Gicht VO: op wegen einer Meniskusriss Medikamente: metformin, Voltaren Ramipril

Arzt-Arzt Gespräch: Ich habe nur die persönlichen Daten gesagt und dann: So er ist Übergewicht, strahlen die Schmerzen aus? Er hat keinen Unfall keine Parese.. was ist er von Beruf? Also das Gespräch war wie eine Wiederholung der Anamnese. VD und was machen Sie bei der Untersuchung. Dann teilte ich dem Patienten die Diagnose mit und sagte, dass wir eine Röntgenaufnahme machen müssten. Keine Aufklärung Keine Reaktion

Der Patient hat seeeehr langsam, viel aber klar gesprochen so ich habe die wichtige Fragen gestellt, die in Zusammenhang mit der Beschwerden waren (ich dachte nur an die Zeit aber ich weiß nicht wie viel Minuten hat das Gespräch gedauert, weil der Rechtsanwalt die Zeit auf seiner Uhr abgelesen hat 😊)

Die Kommission war sehr nett, sie haben deutlich gesprochen. Über den Arztbrief haben sie gesagt, dass ich eine schöne Handschrift habe haha. Sie waren ein HNO-und Kinderarzt und der Rechtsanwalt.

Fachbegriffe: Arthritis urica Menopause Phimosis Femur Fraktur Humerus Nephrolithiasis Mastektomie Palliative Commotio cerebri Myokarditis Ulcus ventriculi Laringitis

16.11.2023 Oberschenkelhalsfraktur

Gestern habe ich die FSP im Karlsruhe abgelegt.

Der Fall war schenkelhalsFraktur bei Osteoporotiker Patient also wie der Protokoll.

Am Anfang hat er schwäbisch gesprochen.

A.A Gespräch: Fragen über Unfallsumgang (alles was er am Anfang schnell auf schwäbisch gesagt hat) , CT Aufklärung, Therapie.

Die Begriffe waren alle von der Liste

14.11.2023 metabolisches Syndrom

Anton Kaiser, 53 Jahre alt, 170 cm groß, 115 kg schwer.

Anamnese:

- Allergien: Keine
- Raucher: 30 Packungen pro Jahr seit 30 Jahren
- Alkoholkonsum: Täglich 4 Flaschen Bier seit 2 Jahren
- Drogen: Keine Sozialanamnese:
- Beziehung: Getrennt seit 2 Jahren, 2 gesunde Kinder, lebt allein
- Arbeit: Arbeitslos seit 2 Jahren
- Sport: Kein Sport

FA:

- Vater sei mit 80 Jahren verstorben
- Mutter sei mit 55 Jahren verstorben an Mammakarzinom

Herr Kaiser ist ein 53-jähriger Patient, der sich wegen einer seit 2 Jahren fortschreitenden Gewichtszunahme mit Depression in unserer Station vorstellte.

Der Pt berichtete, dass er seine Beschwerden mit Arbeitslosigkeit verknüpft habe.

Der Pt habe keine ähnlichen früheren Beschwerden angegeben. Gestern morgen habe er beim Hausarzt Blut abnehmen lassen, und die Laborergebnisse zeigten erhöhten Blutzucker und erhöhte Cholesterinwerte, weshalb er mit dem Verdacht auf Metabolisches Syndrom zu uns überwiesen wurde.

Dem Pt seien die folgende Begleitsymptome aufgefallen

- Sehstörungen (diabetische Retinopathie)
- Polyurie

(ich habe versucht mit allen Krankheiten zu vergleichen, jedoch hat er nur die Beschwerde der Gewichtzunahme, sonst nix)

Vorerkrankungen: Gonarthrose seit 2 Jahren Arterielle Hypertonie seit einigen Jahren Appendektomie durchgeführt (Als Kind)

Impfstatus ist vollständig.

Medikation: Diclofenac 100 mg bei Bedarf Ramipril 5 mg 1-0-0

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf das Metabolische Syndrom hin.

Die Prüfer waren sehr nett und einige der Fachbegriffe, an die ich mich erinnere, sind: akute, Myokarditis, Ileus, Distorsion und Dysurie.

bestanden

09.11.2023 Pertusis

Ich habe am 9.11 in Karlsruhe die Prüfung abgelegt Und God sei Danke bestanden. Die Prüfung Kommission war extrem Nett und die fall war Pertusis.

A- wie Protokoll Wichtig frage nach impft Status.

Anmerkung Der pat war in ein Kinder Garden vor 2 Wochen, hat ein Bekannter besucht und dort hat er gesehen, dass mehrere Kinder gehustet haben.

Schriftliche Teil.

Ich vermute, dass der Jura Prüfer nicht nur die Struktur der Anamnese überprüft, sondern auch die Wörter zählt. Als er eine Zahl erwähnte (130), wurde mir klar, dass es sich bei den Kopien, in denen ich geübt habe, ungefähr um die gleiche Zahl handelte

A- A Wie nachweisen wir eine Pertussis hin ? Rachen Abstrich

Wie gehen wir weiter nach Abstrich ? Molekulare PCR

Wie ist die Therapie ? wie Protokoll

wie gehen wir in schwer verlauf vor ? Stationiert + isoliert —> bis Kunstlicht Beatmung

Nennen Sie die verschiedene Krankheit Stadium (ich habe vergessen.

Stadium catarrhal Stadium convulsivum Stadium decrementi

Fachbegriffe :

5 von 10 waren neuen. Leider bin ich hier durchgefallen

Retina Meningitis Auskultation Präventiv Sensibilität

Ich muss sagen, dass die wichtigsten Teil sind Anamnese und schriftliche .

viel erfolg euch allen 🙌🍀 Med. Lozano

23.10.2023 Ösophaguskarzinom

Hello, Kolleginnen und Kollegen, heute (30.10.2023) hatte ich den FSP-Prüfung und habe diese elfolgreich bestanden. Das war meine erste Versuch.

Prüfungsort : Karlsruhe Fall : Ösophaguskarzinom

Zunächst stellen Sie sich kurz vor und erhalten einige klassische Fragen. Das ganze Gespräch ist entspannt, die Prüfer waren nett und freundlich.

Teil 1 : Dann beginnt die Anamnese, sie dauert 20 Minuten, Die Daten sind die gleichen wie im Protokoll, ich möchte sie nicht wiederholen. Herr Heinz Mühe 53 Jahre Alt, ... usw. Am Ende fragte mich der Patient, was mit ihm los sei.

Teil 2 : Für eine vollständige Dokumentation inklusive Diagnostik und Therapie reichten mir 20 Minuten völlig aus.

Teil 3 : Ich habe den Patienten bis zur Diagnose mit kleinen Unterbrechung vorgestellt. Ich wurde nach dem Allgemeinzustand des Patienten gefragt. Laut BMI besteht bei dem Patient ein Untergewicht/Anorexie (Gewicht: 49 kg Größe: 179 cm) Ich habe vorher gesagt, dass er über Inappetenz und Gewichtsabnahme klagt.

Als Differenzialdiagnose sagte ich, dass wir zunächst ein akutes Koronarsyndrom ausschließen sollten. (Sie waren damit sehr zufrieden.) Dann sollten wir auch GERD und Tumoren benachbarter Organe wie Trachea und Thyroidea in Betracht ziehen. Hier gab es keine Fragen.

Im Bereich Diagnostik: Nachdem ich von der Ösophago-Gastro-Duodenoskopie gesprochen hatte, fragten sie mich, welche Komplikationen bei diesem Patienten möglich seien (Blutungen wegen Varizen, Schleimhautverletzungen und die Unmöglichkeit einer vollständigen Untersuchung aufgrund der Obstruktion durch den Tumor)

Ich wurde gefragt, mit welcher Diagnosemethode Sie zunächst den Zustand der Speiseröhre beurteilen würden. Ich habe gesagt, „Röntgen des Ösophagus mit Kontrastmittel Bariumbrei“. Danach sagten sie, es sei völlig ausreichend und baten mich, dem Patienten die Untersuchung zu erklären und ihm mitzuteilen, dass der Verdacht auf einen Tumor besteht.

Ökonomie Präventiv Progreß Gingiva Hämatemesis Retina Keratitis Induration Kontusion

Das war meine Erfahrung, es war einfacher als ich erwartet hatte. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Prüfung !!!

23.10.2023 Osteoporose

FB: Anamnese, Aszites, Hydrops, angiologisch, Lymphangitis, Dislokation, neurogen, Laxantien, Xerodermie .

18.09.2023 Ösophaguskarzinom

Ich habe heute die Prüfung abgelegt und bestanden. Der Fall war Ösophaguskarzinom. Ein paar Fachbegriffe waren: Dekubitus Pankreatitis Strabismus Ikterus Emesis gravidum Hereditär

00.09.2023

Herr Schlanz ist ein 51-jähriger Patient, der sich heute morgen bei uns wegen seit 2 Tagen aufgetretener bestehender Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Armen vorstellte. Die Schmerzintensität wurde mit 6/10 auf der Schmerzskala bewertet. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen plötzlich nach Streit mit Nachbarn und sich im Lauf der Zeit verschlimmert hätten. Zusätzlich teilte er mit, dass die Schmerzen Belastung abhängig und im Ruhe besser geworden. Die Frage nach Atemnot, Herzrasen, Herzklopfen wurden verneint. Ferner seien dem Patienten folgende begleitende Symptome aufgefallen: Meteorismus Verstopfung Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Schwitzen Insomnie

Arzt Arzt Gespräch Diagnose Mehr als 20 Minuten, warum nicht MI Warum nicht koronaro direkt Unterschied zwischen stabil un instabil Angina Patient hat Nackensteifigkeit, hat das etwas zu tun mit angina Maßnahmen Warum troponine und nicht dd Und Therapie

04.09.2023 Ösophaguskarzinom

Fachbegriffe: Alopezie, Verruca, Dehydratation, Geriatrie, Trachea, hepatitis, Amaurose, Hernia umbilicalis

04.09.2023 Kolonkarzynom

Herr Franz Meister. 63 J Größe: 1.8 Gewicht: 67 kg Der 63 jährige Patient stellte sich heute bei uns mit seit ca. 3 Monaten, plötzlich aufgetretender, bestehender, zunehmender Gewichtszunahme von 6-8 kg vor. Als Begleitesymptome nannte er Fatige seit 4 Wochen. Die vegetative Anamnese sei bis auf wässrige Diarrhö 12 Mal/T und seltene Obstipation unauffällig. (Menge von 1 Tase von 12 Unzen).

B-Symptomatik, Tachikardie, Thorax- und Abdominalschmerzen, kopschmerzen, Hämatokese, Meläna wurden verneint. Insomnie und Beschwerden bei der Miktion trotz Prostatahyperplasie wurden verneint.

VE: COPD seit 4 J Prostatahyperplasie seit 2 J Colon irritabile seit 10 J

MA: Prostagut 1-0-0

Keine Allergie und Unverträglichkeit

Z.n. Cholezyktomie

FA: Vatter sei vor 10J an Kolonkrebs verstorben Mutter sei gesund

Noxen: 1 Packungzigarette/T seit 10 J 1 Flashe Bier/T seit 5 Tagen Drogen wurden verneint Keine Sport Keine Diät

Er sei verheiratet, habe 1 gesunde Tochter und wohne allein, er habe eine schlechte Beziehung mit seiner Ehefrau.

VDiagnose: Kolonkarzynom DD: Hyperthyreose, Prostatakarzynom akuter Schub von Colon irritabile und chronisch entzündliche Darmerkrankung.

Aufklärung: Koloskopie

01.08.2023 Depression

Ich habe die Prüfung am ersten August abgelegt und got sei dank bestanden.

Teil 1: der Patient war sehr müde seit ein paar Monaten, und hat Interesse an Aktivitäten verloren, har keine Selbstmord Gedanken, Konzentrationsschwierigkeiten, Depressive Stimmung , Heiße Hunger, er wohnt allein, seine Frau hat ihn verlassen, er ist arbeitslos Gewicht : 115kg Alle die anderen Fragen wurden verneint

Reaktionen: Was habe ich ? Er hat gesagt ich glaube nicht dass ich eine Depression habe, ich glaube dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe Haben Sie Kontakt mit Drogen ?

Teil 2 : die Briefe schreiben, ich habe Fehler gemacht, es war nicht perfekt aber es war okay für die Prüfer

Teil 3: Patient Vorstellung mit Unterbrechungen

Diagnose: Depression (primäre) DD : Depression (sekundäre) Hypothyreose (warum und wie können Sie diese Diagnose ausschließen) Schlafapnoe Syndrome (warum und wie können Sie diese Diagnose ausschließen) Klinische U + Labor U + ggf MRT Therapie der Depression: psychiatrisches Konsil veranlassen ++++++ Sie haben gefragt was werden Sie auch recherchieren ? Metabolisches Syndrome (er leidet an Übergewicht und AHT) Wie ? Lipidstatus, Blutzucker , HbA1C, Abdomen Umfang Eventuell Therapie und Einstellung

Teil 4 : Drainage, Urethra , Appendektomie , präfinal ... (ich erinnere mich nicht an alles)

Die Kommission war sehr sehr sehr nett. Die Protokolle war sehr sehr hilfreich

19.09.2023 Migräne

Am 19.09.2023 habe ich die FSP abgelegt und bestanden (zweites Versucht). Der Fall war Migräne.

Frau Elke Kovermann ist eine 39-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Tagen, bestehender, plötzlich aufgetretener pulsierender, linksseitiger Cephalgie vorstellte. Die Patientin berichtete, dass bereits ähnliche vorherigen Beschwerden aufgetreten seien, aber jetzt seien sie schlimmer geworden. Die Einnahme von Paracetamol und Ibuprofen habe keine Verbesserung gebracht. Die Beschwerde seien von Nausea, Erbrechen (2-Mal), Phonophobie und Lichtblitzen begleitet. Die Vegetative Anamnese ist bis auf Inappetenz, schmerzbedingte Insomnie und Diarrhö (seit langer Zeit) unauffällig.

VE: Venenthrombose im linken Bein vor 8 J, behandelt mit Heparin und langfristige Therapie mit Antikoagulantien *Migräne ist schon bei der Patientin bekannt. VO: Histerektomie vor 3 J Die Patientin nehme keine Medikamente ein. Allergie/Unverträglichkeiten: Laktoseintoleranz seit 5 Jahren Noxen: Nicht Raucherin, trinke 1 Glas Wein jeden Abend, Drogenkonsum wurde verneint. FA: Vater: an Hirntumor mit 60 Jahren gestorben Mutter: leidet an Demenz und lebt im Heim SA: Geschieden, 4 Kinder (alles Gesund), lebe mit ihrer Familie zusammen. Sie sei Maklerin bei einer Immobiliens-Firma. Habe viel Stress bei der Arbeit. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf Migräne hin.

Als Differenzialdiagnosen kommen folgenden in Betracht: Hirntumor Meningitis Apoplex Zur Weiteren Abklärung, werde ich die folgenden Maßnahmen durchführen: Körperliche Untersuchung (Neurologische US) Labordiagnostik: KBB, Entzündungsparameter, Retentionsparameter Bildgebende Verfahren: CT Schädels, MRT, Lumbalpunktion Sollte die Diagnose Bestätigen, werde ich die folgende Therapie empfehlen: Körperliche Schonung (abschirmen von Licht und Geräusche) Analgetika (Triptane) Antiemetikum A-P: Könnte es Krebs sein?

A-A Gespräch: Ich habe nur die erste Linie der Vorstellung gesagt, danach kommen die Fragen: Verdachtsdiagnose? Seit wann treten die Schmerzen auf? Differenzialdiagnosen und wie können wir sie ausschließen.

Was machen wir bei Neurologische US? Wie können wir eine Meningitis ausschließen? (Fieber, Lumbalpunktion), Borreliose (Serologie, Zecken Gebiss) FSME. Wie ist der Familienzustand der Patientin? Warum hatte sie eine Histerektomie? Ich werde bei der körperlichen US nachfragen Was könnte die Auslöser für ihre Migräne sein? Was macht die Patientin beruflich? Stress bei der Arbeit und Familie Welche Therapie? Am Ende Abklärung der Diagnose und Therapie zur der Patientin. Kann ich nach Hause? Nein. Sie müssen ein paar Stunden bei uns bleiben, damit können wir eine Blutabnahme zur Labordiagnostik und einige Untersuchungen durchführen.

Fachbegriffe: Cutis: Haut Kachektisch: abgemagert Tubärgravidität: Eileiterschwangerschaft Adaptation: Anpassung Flexur: Biegung Dorsal: Rückseitig Analgetisch: Schmerz lindern Nephritis: Nierenentzündung Bronchialkarzinom: Lungenkrebs Larynx: Kehlkopf Retina: Netzhaut Sedativa: Beruhigungsmittel Die Kommission besteht aus 2 Ärzten und einem Rechtsanwalt. Die waren sehr nett.

31.08.2023 Gicht

Fall: Gicht. 45 Jahre alt. Männlich. Symptome: Stechender Schmerz im linken Großzehengelenk, 8/10, ohne Ausstrahlung, mit Rötung und Schwellung. Die Schmerzen traten plötzlich nachts auf. Der Patient kann nicht mehr laufen. Fieber wird verneint.

Der Patient wiegt 115 kg, trinkt 2 Flaschen Bier pro Tag und isst viel Fleisch.

VE: Hypertonie. Migräne. Nichtraucher. Keine Drogen.

Arzt-Arzt-Gespräch>

Was spricht für Gicht? DD? Welche Untersuchungen? Wie hoch ist der Harnsäurespiegel bei Gicht? Kann der Harnsäurespiegel bei akuter Gicht normal sein? akute Therapie? NSAR, Colchicine. Dauertherapie Welche Komplikationen kann eine Hyperurikämie haben? Außer Gicht. Was findet man in der Pathologie bei Gicht? Uratkristalle.

Der Patient ist übergewichtig. Sollte er abnehmen? Was kann eine Gewichtsabnahme bei diesem Patienten bewirken? Verschlechterung der Symptome.

Keine Aufklärung. Der Patient wollte nur wissen, was er hat. Und welche Untersuchungen. Und ob er im Krankenhaus bleiben muss. Aber es geht nur um die Sprache. Man muss nicht alle Fragen richtig beantworten.

Fachbegriffe: Hypalgesie Spina bifida Diarrhö Distorsion Pulmo

31.08.2023

Fall: Appendizitis. 42 Jahre alt. Weiblich. Symptome: Dumpfer mittelstarker Schmerz im Unterbauch, zuerst in der Mitte dann rechts. Ohne Ausstrahlung. Die Schmerzen traten plötzlich gestern abends auf. Fieber, Emesis wurden verneint. VA: nur Inappetenz, Obstipation.

VE: Hypertonie. Hypothyreose. COPD

vor 12 J Extrauterin gravidität

Sie nimmt die Pille ein

Rauchen: 40Z/Tag seit 20J. Alkohol: 3 mal/Monat Bier/Wein. Keine Drogen.

Arzt-Arzt-Gespräch Fragen:

Was spricht für eine Appendizitis?

DD, was spricht dafür und dagegen?

Welche Untersuchungen? KU, Ergebnisse der Abdomensonographie

Therapie

Keine Aufklärungen

Der Patient fragt nur, ob sie Krebs oder noch mal eine Extrauterin gravidität hat. Und die folgende Maßnahmen

Fachbegriffe:

- Acetabulum
- Aorten-Aneurysma
- Meningitis
- Duplikatur
- Volvulus
- Malrotation

29.08.2023 pAVK

Das Arzt-Arzt-Gespräch war wie eine Diskussion. Der Arzt hat mir empfohlen, eine operative Therapie durchzuführen obwohl der Patient im Stadium 2b war (der Patient raucht seit 40 Jahren 25-30 Zigaretten pro Tag und will nicht aufhören). Dann sagte er mir, dem Patienten die operative Therapie zu erklären.

Fachbegriffe:

- Hemiparese
- Glaukom
- Embolus
- Pyelonephritis
- Germinom
- Sedativa
- Kolektomie
- Bursitis
- Asepsis
- Azidose
- Distorsion

28.08.2023 Borreliose

Fachbegriffe:

- Perikarditis
- Gravidität
- Muskelatrophie
- Kryochirurgie
- Clavicula
- Cochlea
- Perfusion
- dorsobasal
- Lungenatelektase
- Fragmentum

24.08.2023 Abzess

Frau x ist eine 31-jährige Patientin, die sich mit 2 Tagen bestehenden druckenden brennenden starken im rechten Gesäß Schmerzen vorstellte. Die Beschwerden seien bewegungsabhängig, stärker beim Drucken, verbessern sich nicht durch Medikamente Einnahmen. Vor 8 Tagen habe sie ein Voltaren Injektion im rechten Gesäß bekommen. Das war gegen einer chronischen Lumbalgie (sie ist Elektrikerin und beugt sie zu viel). Die Diagnose war Weichteil Abzess. Therapie: Abt iv + Abzess eröffnen und drainieren. Ich habe gesagt Punktion, aber er meinte das ist falsch, in 2 Tagen würde die Abzess sich wieder bilden. Dann habe ich „ok, Entschuldigung“ gesagt und er hat gelächelt und gesagt, „kein Stress, hier ist kein ärztliche Prüfung“ (ps. alle Prüfern sind extrem nett).

Sie hatte eine Allergie gegen Penicillin, dann habe ich Vancomycin oder Cotrimoxazol als Abt empfohlen und er hat kann sein gesagt (am Besten wäre es Clindamicin oder Clarithromycin).

Dann musste ich diese Abzessdrainage der Patientin erklären.

Softskills: Empathie zeigen, mit komplizierten Situationen gut handeln, lacheln 😊 und gute Lösungen finden. Z.B:

die Patientin wollte nach Hause gehen, weil ihre 3-jährige Tochter von ihr abgeholt werden musste, aber sie konnte kaum laufen. Ich habe gesagt „Frau x, ich empfehle, dass sie hier mit uns bleiben. Natürlich können sie gehen wann sie wollen, aber Sie haben Fieber, können sich kaum bewegen. Sie sollen stationär aufgenommen werden, hier bekommen Sie die nötige Medikamente und ich kann den Sozialdienst anrufen, damit wir eine Lösung finden“

Zur Mitbeurteilung der Therapie, empfehle ich immer Konsilen anzumelden, die Prüfer mögen das.

Sie hat gesagt sie trinke 1 Bier täglich und meinte „man sagt nur, dass Tabak schädlich ist, aber ich weiß nicht warum Bier schädlich sein kann.“ Dann habe ich erzählt usw

ich habe ihr Geburtsdatum gefragt und sie war so „ich habe schon die Schwester gesagt“ und ich „ich verstehe, Frau x, aber das mache ich standarmäßig, damit wir uns sicher sind, dass Ihre Daten korrekt sind.

sie konnte sich nicht an alle ihre Medikamente erinnern, dann habe ich gesagt „kein Problem, ich rufe Ihren Hausarzt an“. Dann in der Anamnesebogen habe ich geschrieben „Rücksprache mit Hausarzt folgt“

Ich habe mit dem Buch „Fachsprachprüfung erfolgreich bestehen“ gelernt und fand sehr gut. Außerdem meine persönliche Empfehlung ist: für die KP gleichzeitig lernen. Dann nachdem ich fertig mit dem FSP Buch war, habe ich schon begonnen die 80 Fälle der Innere zu lesen und hat schon geholfen, obwohl ich nur halb gelesen habe. Amboss ist auch mega hilfreich.

Und letzte Tipp: ich weiß wie schwierig es für uns alle ist, hauptsächlich für unsere seelische Gesundheit. Die Warteschlange dauern ewig, dann einatmen, ausatmen, planen was ihr inzwischen machen können (arbeiten/ nur lernen?) und chill, das ist machbar.

Fachbegriffe:

- Aspiration
- Hodentorsion
- Basaliom
- Dekubitus

- Pertussis
- Pulmo
- Thyreoidea
- präventiv
- Malignom

21.08.2023 Sprunggelenkfraktur

Klaus Schröder, 38J. 1.80 m, 74 Kg

Anamnese Herr Gerard Schröder ist ein 38-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns wegen seit gestern bestehender, stechender, zunehmender, rechtsseitiger Sprunggelenkschmerzen. Der Patient berichtet, dass er beim Fußballspielen seinen rechten Fuß umgeknickt habe.

Die Schmerzen strahlen in die Wade aus und die Intensität liege bei 8/10 auf der Schmerzskala.

Als Begleitsymptome nannte der Patient Ödeme, Hämatome, Erythem sowie eine eingeschränkte Bewegung des Sprunggelenks. Die Fragen nach Parästhesie, Hypästhesie und anderen Verletzungen wurden verneint.

Die Vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf schmerzbedingte Insomnie

der Rest war genauso wie im Protokoll. Der Patient war unruhig wegen der Schmerzen und am Ende hat gefragt, welche Maßnahmen ich veranlassen würde. Also die AA-Gespräch war sehr oberflächlich. Ich wollte die Weber Klasifikation erklären und die haben mir gesagt, dass es nicht nötig war, dass es nur um die Sprache geht. Bei der Therapie man achten muss, dass der Patient an einer Gerinnungsstörung leide und er heparinisiert werden soll.

[bestanden] *Quelle:* [Telegram](#)

21.08.2023 akute Pankreatitis

03.08.2023 osteoporotische Fraktur

Fachbegriffe:

- Gonarthrose
- Abdomen
- karzinogen
- Cholangitis
- Tibia
- benigne
- Hämatom
- Zyste
- Ileus
- medial

27.07.2023 Anorexia nervosa (2x)

Julia Springer 19.09.2003 168cm/48kg

Die 17-jährige Patientin in untergewichtigem EZ (BMI <17) hat sich heute nur auf den Wunsch von ihrer Mütter wegen Inappetenz und starker Untergewicht der Patientin vorgestellt. Der Patientin zufolge habe sie keine aktuellen Beschwerden. Die Patientin klagte über Appetitlosigkeit und Nahrungskarenz wegen Magersucht seit 1 Jahr. Zudem erwähnte die Patientin, dass sie Sportsüchtig sei (jeden Tag wache sie um 5 Uhr morgens zu joggen auf, sie wolle einen Marathon im Herbst machen) und sie Kaffeesüchtig sei (mehr als 4-5 Tassen pro Tag). Ferner seien der Patienten die folgenden Begleitsymptome aufgefallen: Völlegefühl nach dem Essen (laut der Patientin nur nach dem Erbrechen werde es besser).

Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Obstipation seit Jahren (dazu nehme die Patientin Laxaberal und pflanzliches homöopathisches Abführmittel ohne große Wirkung) und Appetitlosigkeit.

Keine relevanten Vorerkrankungen seien bekannt. Als VO wurde bei Patientin Appendektomie mit 12. L.J. durchgeführt.

Keine Allergie sei bekannt. Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum wurden verneint. Familienanamnese sei unauffällig. Sozialanamnese: die Patientin sei Schülerin im Gymnasium, wohne mit ihrer Eltern zusammen und habe einen Bruder (3 Jahren ältere als sie).

Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf Anorexia nervosa. Als DD kommen folgende Erkrankungen in Betracht:

- Depression
- Anämie
- Hyper/Hypothyreose
- Gastritis
- Psychische Erkrankungen (frühe Phase von Manifestation)

Um diese Diagnose festzustellen oder auszuschließen, empfehle ich folgende Maßnahmen:

1. KU
2. Labor: BB, CRP, ferritin, Vit B12, TSH, T3, T4
3. Abdomensonografie
4. Psychiatrische Konzil

Falls meine vermutliche Diagnose festgestellt würde, würde ich folgende Therapie vorschlagen:

- Psychotherapie
- Alternative Therapie (Lichttherapie, Schlafentzugstherapie)
- Medikamentöse Therapie (SSRI, Trizyklische Antidepressiva)

Fachbegriffe:

- Embolus
- Kontraktion
- Otitis Media
- Kardiomegalie
- inhalieren
- Sensibilität
- Anorexia nervosa
- resezieren

20.07.2023 Divertikulitis

Herr Wehmer Ulrich 68 Jahre, 166cm, 68kg.

Kam zu uns mit Abdominalgie sinister, dumpf, ohne Ausstrahlung, dauerhaft, 7/10 auf der Schmerzskala, keine Auslöser, begleitet mit, abwechselnd Diarrhö und Obstipation sowie Febris, andere Symptomen unauffällig.

Vegetativanamnestisch ergab sich lediglich Parasomnie.

Bei den Vorerkrankungen ergab sich Hypercholesteronämie und Hüftgelenksarthrose links

Medikamente: Voltaren retard

Allergien gegen Chrome und Nickel

Noxen: Nichtraucher, 1 Glas Wein abends

Familienanamnese: Apoplex beim Vater und DM bei der Mutter

Sozialanamnese: Verkäufer von Beruf, viel Stress bei der Arbeit, verheiratet, habe 2 gesunde Kinder

Fragen:

- Diagnose?
- Untersuchungen?
- Was finden wir in Ultraschall?
- müssen wir sofort operieren?
- Warum gibt es abwechselnd Diarrhö und Obstipation beim Divertikulitis?
- können Sie uns das erklären?
- Medikamente und Therapie?
- Könnte es Appendizitis sein?
- Wirst du ein Koloskopie sofort durchführen?
 - Warum nicht?

18.07.2023 tiefe Venenthrombose (TVT)

Dokumentation Name Frau Anna Müller Alter 52 Jahre Alt ,Geburtsdatum: 04.04.1971 Große 168 cm Gewicht 61 kg Hausärztin Herr Dr. Müller

Allergien und Unverträglichkeiten keine

Noxen Rauchen: 30 Zigaretten am Tag für 30 Jahren (~45 Packungsjahr) Alkohol: 1 Glas Rotwein fast jeden Abend Drogen: mit 20 hat sie Joint geraucht. Schon längst aufgehört.

Sozialanamnese Beruf: Geschäftsführerin in einem internationalen Konzern Familienstand: verheiratet, lebe mit ihrem Ehemann zusammen Kinder: 2 gesunde Töchter

Familienanamnese Vater: Koagulopathie (Blutgerinnungsstörung) bzw. Thrombose Mutter: Diabetes Mellitus (vermutlich Typ 1 seitdem die Patientin geboren ist) keine Geschwister

Aktuelle Beschwerden Frau Müller ist eine 52-jährige Patientin, die sich heute bei uns in der Notaufnahme wegen einer seit 3 Tagen bestehenden rechtsseitigen Unterschenkelanschwellung (Beinödem) vorgestellt. Sie berichtete, dass ihr rechtes Bein rötlich, wärmer geworden ist. Zudem klagte sie ebenfalls über Spannungsgefühl sowie progrediente, beim Gehen verschlimmerte Schmerzen am betroffenen Bein.

Die Schmerzintensität sei 5 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend habe sie schmerzbedingte Durchschlafstörungen (Insomnie).

Außer Obergenannten ist die vegetative Anamnese unauffällig. Darüber hinaus gab sie an, dass die Beschwerden 2 Tagen nach einem 12-stündigen Flug von Bangkok nach Frankfurt auftraten.

Vorerkrankungen und Medikation Unter Vorerkrankungen sind weitere bekannt:

- arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
- Diabetes Mellitus typ 1 seit ihrem 14. Lebensjahr
- Vor 10 Jahren wurde eine Phlebektomie bei ihr durchgeführt.

In Bezug auf Medikation nehme sie die folgenden Medikamente ein;

- Östrogen-pille 1-0-0
- ACE-Hemmer 1-0-1 (An den Namen und die Dosis kann sie sich nicht erinnern)
- Insulin 20 Einheit s.c.

Der Patient sei vollständig geimpft.

Verdachtsdiagnose Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf tiefe Venenthrombose hin.

Differenzialdiagnose Differenzialdiagnostisch kommen 1) PAVK 2) Cellulitis in Betracht.

Diagnostische Maßnahmen Zur weiteren Abklärung würde ich gerne folgende körperliche labortechnische Untersuchungen durchführen:

1. Die körperliche Untersuchung. 1. Der betroffene Unterschenkel: Homan-Zeichen, Meyer-Zeichen 2. Vitalparameter
2. Labor
 - BB
 - Nierenparameter
 - Entzündungsparameter CRP BSG
 - D-Dimer
 - APTT, PT, INR
3. Bildgebende Untersuchung * Farbduplex-Sonographie ggf. CT-Angiografie/Venografie * Komprimierbarkeit bei der Sonografie

Therapie: Sollte sich der Verdacht auf TVT bestätigen, würde ich gerne die folgenden therapeutischen Maßnahmen empfehlen:

1. stationäre Aufnahme
2. Analgetika
3. Vollheparinisierung mit APTT Kontrolle ggf. LMWH 1 mg/kg s.c. q 12 hr
 - wenn Kreatinin-Clearance <30 ml/min LMWH 1 mg/kg s.c. q 1 Tag

4. Fibrinolyse oder Thrombektomie je nach Schweregrad
5. Lokale Kompression

Arzt-Arzt-Gespräch

1. Was spricht für TVT?
 - Alle Beschwerden
2. Welche Risikofaktoren hat die Patientin?
 - Immobilisierung(langer Flug)
 - Östrogen-pille, orale Kontrazeptiva
 - Tabakkonsum
 - aHT
3. Welche therapeutischen Maßnahmen würden sie anordnen?
 - siehe Oben
4. Welche Komplikationen können auftreten?
 - Lungenembolie
 - Schlaganfall in welchem Sonderfall? >> bei Patienten mit dem persistierenden Foramen ovale, der Embolus kann durch das Loch zu dem Hirngefäß wandern.
5. Um TVT und pAVK zu unterscheiden, wie kann man einfach bei der körperlichen Untersuchung machen?
 - Puls fühlen (am Leistenbereich und unter)
6. Was können wir machen, um die Patientin auf die Entlassung vorzubereiten?
 - Bridging zum Macumar (zeitweise Überbrückung einer langzeit-Antikoagulation durch ein anderes)
7. Wie lange sollte die Patientin Macumar einnehmen?
 - Ich habe gesagt mindestens 3 Monate bis 6 Monate, aber fall die Patientin zufälligerweise Malignom hat, sollte die Patientin Macumar langfristig bis zur Heilung des Malignoms einnehmen.
 - Der Oberarzt hat mir gesagt, 1 Jahr wäre besser.
 - Ich muss noch recherchieren.

Fachbegriffe:

1. Abort
2. Colon
3. Myokarditis
4. Inkontinenz
5. metabolisch
6. Nephrektomie
7. Pulmo
8. Analgetikum
9. Halluzination
10. Obstipation
11. Rezidiv
12. Chronisch

18.07.2023 tiefe Venenthrombose (TVT)-1

Der Fall war *genauso* wie von meinem Kollegen *oben beschrieben* (TVT), nur mit einigen Unterschieden in den Angaben.

Fragen: Wie kann man VD und DD ausschließen? Wie schließt man jede DD aus? Was ist Claudicatio intermittens? Welche Zeichen gibt es und welche Maßnahmen und Therapien sind empfehlenswert? Welche Risikofaktoren gibt es? Komplikationen und wie verhindern ?

Fachbegriffe:

- Rezidiv
- Gastrotomie
- Splenektomie
- Os pubis
- intercostal
- Dialyse
- Inkontinenz
- Lobulus

17.07.2023 rheumatisches Fieber

48 Jähriger Patient mit Großgelenkschmerzen. Vor 3 Wochen war er beim Hausarzt wegen Halsschmerzen ... und Antibiotika wurden verschrieben

Aufklärung von TEE

Fachbegriffe: (12)

- Ikterus
- Sugillation
- Pankreatitis
- okzipital
- Antipyretika

13.07.2023 akute Pankreatitis

- Apoplex
- Parkinson
- Konjunktivitis
- gastroenterologisch
- Colon
- digitale Untersuchung
- resezieren
- Flexion

10.07.2023 pAVK Stadium 2 b

Der Patient stellt sich heute bei uns in der Notaufnahme wegen seit 4 Monaten bestehender , zunehmender krampfartiger , linksseitiger Wadenschmerzen vor.

Er berichtet, die Schmerzen seien nach Gehstrecke von 100 m aufgetreten, und er brauche eine 5 Minuten Pause um weiterzugehen.

Die Fragen nach Schwellung , Rötung , blasse Haut, Kühlung an der Betroffenen Stelle , Fieber , offene Wunde wurden verneint VE : Diabetes Type 2 Arterielle Hypertonie.

Arzt-Arzt Gespräch:

- Diagnose
- Körperliche Untersuchung und wo genau tasten sie den Puls
- Weiteren Untersuchung um Klassifikation zu bestätigen (Laufband)
- Duplexsonografie
- Therapie für 4 Stadien
- Risikofaktoren
- was empfehlen Sie den Patienten
- Ist die arterielle Hypertonie stabil jetzt (ich habe den Patienten in die Anamnese nicht gefragt)
- Wie ist ihr Diabetes (auch in die Anamnese habe danach nicht gefragt)
- Wie heißt Pavk (Schaufenster Krankheit) warum heißt so ?

Fachbegriffe:

- Myopie
- Episiotomie
- Hypophyse
- Ejakulation
- Genu
- Duplex

[bestanden] -[LanguageTool](#)-

06.07.2023 Alzheimerkrankheit

Der Patient hat sehr langsam geredet. (psychomotorische Verlangsamung)

Herr Benzler, 83 Jahre alt , mit folgenden Symptomen: Gedächtnisstörungen seit langem Schläfrigkeit Fatigue depressive Stimmung Schwierigkeiten, sich zu äußern

Vegetative Anamnese: Obstipation Insomnia in Form von Einschlafstörung (trotz Schläfrigkeit) Appetitlosigkeit

Arzt-Arzt Gespräch:

- Vorstellung
- wie gehen Sie vor? Welche Laborwerte?
- Differenzialdiagnosen
- Verdachtsdiagnose
- was machen Sie als Hausarzt für diesen Patienten (Demenz und lebt allein)? Ich informiere den Sozialdienst.

Fachbegriffe:

- Obstipation
- Bluttransfusionen
- Pertussis
- Pulmo
- Basaliom
- Intoxikation
- Malignom
- Thyroidea
- Präventiv

[bestanden]

06.07.2023 Alzheimerkrankheit-1

Herr Klaus Benzler ist ein 83-jähriger Patient, der heute Morgen zu uns im Begleit von seiner Nachbarin kam. Er stellte sich wegen seit langer Zeit bestehender, progredienter Amnesie vor. Die Nachbarin gab an, dass die Beschwerden besonders in letzten 3-4 Monaten schlimmer geworden seien. Darüber hinaus klagte der Patient über depressive Stimmung, Fatigue, Schläfrigkeit.

Arzt-Arzt Gespräch: DD? Welche Laborwerte sind wichtig? Was sollen wir jetzt machen? Ich habe gesagt, dass wir mit Sozialdienst kontaktieren sollten. Das hat ihnen sehr gefallen. Die Prüfer waren sehr, sehr nett.

Fachbegriffe:

- Adaptation
- Tubargravidität
- Cutis
- Kehlkopf
- Dorsal
- Nephritis
- analgetisch

[bestanden]

03.07.2023 Diabetes mellitus Typ I

15.06.2023 Angina pectoris (2x)

Symptom: Engegefühl in der Brust

Fragen Verdachtsdiagnose (VD) und Maßnahmen. Aufklärung des Patienten was hat er und überzeugen wir ihn Herzkatheter zu machen.

Fachbegriffe:

- Atrophie
- Mandibula
- Ösophagus
- Konjunktivitis
- Aszites

- Retina
- Splenektomie
- Letalität

07.06.2023 Ulcus ventriculi

35-jähriger Patient hat sich bei uns wegen seit 4- 5 Tagen aufgetretener stechender Schmerzen im Epigastrium vorgestellt.

Apotheker, er finde seine Arbeit stressig. Er nehme Analgetika in Bedarf ein. Es sei ihm Übel, aber musste er nicht erbrechen. Darüber hinaus leide er an Kopfschmerzen.

Vegetative Anamnese sei bis auf Insomnia unauffällig.

Vater-> gesund Mutter-> diabetes mellitus Bruder -> arterielle Hypertonie Raucher, 20-25 Zigaretten täglich 2 Gläser Wein täglich

Arzt-Arzt Gespräch:

- Verdachtsdiagnose,
- Wie sollen Sie behandeln?
- Gastroskopie Aufklärung

Fachbegriffe:

- maligne
- Inhaler
- Hyperkaliämie
- Pertussis
- Basaliom

00.06.2023 Pneumonie

Herr: Mais 56 Jahre. 1,70 m 70 kg Allergien: Penicillin (Exanthem) Verheiratet / zwei gesunde Kinder. Arbeit: Angestellter. Vater: gesund Mutter: Pankreaskarzinom (gestorben) Rauchen: unauffällige. Alkohol : 1 Glas Wein am Wochenende.

Er kam heute zu uns mit seit 3 Tagen bestehendem, plötzlich aufgetretenem progredientem Fieber 40°. Begleitend habe er Schüttelfrost, Husten mit gelbem schleimigem Sputum, Schweißausbruch, Dyspnoe, Insomnie und Thorakalgie ohne Ausstrahlung. Dagegen habe er Paracetamol 500mg, Asprin und Codein eingenommen und das habe ihm nicht geholfen.

Die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis auf Inappetenz.

Die Sexualanamnese ergab Impotenz.

Die Vorerkrankung-Anamnese ergab Diabetes mellitus seit 12 Jahren, mit Metformin 850mg behandelt , arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, wogegen er Linopril 5mg (1.0. ,5) und HCT 12,5mg (1.0.0) nehme. Z.n. Prostatakarzinom vor 2 Jahren, das mit Prosastektomie und Zytostatika behandelt wurde.

Es besteht der Verdacht auf Pneumonie.

Als **Differenzialdiagnosen** kommen Influenza und Covid-19 in Betracht.

Weitere Maßnahmen sind: -Körperliche Untersuchung. -Laboruntersuchung: BB, CRP, BSG, BGA, Sputum und Blutkultur. -Als bildgebende Untersuchungen (Röntgen und C. T des Thorax. -Nasen-Rachen Abstrich.

Arzt-Arzt Gespräch:

Ich habe nur die aktuelle Anamnese präsentiert, und dann fing er an zu fragen. Das Gespräch hat ungefähr 15 Minuten gedauert.

(Jede Antwort muss ein vollständiger Satz sein, aber ich werde mich kurz äußern)

- Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? *Pneumonie*
- Welche Risikofaktoren für Pneumonie hat der Patient? *er klagt an D.M und arterielle Hypertonie, und Z.n Zytostatika und alle diese Risikofaktoren neigen zu Pneumonie.*
- gibt's eine Verbindung zwischen HCT und Pneumonie? *ehrlich gesagt, ich weiß nicht, aber ich denke, da besteht kein Zusammenhang.*
- Was ist HCT? *Es ist eine Abkürzung für Hydrochlorothiazide und wirkt auf die distalen gewundenen Tubuli.*
- was sollen Sie machen? Körperliche Untersuchung Aals erste Maßnahme.....
 - Was erwarten Sie bei? *Inspektion: Zyanose, Tachypnoe , Palpation: Stimmfrimetus ist verstärkt. , Auskultation: Rasselgeräusche, Perkussion :Klopfschalldämpfung.*
- Oberarzt: Bezüglich der Laboruntersuchungen, was erwarten Sie? *BB Leukozytose (neutrophile) CRP und BSG erhöht.*
- Ist HbA1c wichtig? *ja, es ist sehr wichtig.*
 - Warum? wenn HbA1c erhöht, ich denke an die Komplikationen, und Pneumonie gilt als Komplikation des D.M und auch Immunsystem.
- Was erwarten Sie bei Röntgen: Infiltrat
 - in welche Lappen? *ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.*
- Oberarzt: welche Therapie? *Allgemeine Maßnahmen..... der Patient hat Penicillin Allergie, deshalb werde ich Penicillin vermeiden, und danach werde ich empirische Antibiotika geben.*
 - welche Antibiotika? *Makrolid z.B Clarithromycin*
- gibt's andere Antibiotika? *Ceftriaxon*
- Welcher Typ von Pneumonie hat der Patient? *ambulant erworbene Pneumonie*
 - Warum? *Während dieser letzten Tage gibt es keine Hospitalisierung*

[bestanden] -LanguageTool-

07.06.2023 Zöliakie

Der Patient hat nur fettiger Durchfall nach der Aufnahme von Brot und Nudeln seit 5 Monaten und Gewichtsverlust von ca. 6 kg innerhalb 5 Monaten. Ohne Schmerzen oder Fieber.

Arzt-Arzt Gespräch:

- Differenzialdiagnose (DD)
- Risikofaktoren
- Warum denken sie nicht Morbus Crohn?
- Der Durchfall des Patienten hält seit 5 Monaten in gleicher Schwere an, dauert zu lange, was könnte der Grund sein?
- Diagnose und Therapie

Fachbegriffe:

- Atrophie
- Dehydration
- Aszites
- metabolisches
- Letalität
- Pleuritis
- Placeboeffekt
- Angulus
- Ösophagus

[bestanden] -[LanguageTool](#)-

05.06.2023 Diskusprolaps

Der 51-jährige Herr Kleist stellte sich in unserer Notaufnahme wegen seit 4 Wochen bestehender progredienter Zervikalgie mit Ausstrahlung in den rechten Oberarm vor. Als Auslöser nannte der Patient einen Versuch vor 4 Wochen, eine schwere Kiste aufzuheben, als er seinem Schwiegersohn bei dem Umzug geholfen habe. Bei diesem Ereignis fühlte der Patient plötzlich einen Knixen (oder so etwas) und dann hätten die Schmerzen begonnen. Die Fragen nach Kopfverletzungen, Synkope, Nausea, Vomitus, Amnesie bei diesem Ereignis wurden verneint. Im Laufe der Zeit seien die Schmerzen stärker geworden und sie verstärken sich bei den Bewegungen des Kopfes und Anheben des rechten Armes.

Der Patient habe Ibuprofen mit einer vorübergehenden Schmerzlinderung eingenommen, die letzten 10 Tagen 800 mg 3-mal pro Tag. Die Fragen nach Parästhesien und Myasthenie im rechten Arm wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab Obstipationen seit langem. Die Fragen nach Gewichtsverlust, Fieber und Nachtschweiß wurden verneint. Der Patient leide an COPD. Er habe eine Appendektomie in Kindheit und eine Cholezystektomie vor 10-15 Jahren ohne Komplikationen gehabt. Er nehme regelmäßig Statine 0-0-1 und bei Bedarf Antihistaminika (ich habe die Namen schon vergessen). Bei Bedarf nutze er auch Spray. Allergie: Hausstaub (Nießen).

Noxen: Er rauche seit 30 Jahren 1,5 Packungen pro Tag (45 py) und trinke 1-2 Flaschen Bier pro Woche. Soziale A.: Er sei verheiratet und habe 2 Kinder, arbeite als Büroangestellter. Familienanamnese: Mutter sei im Alter von 45 Jahren an den Folgen des Pankreaskarzinoms gestorben. Der Vater sei gesund.

Verdachtsdiagnose: Diskusprolaps hin.

Differenzialdiagnosen: Wirbelfraktur, Knochenmetastasen

Diagnostik: körperliche Untersuchung, Blut, Rg-Thorax und MRT der Wirbelsäule.

Bei Bestätigung der Diagnose: Analgetika NSAID (+PPI); ggf. Opiode;

CT-gesteuerte Injektion von Lokalanästhetikum an die Nervenwurzel; Bewegungstherapie; Physiotherapie, Orthesen.

Bei Indikation operative Therapie.

Die Fragen bei dem Arzt-Arzt Gespräch waren über Diagnostik, Therapie und Einzelheiten der Anamnese.

Fachbegriffe:

- STIKO
- Thyreoidektomie
- Multimorbidität
- Veneninsuffizienz
- Claudicatio intermittens
- Tonsillitis purulenta
- Compliance
- Adipositas
- Carotisstenose
- Logopädie
- Dysarthrie

Die Kommission war sehr nett und der "Patient" hat deutlich auf Hochdeutsch gesprochen.

[bestanden] -[LanguageTool](#)- Quelle: [Telegram](#)

01.06.2023 rheumatisches Fieber

Der Patient ist mit Gelenkschmerzen gekommen, er hat gesagt , dass die Schmerzen wandern , manchmal, am Fußgelenk, manchmal an der Schulter ,die Gelenke sind geschwollen , warm und schmerzhaft , er hatte auch Fieber und die Beschwerden sind vor 2 Tagen aufgetreten , ich habe nach Tonsillitis, gefragt und er hat mir gesagt, dass vor 2 Wochen er Halsschmerzen hatte und mit Antibiotika behandelt wurden.

Ich habe nach alles gefragt, aber die Fragen wurden verneint.

Fachbegriffe:

- Lobus
- Gastrostomie
- Hernia umbilicalis
- Inkontinenz
- Rezidiv
- interkostal
- Splenektomie
- Os pubis
- Vena pulmonalis

00.06.2023 Pneumonie

Die Prüfern waren sehr nett. Ärztliches Gespräch, Standard Fragen, Diagnose, Risikofaktoren körperliche Untersuchung, apparativ Diagnostik und Therapie, keine Aufklärung.

Fachbegriffe: Urosepsis

08.05.2023 Colon irritabile

Herr Klaus Müller 53 Jahre alt 179 cm 80 kg stellte sich bei uns wegen seit 3 Monaten auftretender Abdominalschmerzen vor. Die Schmerzen hätten nirgendwohin ausstrahlt und seien maximal ein 7 auf einer Skala von 0 bis 10. Herr Müller berichtet weiter, dass die Schmerzen nach der Darmentleerung nachgelassen hätten. Im Verlauf des obigen Zeitraumes habe er Diarrhö oder Obstipation gehabt. Die Fragen zu Gewichtsveränderungen, Zusammenhang mit Lebensmitteln und Fieber wurden verneint.

Der Patient leide an folgenden Vorerkrankungen:

- arterielle Hypertonie
- Diabetes mellitus

Z.n. Appendektomie vor 50 Jahren.

Arzt-Arzt Gespräch

- Verdachtsdiagnose
- Differenzialdiagnosen und Diagnostik der VD.
- Mögliche Laborbefunde
- Aufklärung einer Koloskopie und wie man sie durch führt
- Beratung, Behandlung und allgemeine Maßnahmen.

[bestanden] -LanguageTool-

08.05.2023 Depression

Herr Anton Kaiser 53 Jahre alt 170 cm, 115 kg kam zu uns mit Lustlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, habe keinen Kontakt zu Freunde und Familie und Gewichtszunahme von 10 in 2 Jahren, begleitet mit Belastungsdyspnoe. Die Fragen zu Cephalgie, Haarausfall, Halluzination und Fieber wurden verneint. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Bei den Vorerkrankungen erwähnte er aHT seit 15 Jahren, Gonarthrose und Z.n. Appendektomie.

Arzt-Arzt Gespräch

- Was habe der Patient
- Was sind Risikofaktoren
- Wie gehen sie vor?
- Welche Blutwerte sind wichtig?

Begriffe Adenotomie Struma Rezidiv Fluktuieren

04.05.2023 Appendizitis

04.05.2023 Migräne

Fachbegriffe:

- Myopie
- Ejakulation
- duplex
- Episiotomie
- Anorexia Nervosa
- Demenz
- Genu
- Hyperkaliämie
- Karenz

26.04.2023 Divertikulitis

Die Fragen waren:

- Verdachtsdiagnose (VD)
- Differenzialdiagnose (DD)
- Ist das klinische Bild typisch für eine Divertikulitis? Nein: Kein Übergewicht und Mann.
- Indikation einer Koloskopie?
- Nach dem Abklingen der Entzündung. Ausschluss Divertikulose und Kolon K
- Therapie?
- Diagnostische Maßnahmen
- Was sehen Sie in der Sonographie?
- Was machen Sie, falls es gibt einen Abszess: Transkutane Punktion, ggf. Sigmoidektomie.
- Was spricht gegen Kolitis Ulcerosa (Alter, kein Blut im Stuhl ...)

Fachbegriffe:

- Tibia
- Thyreoidea
- Spatium
- Inhalieren
- Gonarthrose
- Pertusis
- Intoxikation
- Dekubitus
- Basiliom
- Ligament

Die Prüfer sind nett. Ich habe die Therapie nicht geschrieben. (Keine Zeit) Sie haben nichts gesagt.

Die Anamnese war sehr seltsam: Der Prüfer hat alles in einmal gesagt: "Herr Dr. Ich habe seit 2 Wochen bestehenden, langsam aufgetretenen, zunehmenden linkseitigen Schmerzen im Unterbauch". Ich war schockiert, ich wusste nicht mehr, was ich fragen sollte.

[bestanden] -LanguageTool-

26.04.2023 Pyelonephritis

Was sehen wir in Sonografie? Komplikation des Pyelonephritis war Sepsis , Sie haben Urinprobe gefragt. Die Antwort war Mittelstrahlurin.

Fachbegriffe:

- Neoplasie
- Laxativum
- Inzision
- Colon Irritabile
- Sinus maxillaris

25.04.2023 Laktoseintoleranz

25.04.2023 Appendizitis (2x)

OP **Erklärung** hat dem Oberarzt gefragt.

19.04.2023 Sprunggelenkfraktur

Fachbegriffe:

- Stiko
- Multimorbidität
- Compliance
- Tonsillitis
- purulent
- Claudicatio intermittens

17.04.2023 obere intestinale Blutung

Fachbegriffe:

- Hyperkapnie
- Lobektomie
- Splenektomie
- Gastrektomie
- Intraokular
- Humerusfraktur
- Thrombektomie
- Angiografie

17.04.2023 akute Pankreatitis

Fachbegriffe:

- medial
- Ekzem
- Gonarthrose

- Abdomen
- Ileus
- Zyste
- Tibia

06.04.2023 periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

Patientenname: Warter Vogel

- Alter: 67 Jahre alt.
- Größe: 167 cm
- Gewicht: 76 kg
- Allergien/ Unverträglichkeiten:
- Penicillin, die allergische Reaktionen: Exanthem, Pruritus.

Genussmittel/ Noxen:

- Er sei Raucher seit 40 Jahren, 25 - 30 Zigaretten täglich.
- Er trinke gelegentlich Alkohol.(Bier)
- Drogen wurden verneint.
- Sport Anamnese: Er treibe keinen Sport.

Impfstatus: Sei vollständig.

Sozialanamnese:

- Er sei Rentner, früher sei Busfahrer.
- Er sei verheiratet und habe 2 erwachsenen Kindern.
- Er wohne mit seiner Frau in einer Wohnung zusammen.

Familienanamnese:

- Der Vater des Patienten sei an aHT verstorben.
- Die Mutter des Patienten sei an DM Typ 2 verstorben.

Aktuelle Beschwerden: Herr Vogel ist ein 67_ jähriger Patient, der sich heute bei uns in der Notfallaufnahme wegen seit paar Tagen bestehender, stechender, krampfartiger, rechtsseitiger belastungsabhängiger Unterschenkel Schmerzen vorgestellt hat.

Er berichtete, dass beim Gehen verspüre, er nach einer Strecke von 50 _ 75 Meter diese Schmerzen verspüre, dann müsse er stehen bleiben und eine Pause machen.

Er fügte hinzu, dass die Schmerzen im Lauf der Zeit schlimmer geworden, und in Ruhe besser geworden.

B. Symptome:

Er klagte über:

1. Kälte Haut des rechten Beins.
2. Beinödem
3. Rubor.

Vegetative Anamnese: Unauffällig bis auf:

- Obstipation seit langem.
- morgendlicher Reizhusten

Vorerkrankungen/Voroperationen: Er leide an die folgenden Erkrankungen:

1. Er habe einmal seit 8 Jahren Herzinfarkt gehabt, dagegen er Koronarangiografie mit Stent durchgeführt habe.
2. arterielle Hypertonie seit 6 Jahren.
3. Hypercholesterinämie
4. lumbal Diskusprolaps seit 15 Jahren.

Voroperationen: Er habe keine Operation gehabt.**Medikamentenanamnese:**

1. Atorvastatin ... mg, 1.0.0
2. Bisoprolol ... mg, 1.0.0
3. Ibuprofen b.B.

Verdachtsdiagnose: Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf pAVK hin.**Differenzialdiagnosen:**

- tiefen Venenthrombose (TVT)
- Spinalkanalstenose
- Erysipel
- Trauma (Unterschenkel Fraktur)

Maßnahmen:

- Als erste Maßnahme würde ich den Patienten körperlich untersuchen: Vitalzeichen messen, Puls prüfen (A. dorsalis pedis, A. posterior tibialis um pAVK zu bestätigen).
- Mayer Zeichen, Player Zeichen, Homans-Zeichen um TvT auszuschließen.
- Laboruntersuchung: BB, CRP, BSG, Entzündungsparameter, D.Dimer, INR, Gerinnungswerte, Lipidspiegel, HbA1C)
- Röntgen des rechten Beines um Fraktur auszuschließen.
- EKG
- Farbkodierte Duplexsonografie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende **Therapie** vor,

1. Stationäre Aufnahme.
2. Analgetikum
3. Statin
4. Antikoagulation Therapie.
5. Kardiologisches Konzil veranlassen.
6. Lebensstilveränderung:
7. Tabakabstinenz
8. Alkoholabstinenz

- 9. Bewegungsaktivitäten
- 10. Nahrungsumstellung

Fachbegriffe:

- Agonie
- Apex cordis
- Auricula Auris
- Brachialgie
- Capitulum
- cave!
- Cavum
- Commissura
- Commotio cerebrie
- Dens
- Dermatoze
- Cutis

Fragen:

1. Patienten Vorstellung
2. Duplexsonografie aufklären.
3. Gründen von Verdachtsdiagnose, Risikofaktoren.
4. DD warum TVT, warum Spinalkanalstenose, ...
5. Maßnahmen Schritt bei Schritt
6. Ob der Patient eine OP braucht oder nicht.
7. Was ist pAVK, Umgangssprache (Schaufensterkrankheit, warum wird Schaufensterkrankheit genannt).
8. Therapie
9. pAVK aufklären für den Patienten

Die Kommission war sehr professionell und nett.

[bestanden] -LanguageTool-

27.03.2023 Obere gastrointestinal Blutung

Meläna, Hämatemesis, Essen als Auslöser, Stress bei der Arbeit.

Meine Fragen waren:

- Vorstellung des Patienten
- OGD Aufklärung
- Risiko
- wie kann man die Blutung stillen durch die Endoskopie.

27.03.2023 Rheumatisches Fieber (2x)

Herr Olaf Stehmann, Müdigkeit seit 3 Tagen..... Gelenkschmerzen... Ödem, Überwärmung Fieber 39
Inappetenz Keine VE Er hat vor 2 Wochen Angina Tonsillitis gehabt, die mit Penicillin behandelt wurde(nur
3Tagen eingenommen habe) Operation Cholezystektomie Eltern gesund

Fachbegriffe:

- Dyspnoe
- Trachea
- Radiatio
- Pankreas

Keine Aufklärung

Nur erklären für Pat. Er fragte mich, was ich habe Frau Doktor: rheumatisches Fieber Ihre Beschwerden sprechen für RF, und Sie haben mir gesagt, dass Sie das Antibiotikum nur für 3 Tagen eingenommen haben, deswegen haben Sie solche Beschwerden Aber machen Sie sich keine Sorgen Wenn die Verdachtsdiagnose richtig ist, dann Sie brauchen nur Antibiotikum für 2 Wochen ...

18.01.2023 Appendizitis

18.01.2023 Pneumonie

Fachbegriffe:

- Sinus maxillaris
- Liquor
- Struma
- Distorsion
- Hypercholesterinämie
- Herzinfarkt
- Ductus choledochus

Aufklärung: sonographie und Blutabnahme

30.01.2023 Sprunggelenksfraktur

Die Prüfern waren sehr nett. Zuerst haben wir ein inoffizielles Gespräch wo ich mich vorgestellt habe und sie haben ein paar Fragen an mich gehabt (woher ich komme, wo ich studiert habe usw.). Dann hat ein Arzt den Patienten gespielt. Er hat viel erzählt.. man muss nur genauer zuhören und danach nachfragen. Dann hatte ich 20 min für Schreiben des Arztbriefes. Dann habe ich den Patienten vorgestellt und der OA hat mich gefragt nach die Diagnose, wie kann ich die Dg. feststellen. Dann hat er gefragt welche Narkose Möglichkeiten es gibt, und nach Komplikationen die mit Narkose verbunden sind. Am Ende habe ich 10 Begriffe bekommen.

Fachbegriffe:

- exsikkiert
- Cerebrum
- Palpation
- Palliative Therapie
- Anxiolyse
- Ödem
- Sepsis
- Meläna

08.02.2023 obere gastrointestinale Blutung

Symptome: seit 2 Wochen starke brennende Oberbauchschmerzen, dunkler Stuhl und Hämatemesis.

Begleitsymptome: Aufstoßen, Sodbrennen, Mundgeruch, Heiserkeit

Der Patient hatte große Angst von Krebs und wollte über die Magenspiegelung mehr wissen.

Fachbegriffe:

- präventiv
- maligne
- Pulmo
- Pertussis
- Obstipation
- Dekubitus
- inhalieren
- Intoxikation

08.02.2023 Hüftkopfnekrose

Der Fall war Hüftkopfnarkose aber mein VD war Coxarthrose.

Leitsymptome anhaltende Schmerzen im Hüftbereich (ohne Rötung ohne Wärmung)

Vorerkrankungen Diabetes , Hypertonie

vegetative Anamnese unauffällig

Fachbegriffe:

- Aneurysma
- Menopause
- Hepatitis
- Varizelle
- Pneumektomie
- Sepsis

09.02.2023 rheumatisches Fieber

Der Patient ist 45 JA, vor 3 Wochen hat er Tonsillitis (Streptokokken) gehabt, die wurde mit Penicillin behandelt (er hat das Antibiotikum nur 3 Tagen eingenommen). Seit 10 Tagen hat er Gelenkschmerzen, erstes in linke Ellenbogen dann in rechten Hüft, Kniegelenk und Schulter.

Er hat keine Vorerkrankungen oder Op, er nimmt keine Medikamente.

Meine Verdachtsdiagnose war rheumatisches Fieber.

Differentialdiagnose: septische Arthritis und rheumatische Arthritis .

Das Arzt-Arzt Gespräch war interaktiv und die Prüfer waren sehr nett. Ich habe die Prüfung bestanden

Fachbegriffe:

- pulmonal
- Diarrhoe
- metabolisch
- Myokarditis
- Hallucination
- Inkontinenz

00.02.2023 Migräne

Die Kommission (3 Männer) war sehr nett, aber das bedeutet, nicht, dass sie alle bestehen lassen. Hören und auch spontan sprechen zu können, ist für die Prüfung sehr wichtig. z.B. der Patient war am Anfang unruhig und hat mit 'ohhh frau Doktor, ich habe sehr, sehr heftige Kopfschmerzen' angefangen und ich habe gesagt 'Es tut mir leid, dass die Schmerzen so heftig sind, aber zuerst muss ich mich vorstellen und über Ihre persönlichen Daten fragen.' Das hat ihnen gefallen. Er hat auch gesagt, dass seine Mutter an Gehirntumor gestorben ist und gefragt 'werde ich auch sterben, habe ich auch Tumor, was ist meine Diagnose' usw.

Im Arzt-Arzt Gespräch gab es keine Aufklärungen. Ich habe zuerst über die aktuellen Beschwerden gesprochen, der Arzt hat mich unterbrochen und meine Diagnose und die Therapiemöglichkeiten gefragt. In der Prüfung geht es nicht um Medizin, sondern um Deutschkenntnisse. Sie haben mir das deutlich am Anfang gesagt. Ich denke, es macht nichts, wenn man die Diagnose oder Therapie nicht weiß, aber man muss Deutsch sprechen können. Ich auch glaube, dass sie keine auswendig gelernten Sätze mögen.

Fachbegriffe:

- Femur
- Anämie
- Spinalstenose
- Defibrillator
- Endokarditis
- Osteosynthese
- Palpation
- Arteria poplitea
- Ulcus cruris
- kachektisch

16.02.2023 Appendizitis (2x)

16.02.2023 Angina pectoris

Meine Patientin hatte mir VIELE Reaktionen gemacht, ich übertreibe nicht wenn ich sage vielleicht 8-9 Reaktionen und die EKG Aufklärung.

Fachbegriffe:

- kachektisch
- analgetisch
- Cutis

- Larynx
- Nephritis
- Flexur

16.02.2023 Appendizitis

Sie brauchen so viel Empathie und das ist sehr wichtig.

Fachbegriffe:

- kongenital
- intrazerebrale Blutung
- Laryngitis
- Stenose
- Rhagade
- Albumin
- Adhesion
- Cholangitis
- Fibrose

Fragen:

- Welche Zeichen wissen Sie für Appendizitis?
- Psoas Zeichen?
- Wie können wir das Fieber messen? Und welche Unterschied ?

23.02.2023 Abszess am Gesäß

Es gab weder Aufklärungen noch Reaktionen. Die Kommission war nett, beim Arzt Arzt Gespräch, die Diskussion war v.a. über die Behandlung des Patienten.

13.03.2023 Depression

13.03.2023 Appendizitis

Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit gestern Morgen bestehender, plötzlich aufgetretener, drückender, ziehender, postprandialer Abdominalgie in der Regio Inguinalis re. ohne Ausstrahlung vor. Sie berichtet, dass diese Schmerzen von Regio periumbilikalisch in die Regio Inguinalis re. gewandert seien. Des Weiteren, fügt die Patientin hinzu, die Schmerzintensität liege bei 5-6 von 10 einer Schmerzska. Die Fragen nach Nausea, Vomitus, Pyrexie, Nachtschweiß und Schüttelfrost wurden verneint. Die Patientin habe 1 Tablette von Ibuprofen 400mg ohne Verbesserung eingenommen und Wärmflasche wegen Schmerzen benutzt. Die Patientin konnte letzte Nacht nicht auf der rechten Seite schlafen.

In Bezug auf **vegetative Anamnese** leide sie an schmerzbedingter Insomnie, Inappetenz, Obstipation(1 Mal/2 Tagen, Stuhl sei hart, ohne Blut) und produktiver Tussis mit schleimigem Sputum.

Bezüglich der **Vorerkrankungen** leide sie an aHT(seit10J.) und Hypothyreose(seit 10J.). Sie wurde wegen Tonsillektomie (als Teenager), Cholezystitis(vor 10J) und Salpingektomie li.(vor 6-7J) ohne Komplikationen operiert worden. Sie sei vollständig geimpft, auch gegen Covid-19(4-mal).

Sie nehme regelmäßig Ramipril 10 mg(1-0-0), L-Thyroxin 100 µg (1-0-0) und orales Kontrazeptivum ein.

Die **Allergien** und Unverträglichkeiten wurden verneint.

Sie rauche 40 Zig/Tag seit mehr als 20J.(ca.40PY). Sie trinke gelegentlich 1Fl. Bier oder Wein. Der Drogenkonsum wurde verneint.

Sein Vater sei gesund. Seine Mutter habe Apoplex erlitten (leide jetzt an rechtzeitiger Parese und Dysarthrie). Die Schwester habe an Mammakarzinom gelitten(Z.n. Operation, Chemotherapie).

Sie sei verheiratet, habe 2 gesunde Kinder. Sie sei Hausfrau.

A-A Gespräch:

- Welche Diagnose, Untersuchungen, DD, Behandlung.
- Könnte die Patientin schwanger sein?
- Könnte es Möglichkeit von Extrauterin gravidität bestehen?
- Was können wir bei Sonografie des Abdomens schauen? Wichtig ist es bei Frauen gynäkologische Untersuchung, Schwangerschaftstest(Beta-Humanes Choriogonadotropin) und transvaginale Sonografie durchzuführen.

Fachbegriffe:

- Otitis externa
- Makroglossie
- Os coccygis
- Katarakt

[bestanden] -[LanguageTool](#)- Quelle: [Telegram](#)

00.03.2023 Depression

Arztbrief: Herr Karl Heidenreich, 55 Jahre alt, 66 kg schwer, 166 cm groß. Der Patient kam heute zu uns mit seit 2 Monaten bestehenden, drückenden, starken Schmerzen im ganzen Kopf ohne Ausstrahlung. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen am Morgen sehr stark und am Abend besser geworden seien. Darüber hinaus gab er an, dass seine Schwester vor 2 Monaten an Leukämie gestorben sei. Außerdem erwähnte er, dass er eine schlechte Stimmung und keine Lust mehr, etwas zu tun, habe. des Weiteren fügte er hinzu, dass er Durch- und Einschlafstörungen habe. Zudem teilte er mit, dass er bei seinem Hausarzt gewesen sei. Der Hausarzt habe ihm Adumbran 10mg (Benzodiazepin) geschrieben, aber das Medikament habe ihm nicht geholfen.

Die vegetative Anamnese ergab Fatigue.

Als Vorerkrankung hat der Patient seit 20 Jahren arterielle Hypertonie, die mit Ramipril 10mg und HCT 12,5mg einmal morgens behandelt ist.

Der Patient trinkt 2-3 Gläser Wein abends.

Er treibt keinen Sport.

Die Fragen nach Nikotin- und Drogenkonsum wurden verneint.

Der Patient war nicht in letzter Zeit im Ausland.

Er ist durch geimpft. (viermal gegen Covid-19)

Er hat keine Allergien und keine Unverträglichkeiten.

Der Vater hat sich selbst umgebracht und war gesund. Die Mutter hat arterielle Hypertonie und Herzinsuffizienz.

Der Patient ist Bankkaufmann, verheiratet, lebt mit seiner Frau zusammen und hat 2 gesunde Kinder.

Als Verdachtsdiagnose stelle ich Depression. Als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht: Hypothyreose Anämie Gehirntumor

Als erste Maßnahme untersuche ich den Patienten körperlich.

Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden: Blutabnahme und Bestimmung von Hb, TSH, T4 und T3 Ein CT des Schädels muss durchgeführt werden.

Falls die Verdachtsdiagnose Depression bestätigt ist, schlag ich die folgende Therapie vor:

Trizyklische Antidepressiva

Psychotherapie

Patientenvorstellung:

- Was hat der Patient? *Depression*

Der Oberarzt hat mir gesagt:

- Der Patient hat gesagt, dass die Schmerzen am Morgen stark und am Abend besser geworden sind
- Adumbran, Ramipril und HCT verursachen morgendliche Kopfschmerzen, deshalb müssen wir die Medikamente umstellen.
- Wie groß sind die Gläser Wein?

Erklären Sie jetzt dem Patienten die Therapie.

Es gab keine Aufklärung.

Fachbegriffe:

- kardial
- gastroenterologisch
- Abusus
- Palliative Therapie
- Analsphinkter

06.03.2023 Depression

06.03.2023 Angina pectoris

08.03.2023 Lyme-Borreliose

Also die fragen war über wie man Lyme diagnostiziert und medikamentöse Therapie und was passiert wenn es nicht medikamentös behandelt werde.

Aufklärung der Entzündung und Behandlung zu dem Patient.

Fachbegriffe:

- Apoplex
- rezidivierend
- Ulcus ventriculi
- Prostatitis
- Vasculitis
- Pneumonie

08.03.2023 Lyme-Borreliose-1

Mein Fall war Lyme Borreliose wie in der Fälle. Ich hab einige Fragen vergessen zu stellen aber das war normal.

Arzt Arzt Gespräch war cool und interaktiv er fragt nach der Therapie und welche Antibiotika Möglichkeiten haben wir und hat mich um eine doxycyclin Aufklärung gebeten.

Und was wichtig war, dass der Patient nicht nüchtern sein sollte und keine Milchprodukte mit dem Antibiotikum verzehrt

Fachbegriffe:

- Arthritis urica
- Menopause
- Myokarditis
- Laryngitis
- Mastektomie
- Phimose
- Humerus
- Femurfraktur
- Palliative Therapie

09.03.2023 Multiple Sklerose

09.03.2023 Osteoporose

Fachbegriffe:

- Vena cava inferior
- Valva aortae
- Urosepsis
- Glandula
- Induration

Die Kommission war sehr nett

16.03.2023 zervikaler Diskusprolaps

Arzt Arzt Gespräch:

- was ist die Verdacht Diagnose ?
- was ist die Ursache für diese Krankheit ?
- was sind die Risikofaktoren ?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Diagnose und dem Rauchen? *Pt raucht seit 20 Jahren 30 Zigaretten. Ich habe gesagt: Rauchen verursacht COPD UND PULMONALES KARZINOM.*
- Untersuchung
- Therapie
- Erklärung der MRT-Untersuchung
- was wird in der MRT gefunden
- Vorteil der MRT
- Erklären Sie dem Patienten die Therapie
- Wann sollen wir den pt operieren?
- was erwarten wir von der Operation?
- können Sie die Operation erklären?
- Einschnitt von vorne oder von hinten

20.03.2023 Gastroenteritis

Arzt Arzt Gespräch:

- DD
- Risikofaktoren
- Warum denken sie nicht Morbus Crohn?
- Der Durchfall des Patienten hält seit 2 Wochen in gleicher Schwere an, dauert zu lange, was könnte der Grund sein?
- Diagnose und Therapie

Fachbegriffe:

- Atrophie
- Dehydration
- Aszites
- metabolisches
- Letalität

09.06.2022 Hyperurikämie (Gicht)

Ein 45 jähriger Patient, Gewicht: 114 kg, Größe: 170.

Beruf: Mechatroniker.

Aktuelle Beschwerde: Der Patient kam zu Notaufnahme wegen vor 2 Tagen bestehender, brennender dauerhafter Schmerzen am Großzehengrundgelenk auf der linken Seite. Die Schmerzen sind 7 von 10 auf der Schmerzskala. Es gibt weder eine Ausstülpung noch begleitete Symptome. Der Patient ist Nichtraucher und trinkt 2 Flaschen Bier am Abend. Er hat keine Medikamente gegen diese Beschwerde eingenommen.

Vorerkrankungen und OPs:

- Arterielle Hypertonie.
- Migräne (seit 20 Jahren).
- Motorradunfall (vor 25 Jahren, nur konservative Behandlung, keine Frakturen, keine Schädigungen).

Medikamentöse:

- Beta Blocker Bisoprolol 5 mg 1 - 0 - 0
- Keine Allergien kein Fieber.

Die Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf : er isst viel Fleisch.

Familienanamnese:

- Seine Mutter starb an Myokardinfarkt mit 75 Jahren.
- Sein Vater lebt noch.
- Er hat an Prostatakrebs gelitten und er ist mit Radiotherapie behandelt worden.

Sozialanamnese:

- Er ist verheiratet und hat 3 Kinder
- Ein Kind leidet an Trisomie 21 (Down Syndrom)

Verdachtsdiagnose:

- Podagra (Gichtanfall)

D.D:

- Pseudoogicht
- rheumatoide Arthritis
- reaktive Arthritis
- septische Arthritis

Diagnostik:

- Körperliche Untersuchung
- Blutbild (Hyperurikämie)
- Gelenkpunktion
- Röntgen, MRT

Therapie:

- Urikostatika : Allopurinol
- Normalisierung des Körpergewichts
- Colchicin

Fachbegriffe:

- Otitis media
- Somnolenz
- Intubation

- Anorexia nervosa
- Pankreatitis
- Drainage
- Appendektomie
- Neoplasma
- Gastroskopie
- Mandibel

22.07.2022 Zöliakie

Herr Hirschmann Gustav ist ein 44-jähriger Patient, der wegen seit mehr als 6 Monaten bestehender, fettiger Stuhlveränderungen und starker Gewichtsabnahme vorgestellt hat.

Die andere Beschwerden waren Blähungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Er hat viel über seinen Stuhl gesprochen. Er habe zwei mal am Tag fettiger Stuhl und es sei schwer, seinen Stuhl zu säubern.

Die Fragen nach Bauchschmerzen, Fieber, Trauma wurden verneint.

Ich habe erst gesagt, dass meine Verdachtsdiagnose kolorektales Karzinom ist. Meine erste DD war akute Pankreatitis.

Im Arzt-Arzt Gespräch, hat der Internist gefragt;

- warum ist Stuhl fettig? Ist das normal? Ich habe gesagt, dass Fett wahrscheinlich nicht verdaut werden kann.
- Warum? wegen Enzymemangel oder -probleme, Lipase-Amylase
- er hat gesagt, „so es gibt Probleme bei Malabsorption. Wissen Sie einige Malabsorptionerkrankungen? Ich habe Zöliakie gesagt, sie waren glücklich
- Was machen Sie denn? Transglutaminase IgA, gesamte IgA, Biopsie aus Duedonum
- Was erwarten Sie zu sehen? Zottenatrophie und Kryptenhyperplasie, nach dieser Antwort waren sie sehr glücklich,
- Was sind andere Laboruntersuchungen? Stuhlkultur, Hämoookkulttest

Fachbegriffe:

- Kardial
- Pleuritis
- Embolus
- Basaliom
- angiologisch
- Anaphlaktischer schock
- Subduralhämatom

26.07.2022 Depression

Fragen: Therapie und Verdachtsdiagnose. Kommission: nett

30.07.2022 Ösophaguskarzinom

Ich möchte meine Prüfungserfahrung mit euch teilen. Es gibt drei Prüfer, die einem gegenüber sitzen und man muss während des Gespräches keine Maske tragen. Sie überprüften meinen Lebenslauf und stellten einige allgemeine Fragen sowie eine kleine Vorstellung. Sie erklären dann alles über den Ablauf der Prüfung. Es gibt auch eine Uhr, die vor euch steht.

Meine Arzt-Patient Gespräch dauerte 18 Minuten. Der Patient war sehr kooperativ und ängstlich. Er fragte mich in der Mitte des Gesprächs nach der Verdachtsdiagnose und dem Namen der Untersuchung (ich bekam keine Fragen zur Aufklärung).

Ich machte einen Aussprachefehler des Medikaments, woraufhin der Patient das Wort wiederholte (ich sagte einfach, dass meine Aussprache nicht so gut ist und ich noch lerne und bedankte mich für die Korrektur). Ansonsten habe ich keine Fragen von dem Patienten bekommen. Während der Dokumentation schrieb ich Stichwörter zur Familienanamnese, Sozialanamnese, Allergie und Genussmittel auf. Ich konnte meine Dokumentation nicht innerhalb von 20 Minuten abschließen, ich habe nicht über diagnostische Maßnahmen und Therapie geschrieben, aber es war okay. Bei meinem Arzt-Arzt-Gespräch fragte er mich nur nach dem Hauptproblem und den Risikofaktoren des Patienten.

Er fragte nach einer Differenzialdiagnose, ich sagte GERD & Er fragte was gegen Ösophagitis spricht. Er fragte auch, welche diagnostischen Maßnahmen ich machen würde & ich antwortete, Endoskopie & dann fragte er, wie man die Größe des Tumors messen kann, ich schlug dann CT vor. Das war meine letzte Frage. Dieses Gespräch dauerte 8 Minuten & ich habe keine Aufklärungen bekommen. Meine Fachbegriffe waren Menstruation, lokalisiert, Osteoporose, kardial, Ovar, Palpation, Trachea. Ich erinnere mich nicht an andere Wörter.

18.08.2022 Pyelonephritis

vor 2 Tagen aufgetretener, bohrender, mit 7 von 10 starker, mit der Zeit verschlimmelter, dauerhafter Schmerzen in der Flankenregion auf der linken Seite ohne Ausstrahlung. gleichzeitig Fieber 39 brennendes Wasserlassen bräunliche, schäumige Harn, Harndrang.

Inappetenz keine Gewichtsverlust.

VE: COPD, DM

andere Anamnese sind nicht auffällig

Pat hat zu viel, über unwichtige Sachen gesprochen.

Arzt-Arzt Gespräch:

- Verdacht diagnose?
- DD?
- labor ? urinkultur!!!
- abgabe, wenn dem Pat nicht gut es geht, trotz abgabe. was machen wir ? Breitenspectrum abgabe.
- Komplikation: Urosepsis
- Welche Bakterien verursacht Pyelonephritis? E.coli
- welche abgeben? beta Laktam ab. welche ? Penicillin

Fachbegriffe: -12- Tinnitus Sepsis Exsikkose Noncompliance Meläna

18.08.2022 Pyelonephritis

79 Patient, akute, starke, linksseitige Flankenschmerzen ohne Ausstrahlung. Schmerzen seien stechend und aber auch dumpf (er hat fast alle Adjektive benutzt stechend -brennend-dump- heller Schmerz). Sie sind dauerhaft da und mit der Zeit schlimmer geworden. Die verstärken sich bei Bewegung. Außerdem habe er 39,3 Fieber, rektal, heute Morgen gemessen. Er habe gegen Beschwerden paracetamol und Ibuprofen eingenommen, mit geringem Ansprechen der Symptomatik. Er klagte auch über Ischurie, Dysurie, bräunlichen, schäumenden Urin mit „fischigem“ Geruch.

Er habe Inappetenz und Schlafstörungen, weil er in der Nacht häufig auf die Toilette gehen muss. (5-6 mal seit zwei Tagen mit geringem Urin, normalerweise geht er 1-2 mal)

Er habe DM-Typ 2 seit 20 Jahren, der mit Metformin 1000 (1-0-1) eingestellt und COPD, die mit Spiriva behandelt (2 mal am Tag und bei Bedarf)

Er habe Kribbeln an den Beinen (er hat das ganz am Ende gesagt, wenn ich Kribbeln oder Taubheitsgefühl am Körper nachgefragt habe. diabetische Neuropathie?) Das habe ich ganz am Ende gefragt und danach war der Patient etwas etwas unruhiger wegen Schmerzen, also Ende des Gesprächs - ich gebe gleich Analgetikum.

Raucher, seit 60 Jahren 20 Zigaretten pro Tag, Alkohol: 1 Glas Rotwein jeden Abend, kein Drogenkonsum

Seit 3 Jahren verwitwet, habe 2 gesunde Kinder Rentner, vorher Bauingenieur

Er habe dazwischen viel gesprochen. Man muss aufmerksam sein. Wenn er über Beschwerden gesprochen hat, hat er schon etwas über sein DM, Rauchen, Aufenthalt in einer Lungenklinik wegen COPD, Rauchen und Rotwein erzählt.

Verdacht auf Pyelonephritis und diabetische Nephropathie

DD: Urolithiasis, MI, Divertikulitis, Bandscheibenvorfall

Beim Arzt Arzt Gespräch hat er ohne Patientenvorstellung, direkt mit Fragen angefangen. Warum habe ich diesen Verdacht? Außer MI, wurde ich für jede Differenzialdiagnose auf dem Arztbrief gefragt, warum es in der DD List ist. Pyelonephritis Diagnose (Kultur fast vergessen) Was gebe ich Als Therapie? Welche Antibiotika? Schicke ich den Patienten nach Hause mit Rezept? (Nein) Erklären Sie bitte das zur Krankenversicherung warum. Patient hat Diabetes, Höher Risiko für Komplikationen und Untersuchungen wegen diabetischer Nephropathie. Welche Komplikationen? Abszess, akute Nierenversagen, Sepsis.

Fachbegriffe:

- Lobektomie
- Menopause
- epigastrisch
- Asthma
- Sepsis
- Lokalanästhesie
- Ulcus ventriculi

15.12.2022 Ösophaguskarzinom

15.12.2022 Appendizitis

15.12.2022 Grippe

Fachbegriffe:

- Cutis
- Flexion
- Tubargravidität
- kachektisch
- Nephritis
- Adaptation

26.01.2022 Wirbelfraktur aufgrund einer Osteoporose

DD: Wirbelfraktur , Bandscheibenvorfall

Patient: Reiner Züblin, 55 j.a., 1,83m, 81kg Allergie: Nüssenallergie

Noxen: 35py SA: Verwaltungsangestellte

FA: Vater: Apoplex (Halbseitenlähmung links)

Mutter: Osteoporose

Beschwerden:

- plötzlich aufgetretene Rückenschmerzen seit gestern nach einer Falshdrehung, im Verlauf schlimmer geworden
- 3-4/10
- keine Sensibilitätsstörung VA: Husten VE: -Oberschenkelfraktur, die mit Hüft-TEP behandelt wurde

-Osteoporose

-Z.n. Appendektomie als Kind

Medikamentenanamnese: Merformin 1000 mg 1-0-1 Ibuprofen b.B

Arzt- Arzt Gespräch

- Pt Vorstellung (ich habe nur die aktuelle Anamnese präsentiert)

Frage: handelt es sich um primär ou sekundär Osteoporose. Antwort: sekundär Osteoporose (Gründe: Alter des Patienten sowie das Geschlecht) Mögliche Ursache von sekundär Osteoporose und wie beständigen Sie das?

Antwort: Hyperparathyroidismus Bestimmung von Parathormon und Sonographie.

Gibt es noch etwas auszuschließen bei Rückenschmerzen v.a. bei Männer? Antwort: KHK , EKG wird geschrieben

Wie behandeln Sie den Patienten? : Antwort: Calcium, Vit D, Biphosphanate, körperliche Bewegung.

Fachbegriffe:

- Ulcus duodeni
- Endokarditis
- Cardia
- Linea anocutanea
- Exartikulation
- Reposition
- Humerusfraktur
- Hyperthyreose
- Adrenalektomie
- Rektumexstirpation

03.02.2022 Laktoseintoleranz

Fragen: Pathophysiologie der Laktoseintoleranz und wie kann man die Diagnose bestätigen.

Fachbegriffe:

- Urosepsis
- Hämatemesis
- letal
- toxisch
- Alkalisch
- Colitis ulcerosa
- Cholestase
- Ureter
- Zytostatika
- Malignom

[bestanden] *Quelle:* [Telegram](#)

08.11.2021 Depression

Herr Theo Heidenreich, 55 Jahre alt, 76 kg schwer, 167 cm groß kam heute zu uns wegen seit 10 Wochen aufgetretener, drückender, beidseitiger Cephalgie ohne Ausstrahlung. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen dauerhaft seien und Morgens immer schlimmer seien. Die Stärke der Schmerzen bewertete der Patient 7-8 von 10 auf der Skala. Darüber hinaus gab er an, dass der Tod der Schwester als die Auslöser der Beschwerden sei. Die Beschwerden seien von Nausea, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und depressive Stimmung begleitet.

Die **vegetative Anamnese** sei unauffällig bis auf Insomnie (Durchschlafstörung) und 2 kg Gewichtsabnahme innerhalb 3 Monaten.

Die Fragen nach Parästhesien, Paralyse, Hypästhesie, Sehstörungen, Schmerzen an anderer Körperregion, Husten, Tachykardie wurden verneint.

In der Anamnese der Vorerkrankungen fanden sich eine arterielle Hypertonie (behandelt mit Ramipril 20mg 1-0-0 und HCT 12.5mg 1-0-0).

Außerdem nehme er ein Benzodiazepinesderivat einmal täglich wegen der Schlafstörung ein (Ich erinnere mich nicht an den Namen).

Bei ihm sei vor 5 Jahren eine Appendektomie durchgeführt worden.

Herr Heidenreich rauche nicht, trinke 2 gläser Wein pro Woche und treibe keinen Sport.

Darüber hinaus berichtete die Patientin, dass sie keine Allergien oder unverträglichkeiten habe und ihr Impfausweis aktuell sei.

Bei der **Familienanamnese** sagte die Patientin, ihr Vater habe selbst umgebracht, die Mutter leide an einer Hypertonie und einer Herzinsuffizienz und die Schwester sei an Leukämie gestorben.

Die Patientin habe 2 gesunde Kinder.

Frau Heidenreich habe als Verkäuferin gearbeitet, aber sie ist jetzt arbeitslos, sei verheiratet und lebe mit ihrer Frau zusammen.

Als **Verdachtsdiagnose** stelle ich Depression.

Als **Differentialdiagnosen** kommen Multiple Sklerose, Migräne, Hypothyreose, VitB12 Mangel in Betracht.

Als weitere Prozedere empfehle ich folgende Untersuchungen:

- körperliche Untersuchung
- Blutabnahme (BB,CRP,BSG,fT3, fT4,TSH, VitB12)
- MRT des Schädels
- Psychiatrische Konsil veranlassen!

Patient-Arzt Gespräch

- Was habe ich ?
- Was werden Sie machen ?

Arzt-Arzt Gespräch

Ich habe die Patientin fast vollständig vorgestellt. Die fragen waren die folgenden:

- Können wir den Patienten entlassen?
- Was sollen wir tun, falls der Patient von 20 m sprung möchte?
- Was bedeute Abusus, falls der Patient täglich Schlafmittel einnimmt? Ich habe gesagt, ich glaube, wir müssen ihr eine psychische beratung empfehlen.

Er hat mir gesagt, dass das richtig ist, aber wir können sie nicht entlassen, weil Depression Patienten Suizidale Tendenzen haben können.

Dann habe ich einen Zettel mit 12 Fachbegriffen bekommen.

Keine Aufklärung. Am wichtigsten ist die Sprache. Die Kommission war sehr nett.

[bestanden] -[LanguageTool](#) -  *Quelle:* [Telegram](#)

17.09.2020 Gichtanfall

Name- Nobert Bethge Alter- 45 Jahre Gewicht- 114 kg Größe- 1.78m

Allergie- Keine Noxen: Nichtraucher 2-3 Bier täglich seit vielen Jahren Keine Drogen Er treibt keinen Sport

Sozialanamnese: Familienstand: verheiratet, 3 Kinder- 2 Söhne (1 Sohn hat Down-Syndrom), 1 Tochter Er lebt zusammen mit seiner Familie Arbeit- Schlösser von Beruf

Familienanamnese: Vater- an Kolonkarzinom verstorben Mutter- hatte viele chronische Krankheiten, sie verstarb 'beim Schlafen'

Aktuelle Beschwerden: Herr Bethge ist ein 45-jähriger Pt, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 2 Tagen klopfender stechender starker Schmerzen am linken Fuß besonders in der Hallux ohne Ausstrahlung vorgestellt hat.

Der Pt berichtete, dass die Schmerzen seit 2 Tagen plötzlich aufgetreten seien und sich im Laufe der Zeit verschlimmert hätten. Heute Nacht habe er wegen der Schmerzen aufgewacht. Er ordnete die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 8 ein. Die Schmerzen seien lageabhängig und beim Stehen/bei der Bewegung schlimmer und in Ruhe besser geworden. Er habe eine Tablette Ibuprofen gegen die Schmerzen genommen, was ihm eine leichte Besserung gab. Als Begleitsymptome nannte er Ödem, Erythem und Überwärmung der betroffenen Stelle.

Die Fragen nach Fieber, Verletzung sowie vorherigen ähnlichen Beschwerden wurde verneint. Als Vorerkrankung leidet er an arterieller Hypertonie und Migräne. Er erlitt eine Gehirnerschütterung (Commotio cerebri) wegen eines Motorradunfalls vor 25 Jahren. Die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie wegen der Schmerzen unauffällig. Er hat einen guten Appetit (besonders für Fleisch und fettiges Essen). Der Patient nimmt regelmäßig Bisoprolol 1-0-0 ein.

Die **Verdachtsdiagnose** lautet Gichtanfall (Podagra).

Als **Differentialdiagnosen** kommen Trauma, rheumatische Arthritis, septische Arthritis, pAVK, TVT.

Die weitere **Untersuchungen:**

- Vitalparameter messen
- Körperliche Untersuchung
- Labor- Blutbild, CRP, BSG, Harnsäure, Nierenwerte
- Röntgen des Fußes

Arzt- Arzt-Gespräch:

- Was hat Sie zur Diagnose von Gicht geführt?
- Welcher Laborparameter ist in Gicht wichtig?
- Was sind einige purinreiche Lebensmittel?
- Welche Änderungen des Lebensstils würden Sie empfehlen?
- Welche Behandlung würden Sie empfehlen?

Fachbegriffe: -12-

- Dens
- Agonie
- Commotio cerebri
- Auricula
- Commissura
- Cave
- Capitulum

- Apex cordis

[bestanden] -Quelle: [Approbations.info](https://www.approbations.info)

24.06.2020 Oberschenkelhalsfraktur

Lisele Müller 90 Jahre 50kg 155cm

Sie sei Ex-Raucherin seit 20 Jahren und früher habe sie 10 bis 20 Zigaretten pro Tag seit 40 Jahren.

Sie trinke ein Glas Sekt jeden Tag seit 10 Jahren und früher ein Glas Wein.

Der Drogenkonsum wurde verneint.

Sie sei verheiratet und habe 3 Töchter.

Die älteste habe Mama-Ca gehabt aber nach dem Behandlung mit Therapie sei sie gesund.

Sie sei Rentnerin.

(Frage nach Eltern habe ich nicht gestellt und am Ende hat der Oberarzt gesagt, dass ich sehr gut gemacht habe. Sie ist selbst 90 Jahre alt hat er gesagt und machte keine Sinn die Frage über Ihre Eltern stellen).

Sie habe eine Schwester aber sie wusste nicht wie ihr geht und lange Zeit nicht mehr mit ihr gesprochen.

Frau Müller ist 90 Jahre alt und stellt sich bei uns wegen seit Heute gestürzt vor. Sie berichtete, dass sie Heute Abend in der re Seite gestürzt sei und nachdem habe sie gleich Ihre Tochter angerufen. Die Tochter habe RTW angerufen und sie haben ins Krankenhaus gebracht. Zeitlich, örtlich, persönlich und situativ war sie orientiert. Sie habe keine Hämatome in der re Seite bemerkt. Auf Nachfrage wegen blutspuren auf dem Boden habe sie nicht bemerkt.

Frau Müller erwähnt, dass sie starken Schmerzen am den re Hüfte habe und kann nicht der Bein bewegen. Auf Nachfrage werde die Beschwerden auf der Schmerzskala bei 8 in Belastung und 0 in Ruhe eingestuft. Darüber hinaus seien der Patientin folgende Begleitsymptome aufgefallen Appetitlosigkeit und Müdigkeit.

Die **vegetative Anamnese** sei unauffällig.

An **Vorerkrankungen** leide sie an

- aHT seit 20 Jahren
- pAVK
- Hyperthyreose
- Chronische Bronchitis seit 40 Jahren Z.n IAM vor 15 Jahren Z.n Hernia Inguinalis vor 30 Jahren Z.n Unterschenkel Thrombose vor 15 Jahren Z.n Myokarditis vor 25 Jahren Z.n Glaukoma seit mehrere Jahren Z.n Handgelenk Fraktur li vor 15 Jahren

In Bezug auf **Medikation** nehme sie Ramipril 2.5 mg 1-0-1, Esomeprasol 20 mg 1-0-0 ,ASS 100 mg 1-0-0, L-Thyroxin 75 µg 1-0-0

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine auf symptomatische Oberschenkelhalsfraktur hin.

Differezdidiagnostisch kommen TIA ,Beckenfraktur in Betracht.

Zur weiteren Abklärung empfehle ich die folgenden **Maßnahmen**:

- Körperliche Untersuchung
- Labordiagnostik
- CT- Cranium
- Ekg
- Röntgen- Oberschenkel
- Röntgen- Becken

Der Prüfer haben mir am Ende gesagt, dass bei mir Mündlich teil besser als schriftliche Teil ist.

Ich bedanke mich ganz herzlich [Frau Schindler](#), dass sie mir viel geholfen habe. Wenn jemand echtes und Professionelle Hilfe braucht ist ganz einfach bei Frau Schindler anmelden. Sie kann sehr gut einschätzen ob du fertig für die Prüfung bist oder nicht.

Ich habe vergessen zu schreiben. Sie sei allergisch gegen Penicillin und Dipidolol

[bestanden] *Quelle:* [Approbations.info](#)

06.02.2020 Depression

Herr... ist ein 65-Jähriger Patient, der sich wegen seit 4 Wochen bestehender Schmerzen im Skapula und Nacken mit Ausstrahlung in Schläfe (ich wusste dieses Wort nicht) bei uns im Krankenhaus vorstellte. Die Schmerzen seien dauerhaft da und hätten eine Intensität von 6 bis 7 auf der Schmerzskala.

Er habe dagegen Ibuprofen und Parasetamol eingenommen aber das habe keine Verbesserung gemacht. Er klagte über Müdigkeit seit der Scheidung mit der Ehefrau. Er sei wegen dieser Beschwerden bei Orthopäde gewesen aber die Untersuchungen waren unauffällig.

Die Fragen nach Sensibilitätsstörung, Sehstörung, Lärmscheu, Lichtscheu, Übelkeit und Erbrechen wurden verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Durchschlafstörung wegen Schmerzen und Einschlafstörung wegen bestender Gedanken.

An **Vorerkrankungen** leide er an:

1. Arterielle Hypertonie, der seit 20 Jahren bei ihm bekannt aber nicht medikamentös eingestellt sei.
2. Benigne Prostatahypertrophie, der mit Prostagut eingestellt sei.
3. Hypercholesterinämie, der mit Sartan eingestellt sei.

In Bezug auf Medikation nehme er die folgende Medikamente ein:

1. Sartan (1 Tablette)
2. Prostagut 3).. 4).. (Ich habe die Dosis gefragt. Aber ob er Morgen/Mittags/Abends einnimmt habe ich vergessen zu fragen.)

Er sei Nichtraucher, trinke ab und zu Alkohol. Drogenkonsum würde verneint.

Die anamnestischen Angaben deuten am Ehesten auf Depression hin.

Als **Differenzialdiagnose** können die folgende in Betracht.

1. Diskus Prolapsus

2. Migräne
3. Hypothyreose

Zur weiteren Abklärung sollte die folgende Massnahmen durchgeführt werden.

1. KU
2. Labor
3. Polysomnographie

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlagen wir die folgende Therapie vor.

1. Antidepressivum
2. Psychotherapie
3. Lichttherapie

Der Patient hat gefragt:

1. Was habe ich?
2. Was werden Sie machen?

Der Chef hat gefragt

1. Was ist ihr Verdachtsdiagnose?
2. Was sind die Differenzialdiagnose?
3. Wie könnten Sie Discus Prolapsus ausschließen?
4. Könnte es nicht Rheumatische Erkrankung sein? (Hier hat er gesagt. Das die Schmerzen ganz lokalisiert sind. Wenn die Entzündungsparameter hoch sind, könnte es auch Polymyelitis Rheumatika sein.)
5. Können Sie dem Patient Mrt aufklären?

Fachbegriffe:

- Germinom
- Asepsis
- Pyelonephritis
- Hemiplegie
- Glaukom
- Gangran
- Asidoze

Ich hatte viel Stress während der Prüfung aber die Ärzten hatten schon Verständnis und waren ganz ganz nett.

Als Lernquelle habe ich Mahmoud, Schritt für Schritt und Protokolle gelesen.

In der letzten Zeit habe ich mit [Frau Schindler](#) Unterricht gemacht. Sie ist auch ganz nett. Es ist aber ratsam erst allein zu lernen und danach eure Fehler mit Frau Schindler zu korrigieren. Sie gab mir viele Strategie und wie ich mich auf die Prüfung vorbereitet soll.

[bestanden] *Quelle:* [Approbations.info](#)

29.01.2020 Depression

Herr X ist ein 32-jähriger Patient, der sich bei uns aufgrund seit 4-5 Jahren bestehender anhaltender Gliederschmerzen vorgestellt hat. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen im ganzen Körper befindlich seien und am frühen Morgen am schlimmsten seien. Diese würden sich im Verlauf des Tages erleichtern. Weiterhin klagte der Patient, an Antriebslosigkeit und Interessensverlust zu leiden. Der Patient gab an, er habe darüber hinaus Beeinträchtigung der Sehkraft und Schwerhörigkeiten seit einigen Monaten bemerkt, welche schwankend auftreten würden. Als begleitende Symptome berichtete er über Störungen sowohl bei Ein- sowie bei Durchschlafen und Appetitlosigkeit. Es bestehe zudem eine Abgeschlagenheit. Gewichtsveränderungen, Suizidgedanken sowie Suizidhandlungen, Missempfindungen und Kraftverlust wurden verneint. Der Patient sei aufgrund der o.g. Symptome mehrmals bei dem Hausarzt vorstellig gewesen. Die verschriebene Medikamente hätten aber zu keiner Besserung der Beschwerden geführt. Außerdem sei vor einigen Jahren ein bildgebendes Verfahren zum Ausschluss von MS durchgeführt worden (MRT ?), deren Befunde unauffällig gewesen seien.

Keine Vorerkrankungen seien bei dem Patienten bekannt.

Keine Voroperationen. Medikamente nehme er aktuell keine. Bei dem Patienten sei eine Pollenallergie bekannt. Es bestehe kein Konsum von weder Alkohol noch Nikotin. Familienanamnestisch ergab sich Depression mütterlicherseits. Sein Vater sei gesund sowie zwei Geschwister. Der Patient habe das Studium vor einigen Jahren abgebrochen. Er ist ledig und hat keine Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten a.e. auf Depression hin.

Differentialdiagnostisch kommen die folgenden Krankheiten in Betracht:

- Dystimie
- Psychoaffektive Störung
- Anämie
- Hypothyreose
- MS ?

Zur weiteren Abklärung führe ich die folgenden **Maßnahmen** durch:

- körperliche Untersuchung
- Blutbild, TSH, T3, T4, Ferritin, B12, Entzündungsparameter
- ggf. MRT

ARZT-ARZT

- (der Neurologe hat mir alle Fragen gestellt, die anderen haben nur zugehört)
- Warum denken Sie an Depression?
- Welche anderen Krankheiten können die Symptome des Patienten verursachen?
- Können alle die Symptome des Patienten nur durch Depression abgeklärt werden?
- Welche Untersuchungsmethoden kommen zum Einsatz?
- Was erwarten Sie von den Laboruntersuchungen?
- Würden Sie bei diesem Patienten ein MRT veranlassen?

Fachbegriffe:

- Somnolenz
- Appendektomie

- Mandibula
- Intubation
- Inzision
- Drainage
- Pankreatitis
- Otitis media

[bestanden] *Quelle:* [Approbations.info](https://www.approbations.info)

Fachbegriffe Karlsruhe

- Diese Liste umfasst alle die Fachbegriffe, die in den Protokollen aus Karlsruhe bis **September 2023** vorkommen sind.
- Es gibt eine **"Skala der Häufigkeit"**. Die Skala beginnt mit einem Mindestwert von 1 und erhöht sich, je häufiger die Wörter in der FSP vorkommen. Zum Beispiel:
 - *Anxiolyse*= 1
 - *Sepsis*= 4

Das bedeutet das "Sepsis" kam in Karlsruhe viermal in der Protokolle vor, im Vergleich zu „Anxiolyse“, das nur einmal vorkam. Natürlich ist das Wort „Sepsis“ in Karlsruhe sehr gefragt und wichtiger als "Anxiolyse".
Fazit: Wörter mit einer höheren Zahl auf der Skala sind wichtiger für die FSP in dieser Stadt.

Abkürzungen:

- poly. = polyseme Begriffe (ein Wort mit mehreren, verschiedenen Bedeutungen) werden mit arabischen Ziffern durchnummeriert.
 - Sterilität (*poly.*) = 1. Keimfreiheit / 1. Unfruchtbarkeit

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
2	Abdomen	Bauch
1	Abort	Fehlgeburt
1	Abusus	Missbrauch (Alkohol, Drogen, Medikamente,Tabak)
1	Acetabulum	Hüftgelenkspfanne
2	Adaptation	Anpassung
1	Adhäsion	Verwachsung (von Geweben)
1	Adipositas	Fettleibigkeit
1	Adrenalektomie	operative Entfernung einer oder beider Nebennieren
2	Agonie	Todeskampf
1	Albumin	Eiweißstoff

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	alkalisch	basisch, laugenhaft
2	analgetisch	schmerzstillend
1	Analgetikum	Schmerzmittel
1	Analosphinkter	Schließmuskel des Afters
1	Anämie	Blutarmut, Erythrozytenmangel
1	anaphylaktischer Schock	lebensbedrohliche allergische Reaktion
1	Aneurysma	umschriebene Erweiterung einer Schlagader
1	Angiografie	Röntgenuntersuchung der Gefäße
1	angiologisch	die Blutgefäßen betreffend
1	Angulus	Winkel
1	Antipyretika	fiebersenkende Medikamente
3	Anorexia nervosa	Magersucht
1	Aorten-Aneurysma	Erweiterung der Hauptschlagader
1	Anxiolyse	Beseitigung nervöser Unruhe (durch Medikamente)
2	Apex cordis	Herzspitze
1	Apoplex	Schlaganfall
2	Appendektomie	operative Entfernung des Wurmfortsatzes
1	Arteria poplitea	Kniekehlschlagader
1	Arthritis urica	Gicht
2	Asepsis	Keimfreiheit, Sterilität
1	Aspiration	1. Ansaugen, 2. Fremdstoffeinatmung
1	Asthma	anfallsweise auftretende Atemnot
3	Aszites	Bauchödem, Flüssigkeitsansammlung in der freien Bauchhöhle
3	Atrophie	Schwund
1	Auricula	1. Ohrmuschel 2. Ohrläppchen
1	Auricula auris	Ohrmuschel
2	Azidose	Übersäuerung von Blut und Geweben
5	Basaliom	Krebserkrankung der Haut
1	benigne	gutartig

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Bluttransfusion	Blutübertragung
1	Brachialgie	Oberarmschmerzen
1	Bursitis	Schleimbeutelentzündung
2	Capitulum	Knochenkopf, Gelenkköpfchen
1	Cardia	Mageneingang, Magenmund
1	Carotisstenose	Verengung der Halsschlagadern
2	cave!	„Vorsicht!“, „vermeide!“
1	Cavum	Höhle, Hohlraum
1	Cerebrum	Gehirn
1	chronisch	langdauernd, langsam verlaufend
2	Cholangitis	Entzündung der Gallenwege
1	Cholestase	Gallestauung
1	Claudicatio intermittens	Schaufensterkrankheit
1	Clavicula	Schlüsselbein
1	Cochlea	Hörschnecke
1	Colitis ulcerosa	Entzündung des Dickdarms mit Geschwürbildung
1	Colon	Dickdarm
1	Colon irritabile	Reizdarmsyndrom
2	Commissura	Verbindung zwischen Weichteilen im Bereich der Organe
2	Commotio cerebri	Gehirnerschütterung
1	Compliance	Kooperation des Kranken
4	Cutis	Haut
1	Defibrillator	Gerät zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
2	Dehydration	der Entzug von Wasser
3	Dekubitus	Druckgeschwür
1	Demenz	erworbene Geistesschwäche
2	Dens	Zahn
1	Dermatose	Hautkrankheit
1	Dialyse	Blutwäsche

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Diarrhö	Durchfall
3	Distorsion	Verstauchung, Zerrung eines Gelenks
1	Dorsal	rückseitig
1	dorsobasal	hinten und unten
2	Drainage	bei einer Operation eingelegter Schlauch zur Ableitung von Wundsekret
1	Ductus choledochus	Hauptgallengang
1	Duplikatur	Verdoppelung
1	duplex	doppelt
1	Dysarthrie	mühsames Sprechen, Stammeln, Stottern
2	Dyspnoe	Atemnot
1	Ejakulation	Samenerguss
1	Ekzem	Juckflechte
3	Embolus	Blutgefäßpfropf
2	Endokarditis	Entzündung der Herzinnenhaut
1	epigastrisch	den Oberbauch betreffend, im Oberbauch liegend
1	Episiotomie	Dammschnitt
1	Exartikulation	operatives Entfernen eines Körperteils im Gelenk
1	exsikkiert	ausgetrocknet
1	Exsikkose	Austrocknung
1	Femur	Oberschenkelknochen
1	Femurfraktur	Knochenbruch des Oberschenkelknochens
1	Fibrose	Vermehrung von Bindegewebe
1	Flexion	Beugung
1	Flexur	Biegung
1	Fragmentum	Bruchstück (z. B. Knochenbruchstück)
1	Gangrän	Zerfall des Gewebes
1	Gastrektomie	operative Entfernung des Magens
1	gastroenterologisch	den Magen und Darm betreffend
1	Gastroskopie	Magenspiegelung

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
2	Gastrostomie	Anlegung einer Magenfistel
1	genu	Knie
2	Germinom	bösartiger Tumor des Keimgewebes
1	Glandula	Drüse
2	Glaukom	grüner Star
3	Gonarthrose	degenerative Erkrankung des Kniegelenks
1	Gravidität	Schwangerschaft
1	Halluzination	Sinnestäuschung
1	Hämatemesis	Bluterbrechen
1	Hämatom	Bluterguss
1	Hemiparese	Halbseitenlähmung
1	Hemiplegie	halbseitige Lähmung, einseitige Körperlähmung
1	Hepatitis	Leberentzündung
1	Hernia umbilicalis	Nabelbruch
1	Hodentorsion	Hodenverdrehung
1	Humerus	Oberarmknochen
2	Humerusfraktur	Oberarmbruch
1	Hypalgesie	verminderte Schmerzempfindlichkeit
1	Hyperkapnie	erhöhter Kohlendioxidgehalt des Blutes
1	Hypercholesterinämie	erhöhter Cholesterinspiegel im Blut
2	Hyperkaliämie	erhöhter Kaliumgehalt des Blutes
1	Hyperthyreose	Überfunktion der Schilddrüse
1	Ikterus	Gelbsucht
2	Ileus	Darmverschluss
1	Induration	Verhärtung
3	Inkontinenz	Unvermögen, Harn oder Stuhl zurückzuhalten
1	Inhaler	Gerät, das der Einatmung von etwas dient
3	inhalieren	einatmen
2	interkostal	zwischen den Rippen

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	intrazerebrale Blutung	Einblutung in das Hirngewebe
3	Intoxikation	Vergiftung
2	Intraokular	im Auge
2	Intubation	Einführen eines Beatmungsschlauchs in die Luftröhre
2	Inzision	Einschnitt
3	kachektisch	extrem abgemagert
2	kardial	das Herz betreffend
1	Kardiomegalie	Herzvergrößerung
1	karzinogen	krebserzeugend
1	Karenz	Entbehrung, Verzicht (z. B. auf Nahrungsmittel überhaupt oder auf bestimmte Nahrungsmittel)
1	Katarakt	grauer Star
1	Kehlkopf	Larynx
1	Kolektomie	operative Dickdarmentfernung
1	kongenital	angeboren
1	Konjunktivitis	Bindehautentzündung des Auges
1	Kontraktion	Zusammenziehung
1	Kryochirurgie	Kältechirurgie
1	Lobus	Lappen, Teil eines Organs
2	Laryngitis	Kehlkopfentzündung
1	Larynx	Kehlkopf
1	Laxativum	Abführmittel
1	letal	tödlich
3	Letalität	Tödlichkeit einer Erkrankung
1	Ligament	Band
1	Linea anocutanea	untere Grenze des Analkanals
1	Liquor	Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit
2	Lobektomie	operative Entfernung eines Organlappens (z. B. eines Lungenlappens)
1	Lobulus	Läppchen, Teil eines Organs oder einer Drüse

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Logopädie	Sprachtherapie
1	Lokalanästhesie	örtliche Betäubung
1	Lungenatelektase	nicht mit Luft gefüllte Lungenabschnitte
1	Makroglossie	Vergrößerung der Zunge
2	maligne	bösartig
3	Malignom	bösartige Tumor
1	Malrotation	
1	Mandibel	Unterkiefer
2	Mandibula	Unterkiefer
1	Mastektomie	Brustamputation
2	medial	zur Mitte hin
2	Meläna	durch Blut schwarz gefärbter Stuhl
1	Meningitis	Hirnhautentzündung
3	Menopause	Aufhören der Regelblutung in den Wechseljahren
3	metabolisch	stoffwechselbedingt
1	Multimorbidität	Mehrfacherkrankung, gleichzeitiges Bestehen mehrerer Krankheiten bei einem Patienten
1	Muskelatrophie	Muskelschwund
2	Myokarditis	Herzmuskelentzündung
1	Myopie	Kurzsichtigkeit
1	Neoplasie	Gewebeneubildung (oft im Sinne der Bildung einer bösartigen Geschwulst)
1	Neoplasma	Gewebeneubildung
1	Nephrektomie	operative Entfernung einer Niere
3	Nephritis	Nierenentzündung
1	Noncompliance (engl.)	Nichteinhaltung
3	Obstipation	Verstopfung
1	Ödem	krankhafte Flüssigkeitsansammlung im Gewebe
1	okzipital	zum Hinterhaupt gehörend
2	Ösophagus	Speiseröhre

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Os coccygis	Steißbein
2	Os pubis	Schambein
1	Osteosynthese	operatives Zusammenfügen von Knochenbruchstücken
1	Otitis externa	Ohrenentzündung im äußeren Gehörgang
3	Otitis media	Mittelohrentzündung
3	palliative Therapie	lindernde Behandlung (ohne zu heilen)
2	Palpation	Untersuchung durch Betasten
2	Pankreas	Bauchspeicheldrüse
3	Pankreatitis	Bauchspeicheldrüsenentzündung
1	Perikarditis	Herzbeutelentzündung
1	Perfusion	Durchströmung
5	Pertussis	Keuchhusten
1	Phimose	Verengung der Vorhaut
1	Placeboeffekt	Wirkung eines Medikaments ohne Wirkstoff
2	Pleuritis	Brustfellentzündung, Rippenfellentzündung
1	Pneumektomie	operative Entfernung eines Lungenflügels
1	Pneumonie	Lungenentzündung
3	präventiv	vorbeugend
1	Prostatitis	Entzündung der Vorsteherdrüse
5	Pulmo	Lunge
2	Pyelonephritis	Entzündung von Nierenbecken und Nieren
2	Radiatio	Bestrahlung
1	Rektumexstirpation	Entfernung des Mastdarmes inklusive des Sphinkterapparates
1	Reposition	Wiedereinrichtung von Knochenbrüchen
2	resezieren	operativ entfernen
1	Retina	Netzhaut des Auges
3	Rezidiv	Rückfall, erneuter Krankheitsausbruch
1	rezidivierend	wiederkehrend
1	Rhagade	Einriss in der Haut
1	Sedativa	Beruhigungsmittel

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Sensibilität	Empfindlichkeit
4	Sepsis	Blutvergiftung
2	Sinus maxillaris	Kieferhöhle
2	Somnolenz	krankhafte Schläfrigkeit
1	Spatium	Zwischenraum
1	Spina bifida	Spaltung der Wirbelsäule
1	Spinalstenose	eine Einengung des Wirbelkanals
4	Splenektomie	operative Entfernung der Milz
1	Stenose	Verengung
1	STIKO	St ändige I mpf k ommission
1	Struma	Kropf, Schilddrüsenvergrößerung
1	Subduralhämatom	Einblutung in den Subduralraum des Schädels
1	Sugillation	oberflächlicher Bluterguss
1	Thrombektomie	operative Entfernung eines Blutpfropfs aus einem Blutgefäß
3	Thyreoidea	Schilddrüse
1	Thyreoidektomie	operative Entfernung der Schilddrüse
3	Tibia	Schienbein
1	Tinnitus	Klingeln oder Pfeifen in den Ohren
1	Tonsillitis purulenta	eiternde Mandelentzündung
1	toxisch	giftig
2	Trachea	Luftröhre
2	Tubargravidität	Eileiterschwangerschaft
2	Ulcus ventriculi	Magengeschwür
1	Ulcus cruris	Unterschenkelgeschwür
1	Ulcus duodeni	Zwölffingerdarmgeschwür
1	Ureter	Harnleiter
3	Urosepsis	durch eine Entzündung der Harnwege hervorgerufene Blutvergiftung
1	Valva aortae	Aortenklappe
1	Varizelle	Windpocke

Häufigkeit	Fachbegriff	Umgangssprache
1	Vasculitis	Gefäßentzündung
1	Vena cava inferior	untere Hohlvene
1	Vena pulmonalis	Lungenvene, Blutader der Lunge
1	Veneninsuffizienz	mangelhafte Funktion der Blutadern
1	Volvulus	Darmverschlingung
2	Zyste	mit Flüssigkeit gefüllte Geschwulst
1	Zytostatika	Medikamente zur Krebsbehandlung

ACHTUNG: Die neuen Fachbegriffe ab Oktober 2023 sind nicht in dieser Tabelle, aber sie sind verfügbar als "Anki-Karten" (siehe unten!)

"Spaced Repetition" für die FSP

Die letzten Fachbegriffe sind verfügbar als Karten für [Anki](#).

Das Buch "Grundwortschatz für Pflegeberufe" von Richard Strack ist auch verfügbar als Anki-Karten. Die Ärztekammer empfiehlt dieses Buch für die FSP in Baden-Württemberg.

DOWNLOAD: [Telegram-Kanal @ProtokolleBW](#)

Literatur für die FSP

Website: [Anna's Archive](#).

1. [Deutsch für Mediziner - Ina Maria Koetz](#)
2. [Deutsch für Ärztinnen und Ärzte - Ulrike Schrimpf](#)
3. [Fachsprachprüfung - erfolgreich bestehen - Stefania-Cristina Rogoveanu](#)
4. [Fit für die Fachsprachprüfung in nur 1 Woche - Rosa von Trautheim](#)
5. [Diagnose? Deutsch!: Fachsprache Medizin](#)
6. [Trainingseinheiten Deutsch B2·C1 Medizin Teilnehmerbuch](#)
7. [Kommunikation im Gesundheitswesen - Heike Hoos-Leistner](#)

Fachbegriffe:

1. [Grundwortschatz für Pflegeberufe - Richard Strack](#)
2. [Medizinische Terminologie - Wolfgang Caspar](#)
3. [Fachsprache Medizin im Schnellkurs - Axel Karenberg](#)

Grammatik

1. [Hammer's German Grammar and Usage - Martin Durrell](#)
2. [Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten - Matthias Granzow-Emden](#)

3. [Handbuch Deutsch als Fremdsprache - Axel Vielau](#)
4. [Handbuch der deutschen Grammatik - Elke Hentschel](#)
5. [Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen - Roland Schäfer](#)
6. [Duden - Die Grammatik](#)
7. [PONS Die große Grammatik Deutsch](#)
8. [Zeichensetzung klipp & klar - Renate Baudusch](#)
9. [Grundriss der deutschen Grammatik: Band 1: Das Wort - Peter Eisenberg](#)
10. [Grundriss der deutschen Grammatik: Band 2: Der Satz - Peter Eisenberg](#)

Phonetik

1. [Modern German Pronunciation. Christopher Hall - Manchester University 2003](#)
2. [German Phonetics and Phonology -Yale University \(2016\)](#)

Sonstiges

1. [What do you need to know to learn a foreign language? Paul Nation](#)
2. [How Vocabulary Is Learned - Paul Nation](#)

Wörterbücher:

[Goldendict-ng](#) ist die beste Software, um Wörter in einem Wörterbücher nachzuschlagen. Die Software ist effizienter als Online-Wörterbücher (z.B. Duden).

[FreemDict Forum](#) bietet mehr als 100 einsprachige deutsche Wörterbücher für Goldendict an. Die Sammlung umfasst auch zweisprachige Wörterbücher (Deutsch><Russisch, Deutsch><English usw.) und Aussprachewörterbücher (Forvo, Wiktionary Audios usw.).

Podcasts für die FSP

Das Hörverstehen ist sehr wichtig für die Fachsprachprüfung. Folgende Podcasts sind empfehlenswert:

1. [Amboss Podcast](#)
2. [Ärztetag](#)
3. [Ärztetag Extra](#)
4. [Der Springer Medizin](#)
5. [PRIMO MEDICO Fachärzte Talk](#)
6. [Evidenz-Update mit DEGAM-Präsident Martin Scherer](#)
7. [Abenteuer Diagnose](#)
8. [Sprechende Medizin](#)
9. [Notaufnahme - der Podcast von Ärzte ohne Grenzen](#)
10. [Ein Professor fürs Herz - Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg](#)
11. [Sprechstunde - Deutschlandfunk](#)
12. [Fasttrack - Der Notfallpodcast](#)
13. [Grams' Sprechstunde – Der Podcast für echt gute Medizin](#)
14. [Medizin & Menschen - der Audio-Podcast des Leopoldina-Krankenhauses](#)
15. [Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin](#)
16. [Medizin im Alltag](#)
17. [Gesundheitsmarkt-Podcast](#)

18. [E-Health Pioneers | Der Business Podcast für den digitalen Gesundheitsmarkt](#)
19. [FAZ Gesundheit](#)
20. [Ne Dosis Wissen | Der Medizin-Podcast für Menschen im Gesundheitswesen](#)
21. [NDR 1 Niedersachsen Visite - Das Gesundheitsmagazin](#)
22. [Ist das noch gesund? – Der Gesundheitspodcast der Techniker](#)
23. [Die Diagnose](#)
24. [docsdigital - Der Podcast für innovative Ärztinnen und Ärzte & Healthtech](#)
25. [PZ-Nachgefragt - für die Apotheke](#)
26. [Bis der Arzt kommt - der Recruiting-Podcast von ÄRZTESTELLEN](#)
27. [Businessdoc - Arzt als Unternehmer](#)
28. [Ab zur Aufnahme - Fragen bis der Arzt geht](#)
29. [O-Ton Allgemeindenmedizin: Podcast für die Arztpraxis](#)
30. [O-Ton Onkologie](#)
31. [O-Ton Diabetologie](#)
32. [O-Ton Innere Medizin](#)
33. [Dr. Anne Fleck - Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE](#)
34. [Frag dich fit – mit Doc Esser und Anne](#)
35. [GESUNDHEIT KANNST DU LERNEN](#)
36. [Hand, Fuß, Mund](#)
37. [MediTalk - Medizin für dich erklärt mit Frau Dr. Steidl](#)
38. [HörBesuch - Der Hausarzt-Podcast](#)
39. [Auf Herz und Nieren - der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten](#)
40. [Auf Herz und Nieren – Gesundheit, Ernährung & Fitness to go](#)
41. [Auf Herz & Ohren mit Doc Caro](#)
42. [MDR SACHSEN Hausarztsprechstunde](#)
43. [Von Achtsam bis Zuckerfrei – Der Gesundheits-Podcast der Audi BKK](#)
44. [Podcast Viszeralmedizin](#)
45. [Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker](#)
46. [Intensivtalk – von Medizinerinnen für Mediziner](#)
47. [Fach-Podcasts zu Mikrobiom und Schleimhaut](#)
48. [Surgeon Talk](#)
49. [Young Urban Anesthesiologists](#)
50. [Die Martha-Maria SPRECHstunde](#)
51. [Neues aus der Uniklinik Freiburg](#)
52. [Martini-Klinik Prostata POM Talk](#)
53. [Wir sind Klinik - Hirslanden Klinik Im Park](#)
54. [Anae-Doc: Anästhesie, Intensiv und Notfallmedizin](#)
55. [Medizin to go - Städtisches Klinikum Dresden](#)
56. [Audio Nursing - Der Pflegewissen-Podcast](#)
57. [Die KRH Patientenakademie](#)
58. [Bitte freimachen!](#)
59. [Gesundheit Lippe](#)
60. [KKM - Podcast](#)
61. [Spotlight auf Krebs](#)
62. [Der KRH Podcast](#)
63. [Bürgervorlesung am Uni-Klinikum Erlangen](#)

64. [Hörgang](#)
65. [Ist das gesund? Der Medizinpodcast der Kleinen Zeitung](#)
66. [Sprechstunde am Uniklinikum](#)
67. [Radio 1 - Sprechstunde](#)
68. [Meyer trifft Mediziner](#)
69. [USZ Direkt](#)
70. [EMH Journal Club](#)
71. [NZZ Akzent](#)
72. [NZZ Megahertz](#)
73. [Echo der Zeit](#)

Um alle Podcasts zu abonnieren, laden Sie diese [OPML-Datei](#) herunter. Dann importieren Sie die OPML-Datei in einer Podcast-Software (z. B. [Antennapod](#)).

Feedback und Diskussion

Telegram-Gruppe: <https://t.me/fspb Badenwuttemberg>

- Vorschläge zur Verbesserung des Dokuments sind willkommen.
- Bitte teilen Sie ein Protokoll.
- **Autoren:** *Telegram:* [@Linux](#), [@oussdoc](#)
- Lizenz: GPLv3 [Frei]

[Information wants to be free](#)

